

[صورة غلاف الكتاب الرئيسية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 4:3 · تُضاف لاحقاً

BetterDiagnosis

دليل فني الصيدلية

الكتاب الميداني للعمل في الصيدلية من اليوم الأول

الإصدار 0.1 · BetterDiagnosis © 2024

الفهرس

TABLE OF CONTENTS

المتطلبات الأساسية

القسم الأول

01	المصطلحات الطبية
02	تصنيفات الأدوية
03	المضادات الحيوية
04	المسكنات ومضادات الالتهاب
05	أدوية القلب والأوعية
06	الأشكال الصيدلانية
07	قراءة الوصفة الطبية
08	أسماء الأدوية الشائعة

المحتوى الرئيسي — السيناريوهات

القسم الثاني

01	الجهاز العصبي والألم
02	القلب والأوعية الدموية
03	الأمراض المزمنة والأعراض
04	الجهاز التنفسي والحساسية
05	العيون والأذن والأنف
06	الجهاز الهضمي والكبد
07	المضادات الميكروبية
08	الأدوية الحيوية والحقن
09	الجلد والعناية الموضعية
10	الفيتامينات والمكملات

11 صحة المرأة والأطفال

12 الإسعافات الأولية والطوارئ

القسم الثالث

الأقسام الإضافية

01 التفاعلات الدوائية

02 قراءة نتائج التحاليل

03 التخزين وإدارة المخزون

04 المريض المسن في الصيدلية

05 الصيام والأدوية

القسم الأول

المتطلبات الأساسية

المصطلحات الطبية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: المصطلحات الطبية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

لماذا هذا الملف أول شيء؟

لأن المصطلح الطبي ليس كلمة عشوائية — هو جملة مضغوطة. من يفهم البنية يفهم المعنى تلقائياً حتى لو رأى الكلمة للمرة الأولى.

1. بنية المصطلح الطبي

كل مصطلح طبي تقريباً مكوّن من ثلاثة عناصر:

[Suffix لاحقة] + [Root جذر] + [Prefix بادئة]

مثال:

gastro + enter + itis

معدة أمعاء التهاب

= Gastroenteritis = التهاب المعدة والأمعاء =

2. البادئات الأكثر تكراراً

البادئة	المعنى	مثال
anti-	ضد	antibiotic = ضد الحياة (البكتيريا)
hyper-	فوق الطبيعي / زيادة	hypertension = ضغط مرتفع
hypo-	تحت الطبيعي / نقص	hypoglycemia = انخفاض السكر
brady-	بطيء	bradycardia = بطء ضربات القلب
tachy-	سريع	tachycardia = سرعة ضربات القلب
dys-	صعوبة / اضطراب	dyspnea = صعوبة التنفس
a- / an-	غياب / بدون	anemia = فقر الدم
brady-	بطيء	bradycardia = بطء نبضات القلب
poly-	كثير / متعدد	polypharmacy = تعدد الأدوية
mono-	واحد	monotherapy = علاج أحادي
sub-	تحت	sublingual = تحت اللسان
trans-	عبر	transdermal = عبر الجلد
intra-	داخل	intravenous = داخل الوريد
inter-	بين	intermittent = متقطع
peri-	حول	pericarditis = التهاب غلاف القلب
pre-	قبل	preoperative = قبل الجراحة
post-	بعد	postoperative = بعد الجراحة
neo-	جديد	neonatal = حديثي الولادة
micro-	صغير	microbial = ميكروبي
macro-	كبير	macrocyte = خلية دم كبيرة

3. الجذور حسب أعضاء الجسم

العضو	الجذر اللاتيني/اليوناني	مثال
القلب	cardi-	cardiotoxic ,cardiology
الأوعية الدموية	angio- / vascul-	angioplasty ,cardiovascular
الرئة	pneum- / pulmon-	pneumonia ,pulmonary
الكبد	hepat-	hepatotoxic ,hepatitis
الكلية	neph- / ren-	nephrology ,renal
المعدة	gastr-	gastritis ,gastric
الأمعاء	col- / enter-	colitis ,enteritis
الجلد	derm-	dermatitis ,dermatology
العظام	oste-	osteoarthritis ,osteoporosis
المفاصل	arthr-	arthralgia ,arthritis
الدم	hemat- / hem-	hemophilia ,hematology
الأعصاب	neur-	neuropathy ,neurology
الدماغ	encephal- / cerebr-	encephalitis ,cerebral
العين	ocul- / ophthalm-	ocular ,ophthalmology
الأنف	rhin-	rhinorrhea ,rhinitis
الأذن	ot-	otology ,otitis
الحلق	laryng- / pharyng-	laryngitis ,pharyngitis
المصدر	pector- / thorac-	pectoris ,thoracic
الرحم	uter- / hyster-	uterine ,hysterectomy

4. اللواحق الأكثر أهمية لفني الصيدلية

لواحق الأمراض

اللاحقة	المعنى	مثال
-itis	التهاب	gastritis ,hepatitis
-osis	حالة / تليّف / تراكم	cirrhosis ,fibrosis
-emia	في الدم	bacteremia ,anemia
-uria	في البول	hematuria ,glycosuria
-algia	ألم	myalgia ,neuralgia
-pathy	مرض / اضطراب	nephropathy ,neuropathy
-megaly	تضخم	splenomegaly ,hepatomegaly
-rrhea	تدفق / إفراز	rhinorrhea ,diarrhea
-plegia	شلل	paraplegia ,hemiplegia
-trophy	نمو / تغذية	atrophy ,hypertrophy

لواحق الأدوية — مهمة جداً لغني الصيدلية

اللاحقة	فئة الدواء	أمثلة
-cillin	بنسلينات	ampicillin ,amoxicillin
-cycline	تتراسيكلينات	tetracycline ,doxycycline
-mycin / -micin	أمينوغليكوزيدات أو ماکروليدات	azithromycin ,gentamicin
-oxacin / -floxacin	فلوروکینولونات	levofloxacin ,ciprofloxacin
-azole	مضادات فطرية أو بروتون بمب	omeprazole ,fluconazole
-olol	حاصرات بيتا	propranolol ,metoprolol ,atenolol
-pril	مثبطات ACE	captopril ,lisinopril ,enalapril
-sartan	حاصرات ARB	irbesartan ,valsartan ,losartan
-vastatin	ستاتينات	simvastatin ,atorvastatin
-dipine	حاصرات قنوات الكالسيوم	nifedipine ,amlodipine
-pam / -lam	بنزوديازيبينات	,alprazolam ,diazepam clonazepam
-tidine	حاصرات H2	famotidine ,ranitidine
-mab	أجسام مضادة وحيدة النسيلة	rituximab ,adalimumab
-nib	مثبطات كيناز	erlotinib ,imatinib
-gliptin	مثبطات (DPP-4 سكري)	saxagliptin ,sitagliptin
-formin	بيغوانيدات (سكري)	metformin
-oxetine	مثبطات استرداد السيروتونين	paroxetine ,fluoxetine
-triptan	مضادات الصاع النصفي	rizatriptan ,sumatriptan

📌 القاعدة الذهبية: إذا رأيت اسماً دوائياً لا تعرفه، انظر للاحقة أولاً. ستعرف فئته فوراً.

5. المصطلحات السريرية اليومية في الصيدلية

الجرعة والتكرار

المصطلح	المعنى
Loading dose	جرعة تحميل أولية عالية لتحقيق تركيز سريع
Maintenance dose	الجرعة المستمرة للحفاظ على التركيز
(pro re nata)PRN	عند الحاجة — لا جدول ثابت
QD / OD	مرة واحدة يومياً
BID	مرتان يومياً
TID	ثلاث مرات يومياً
QID	أربع مرات يومياً
Q8H / Q12H	كل 8 أو 12 ساعة
(hora somni)HS	عند النوم
(ante cibum)AC	قبل الأكل
(post cibum)PC	بعد الأكل

مصطلحات الفارماكولوجيا الأساسية

المصطلح	التعريف البسيط
($t_{1/2}$ Half-life)	الوقت اللازم لانخفاض تركيز الدواء في الدم إلى النصف
Bioavailability	النسبة التي تصل فعلاً إلى الدورة الدموية من الجرعة المأخوذة
Onset of action	الوقت حتى يبدأ الدواء في العمل
Peak effect	الوقت الذي يصل فيه الدواء لأعلى تأثير
Duration of action	كم يستمر تأثير الدواء
Contraindication	موانع الاستخدام — لا يُعطى في هذه الحالات
Adverse effect	أعراض جانبية غير مرغوب فيها
Drug interaction	تفاعل بين دواءين أو أكثر يغير تأثيرهما
Tolerance	تراجع الاستجابة للدواء مع الوقت
Dependence	اعتماد الجسم على الدواء

ملخص سريع

اللاحقة الدوائية	الفئة
-cillin	بنسلين
-cycline	تتراسيكلين
-floxacin	فلوروكينولون
-azole	مضاد فطري / PPI
-olol	حاصر بيتا
-pril	ACE inhibitor
-sartan	ARB
-vastatin	ستاتين
-dipine	CCB
-pam / -lam	بنزوديازيبين

القسم الأول — المصطلحات الطبية · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

تصنيفات الأدوية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: تصنيفات الأدوية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

لماذا يهتمك هذا؟

لأن كل يوم في الصيدلية ستتعامل مع مئات الأدوية. بدون تصنيف واضح في ذهنك، ستغرق. بوجوده، كل دواء جديد تراه يجد مكانه تلقائياً.

1. نظام ATC — التصنيف الدولي المعتمد

Anatomical Therapeutic Chemical Classification ATC =

نظام تصنيف منظمة الصحة العالمية ((WHO). كل دواء معتمد في العالم له رمز ATC.

الهيكل الهرمي — 5 مستويات

المستوى 1: الجهاز التشريحي (حرف واحد)

المستوى 2: المجموعة العلاجية الرئيسية (رقمان)

المستوى 3: المجموعة الفرعية العلاجية (حرف)

المستوى 4: المجموعة الكيميائية (حرف)

المستوى 5: المادة الفعالة (رقمان)

مثال: الميتفورمين (علاج السكري)

A → الجهاز الهضمي والأبيض

A10 → أدوية السكري

A10B → أدوية السكري (خافضات السكر الفموية)

A10BA → البيغوانيدات

A10BA02 → Metformin ✓

2. المجموعات الرئيسية (المستوى الأول)

الرمز	الجهاز / النظام	أمثلة سريعة
A	الجهاز الهضمي والأبيض	ميتفورمين، أوميزانول، إنزيمات الهضم
B	الدم وأعضاء تكون الدم	وارفارين، حمض الفوليك، الحديد
C	الجهاز القلبي الوعائي	أملوديبيين، أتورفاستاتين
D	الجلد	هيدروكورتيزون كريم، مضادات الفطريات الموضعية
G	الجهاز البولي التناسلي والهرمونات الجنسية	حبوب منع الحمل، سيبروترون
H	الهرمونات الجهازية (غير الجنسية)	هرمون الغدة الدرقية، الكورتيزون
J	المضادات العامة للعدوى الجهازية	كل المضادات الحيوية، مضادات الفيروسات
L	الأورام والعلاج المناعي	كيماوي، أجسام مضادة
M	الجهاز الحركي (عضلات وعظام)	إيبوبروفين، ميتوتريكسات
N	الجهاز العصبي	مسكنات، مضادات اكتئاب، مضادات صرع
P	مضادات الطفيليات والحشرات	الكلوروكين، أدوية الملاريا
R	الجهاز التنفسي	سالبوتامول، مضادات الهيستامين
S	الحواس (عين، أذن، أنف)	قطرات العين والأذن
V	متفرقات	تريبات، صبغات تشخيصية

3. التصنيف العملي في الصيدلية اليومية

المجموعة N — الجهاز العصبي (الأكثر تنوعاً وأهمية)

الفئة الفرعية	الاستخدام	أمثلة
N01 — تخدير	التخدير العام والموضعي	ليدوكاين، كيتامين
N02A — أوبيويدات	ألم شديد	مورفين، كودين، ترامادول
N02B — مسكنات لا أوبيويد	ألم خفيف-متوسط	براسيتامول، أسبرين
N03 — مضادات الصرع	الصرع، بعض الألم العصبي	فينيتوين، كاربامازيبين
N04 — مضادات باركنسون	داء باركنسون	ليفودوبا، براميبكسول
N05A — مضادات الذهان	القصام، الهوس	هالوبريدول، أولانزابين
N05B — مزيلات القلق	القلق، الأرق	ديازيبام، ألبرازولام
N05C — منومات	الأرق	زولبيديم، ترازودون
N06A — مضادات الاكتئاب	الاكتئاب، القلق المزمن	فلوكسيتين، سيرترالين
N06B — منبهات الجهاز العصبي	ADHD	ميثيلفينيدات، أتوموكسيتين

المجموعة C — القلب والأوعية الدموية

الفئة	الاستخدام	أمثلة
C02 — خافضات الضغط	ضغط الدم المرتفع (خط ثاني)	هيدرالازين، ميتيلدوبا
C03 — مدرات البول	الضغط، القصور القلبي، الوذمة	فيوروسيميد، هيدروكلوروثيازيد
C07 — حاصرات بيتا	الضغط، الذبحة، ضربات غير منتظمة	أتينولول، ميتوبرولول
C08 — حاصرات قنوات الكالسيوم	الضغط، الذبحة	أملوديبين، ديلتيازيم
ACE inhibitors — C09A	الضغط، القصور القلبي	ليزيناپريل، إنالابريل
ARBs — C09C	الضغط (بديل ACE بلا سعال)	لوسارتان، فالسارتان
C10 — خافضات الدهون	الكوليسترول	أتورفاستاتين، رسيوفاستاتين

المجموعة J — المضادات الحيوية (مفصلة في prereq_03)

الفئة	الفصيلة
J01A	تتراسيكلينات
J01C	بنسلينات
J01D	سيفالوسبورينات
J01E	سلفوناميدات وتريميثوبريم
J01F	ماكروليدات
J01G	أمينوغليكوزيدات
J01M	فلوروكينولونات
J01X	أخرى (فانكومايسين، ميترونيدازول)

4. التصنيف حسب آلية العمل (Mechanism of Action))

هذا التصنيف مهم لفهم لماذا يعمل الدواء، وليس فقط ماذا يعالج.

الآلية	المعنى المبسط	مثال
Agonist	يحفز المستقبل ويفعله	ساليوتامول يحفز مستقبلات بيتا-2 في الرئة
Antagonist	يرتبط بالمستقبل ويمنع تفعيله	أتينولول يمنع مستقبلات بيتا-1 في القلب
Enzyme inhibitor	يثبط إنزيماً معيناً	ACE inhibitors تثبط إنزيم ACE
Channel blocker	يسد قناة أيونية	أملوديبيين يسد قنوات الكالسيوم
Reuptake inhibitor	يمنع إعادة امتصاص ناقل عصبي	فلوكسييتين يمنع إعادة امتصاص السيروتونين
DNA/RNA disruption	يتدخل في تكاثر الخلية	معظم المضادات الحيوية والكيماءات

5. تصنيف الأدوية حسب درجة الخطورة في الحمل

نظام (FDA الأمريكي) — لا يزال مرجعاً شائعاً رغم تحديثه:

الفئة	المعنى	مثال
A	آمن تماماً — دراسات بشرية سليمة	حمض الفوليك
B	آمن نسبياً — آمن في الحيوانات	براسيتامول، أموكسيسيلين
C	حذر — لا دراسات بشرية كافية	معظم الأدوية الشائعة
D	خطر مثبت — إلا عند الضرورة القصوى	فينيتوين، بعض الستيرويدات
X	ممنوع تماماً في الحمل	ميثوتريكسات، أيزوترينينون (رواكيوتان)

6. تصنيف المخدرات والمواد الخاضعة للرقابة

في معظم الدول المواد مصنفة حسب درجة خطورتها وإمكانية الإدمان:

الجدول	المعنى	أمثلة
جدول I	ممنوع — لا استخدام طبي معتمد	الهروين، LSD
جدول II	استخدام طبي + خطر إدمان عالٍ	مورفين، أوكسيكودون، ريتالين
جدول III	استخدام طبي + خطر متوسط	كودين بجرعات عالية، كيتامين
جدول IV	استخدام طبي + خطر منخفض	ديازيبام، ألبرازولام، زولبيديم
جدول V	خطر محدود جداً	سيروب السعال بالكودين (تركيزات منخفضة)

⚠ **تنبيه:** في الصيدلية، أي دواء جدول II أو III يتطلب وصفة خاصة وتسجيلاً في السجل الخاص بالمخدرات. لا تتجاوز هذه القاعدة أبداً.

ملخص — ماذا تحفظ من هذا الملف؟

1. رموز ATC الأولى — S , R , N , M , L , J , H , G , D , C , B , A
2. اللواحق الدوائية (من (prereq_01 تكمل نظام ATC — معاً يحددان الفئة

3. فئات الحمل A/B آمن، D/X ممنوع

4. الجداول الدوائية — جدول II و IV الأهم في الصيدلية اليومية

القسم الأول — تصنيفات الأدوية · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

المضادات الحيوية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: المضادات الحيوية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

ملاحظة مهمة قبل القراءة:

المضادات الحيوية هي الأكثر وصفاً والأكثر سوء استخدام في العالم. فهمها جيداً يجعلك فنياً صيدلانياً حقيقياً، لا مجرد موزع أدوية.

1. المبدأ الأساسي — كيف تعمل المضادات الحيوية؟

هناك 5 آليات رئيسية:

1. تدمير جدار الخلية البكتيرية ← البنسلينات، السيفالوسبورينات، فانكومايسين
2. تثبيط تصنيع البروتين ← أمينوغليكوزيدات، مكاروليدات، تتراسيكلينات
3. تثبيط تصنيع الحمض النووي ← فلوروكينولونات، سلفوناميدات
4. تلف غشاء الخلية ← بوليميكسين
5. تثبيط الأيض البكتيري ← سلفوناميدات (ثانياً)

2. الفصائل الرئيسية — الجدول الشامل

١) البنسلينات ((Penicillins — J01C

الاسم الجينيبي	الاسم التجاري الشائع	الاستخدام الرئيسي	ملاحظات
Amoxicillin	Amoxil , Augmentin *	التهاب الأذن، الجهاز التنفسي، البول	الأكثر وصفاً
Amoxicillin + Clavulanate	Clavamox , Augmentin	عدوى مقاومة للبنسلين	كلافولانات تمنع مقاومة البكتيريا
Ampicillin	Penbritin	التهاب السحايا، الإنتان	غالباً وريدي
Flucloxacillin	Floxapen	عدوى الجلد والمكورات العنقودية	مقاوم للبنيسيليناز
Piperacillin + Tazobactam	Tazocin	عدوى شديدة في المستشفيات	طيف واسع جداً

⚠ تنبيه حساسية البنسلين: دائماً أسأل المريض قبل صرف أي بنسلين. حساسية البنسلين تحدث في 10% من المرضى، وتعالج مع السيفالوسبورينات بنسبة أقل.

٢) السيفالوسبورينات ((Cephalosporins — J01D

مقسمة إلى أجيال — كل جيل أوسع طيفاً وأقوى ضد البكتيريا السالبة لغرام:

الجيل الأول — الجرام موجب بشكل رئيسي

الاسم الجينيبي	التجاري	الاستخدام
Cephalexin	Keflex	عدوى الجلد والبول — فموي
Cefazolin	Ancef	جراحة وقاية — وريدي

الجيل الثاني — طيف أوسع

الاسم الجينيبي	التجاري	الاستخدام
Cefuroxime	Zinacef , Zinnat	التهاب الجيوب والأذن والروثة
Cefaclor	Ceclor	التهاب الجهاز التنفسي العلوي

الجيل الثالث — سالب غرام قوي

الاسم الجينيبي	التجاري	الاستخدام
Ceftriaxone	Rocephin	التهاب السحايا، الإنتان، السيلان — وريدي
Cefixime	Suprax	التهاب البول والأذن — فموي
Cefotaxime	Claforan	عدوى شديدة — وريدي

الجيل الرابع

الاسم الجينيبي	التجاري	الاستخدام
Cefepime	Maxipime	عدوى المستشفيات الشديدة — وريدي

الجيل الخامس

الاسم الجينيبي	التجاري	الاستخدام
Ceftaroline	Teflaro	MRSA — وريدي

❓ الماكروليدات ((J01F — Macrolides

بديل للمرضى الحساسين للبنسلين. تعمل بتثبيط تصنيع البروتين.

الاسم الجينيبي	التجاري	الاستخدام	ملاحظات
Azithromycin	Zithrocin ,Zithromax	التهاب الرئة، الكلاميديا، الأذن	نصف عمر طويل — 5 أيام تكفي
Clarithromycin	Klacid	التهاب الجيوب والرئة، H. pylori	مع أوميبرازول لعلاج H. pylori
Erythromycin	Erythrocin	بديل البنسلين في الحساسية	أثار جانبية هضمية كثيرة

❓ الفلوروكينولونات ((J01M — Fluoroquinolones

تثبط إنزيمات DNA gyrase و Topoisomerase IV البكتيرية.

الاسم الجينيبي	التجاري	الاستخدام	تحذير خاص
Ciprofloxacin	Ciprobay ,Cipro	التهاب البول، الأمعاء، العظام	الأكثر استخداماً في الفئة
Levofloxacin	Tavanic ,Levaquin	التهاب الرئة، الجيوب	quinolone of respiratory tract"
Moxifloxacin	Avelox	التهاب الرئة المكتسب من المجتمع	لا يُستخدم في التهاب البول
Norfloxacin	Noroxin	التهاب المسالك البولية فقط	نشاط منخفض خارج المسالك

⚠ تحذيرات الفلوروكوينولونات:

- تمزق الأوتار (خاصة وتر أكيليس) — تجنب في المرضى >60 سنة أو مع الكورتيكوستيرويدات

- تطيل QT في مخطط القلب — تحذر مع أدوية الإيقاع

- تجنب في الأطفال والحوامل (تضر بالغضاريف)

- FDA أضافت تحذير Black Box لمخاطر الأعصاب الطرفية

❓ التتراسيكلينات ((Tetracyclines — J01A

تثبط ارتباط tRNA بالريبوسوم البكتيري.

الاسم الجينيبي	التجاري	الاستخدام
Doxycycline	Doxine ,Vibramycin	أكثرها استخداماً — كلاميديا، ملاريا وفاقية، حب الشباب
Tetracycline	Achromycin	حب الشباب، H. pylori
Minocycline	Minocin	حب الشباب الشديد

⚠ **تحذير:** لا تُعطى مع منتجات الألبان أو الحديد أو الكالسيوم (تمنع الامتصاص). ممنوعة في الأطفال <8 سنوات (تصبغ الأسنان الدائم).

❓ J01G — أمينوغليكوزيدات ((Aminoglycosides

تُستخدم في العدوى الشديدة، غالباً بالمستشفيات.

الاسم الجينيبي	التجاري	الاستخدام
Gentamicin	Garamycin	إنتان، عدوى الكلى والبول الشديدة
Amikacin	Amikin	بكتيريا مقاومة لجنتاميسين
Tobramycin	Tobrex	التليف الكيسي، قطرات عين
Neomycin	موضعي فقط	جروح، التهاب الجلد الموضعي

⚠️ **خطورة رئيسية: سُمية للكلية ((Nephrotoxic و سُمية للأذن ((Ototoxic. يجب مراقبة وظائف الكلى وسماع المريض.**

❓ J01E — السلفوناميدات والتريميثوبريم

الاسم الجينيبي	التجاري	الاستخدام
Trimethoprim-Sulfamethoxazole (TMP-SMX)	Septtrin ,Bactrim	التهاب المسالك البولية، التهاب الرئة بالمتكيسات
Trimethoprim وحده	Trimopan	UTI خفيفة

● المضادات الحيوية الخاصة — فانكوميسين وميترونيدازول

الاسم الجينيبي	الفئة	الاستخدام
Vancomycin	Glycopeptide	MRSA — وريدي — العدوى المقاومة
Metronidazole	Nitroimidazole	اللاهوائيات، Clostridium difficile، الطفيليات (جيارديا، أميبا)
Linezolid	Oxazolidinone	MRSA حين يفشل فانكوميسين
Clindamycin	Dalacin	اللاهوائيات، عدوى الجلد، بديل البنسلين

3. الطيف الضيق مقابل الواسع

ضيق الطيف ← ————— → واسع الطيف

أموكسيسيلين أوجمنتين سيفتريا كسون إيميبينيم G بنسلين
موجب غرام (موجب+ بعض (+ مقاومة) (واسع) (الأوسع))
(فقط) سالب

القاعدة الذهبية في استخدام المضادات الحيوية:

ابدأ بأضيق طيف يكفي لعلاج العدوى المشخصة — الطيف الواسع لعدوى شديدة غير محددة أو فاشلة العلاج.

4. المقاومة البكتيرية — ما يجب أن يعرفه كل فني صيدلاني

البكتيريا الأكثر مقاومة ((ESKAPE organisms

الاختصار	البكتيريا
E	Enterococcus faecium
S	Staphylococcus aureus (MRSA)
K	Klebsiella pneumoniae (ESBL)
A	Acinetobacter baumannii
P	Pseudomonas aeruginosa
E	Enterobacter spp.

MRSA — المكور العنقودي الذهبي المقاوم للميثيسيلين

- ما هو: S. aureus مقاوم للبنسلينات والسيفالوسبورينات
- علاجه: فانكومايسين، لينزوليد، سيفتارولين
- أين يصيب: الجروح، الجلد، الرئة، الدم

5. المضادات الحيوية وتأثيرها على الأمعاء

كل مضاد حيوي يُدمر بعض البكتيريا النافعة في الأمعاء. هذا يسبب:

• إسهال مرتبط بالمضادات الحيوية ((Antibiotic-Associated Diarrhea)

• عدوى C. difficile في الحالات الشديدة

الحل: البروبيوتيك (Lactobacillus, Saccharomyces boulardii) مع أو بعد المضاد الحيوي.

6. الجدول المرجعي السريع

الغثة	اللاحقة المميزة	الآلية	ملاحظة رئيسية
بنسلينات	-cillin	جدار الخلية	تحقق من حساسية البنسلين
سيفالوسبورينات	Ceph- / Cef-	جدار الخلية	أجيال 1-5 متصاعدة الطيف
ماكروليدات	- mycin / - thromycin	بروتين	بديل ممتاز للحساسين من البنسلين
فلوروكينولونات	-floxacin	DNA	ممنوع للأطفال والحوامل
تتراسيكلينات	-cycline	بروتين	بعيداً عن الألبان والحديد
أمينوغليكوزيدات	- mycin / - micin	بروتين	مراقبة الكلى والأذن
فانكوميسين	—	جدار الخلية	آخر سلاح ضد MRSA
ميترونيدازول	—	DNA	للامواثبات والطفيليات

القسم الأول — المضادات الحيوية · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

المسكنات ومضادات الالتهاب

[صورة غلاف توضيحية لفصل: المسكنات ومضادات الالتهاب]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

الألم أكثر شكاوى يواجهها في الصيدلية. معرفة الفرق بين مسكن وآخر — ومتى تحيل المريض للطبيب — هي أحد أهم مهاراتك.

1. السلم التصاعدي للألم (WHO Pain Ladder))

درجة 3 - ألم شديد

- أوبيويد قوي: مورفين، أوكسيكودون، فنتانيل
- مسكن بسيط ± مساعد ±

درجة 2 - ألم متوسط

- أوبيويد خفيف: كودين، ترامادول
- مسكن بسيط ±

درجة 1 - ألم خفيف

- باراسيتامول
- إيبوبروفين، نابروكسين، ديكلوفيناك: NSAIDs
- أسيرين

2. الباراسيتامول (Paracetamol / Acetaminophen))

الاسم التجاري الأشهر: بانادول ((Panadol, تايلينول ((Tylenol

آلية العمل

يُثَبِّط إنزيم COX في الجهاز العصبي المركزي. لا يملك تأثيراً مضاداً للالتهاب.

الاستخدام

- الحمى والألم الخفيف إلى المتوسط
- آمن للحوامل والأطفال والكبار

الجرعات

الفئة	الجرعة	الحد الأقصى اليومي
بالغ	500 - 1000 mg كل 4-6 ساعات	4 غرام (4000 mg)
طفل	10-15 mg/kg كل 4-6 ساعات	75 mg/kg/day

⚠ تحذير رئيسي: الجرعة الزائدة تسبب فشلاً كبدياً قاتلاً. المرضى الذين يشربون الكحول بانتظام أو مرضى الكبد — الحد الأقصى لهم 2 غرام يومياً.

3. مضادات الالتهاب غير الستيرويدية — NSAIDs

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

آلية العمل

تُثَبِّط إنزيمات COX-1 و COX-2 مما يمنع تصنيع البروستاغلاندينات المسؤولة عن الألم والالتهاب والحمى.

تحمي بطانة المعدة + تصنيع الثرومبوكسان (تجلط) → COX-1
مسؤولة عن الالتهاب بشكل رئيسي → COX-2

الجدول الكامل للـ NSAIDs الشائعة

الاسم الجينيبي	التجاري الشائع	الجرعة المعتادة	ملاحظة
Ibuprofen	Nurofen ,Advil ,Brufen	3 × mg 400-600	الأشهر والأمان عموماً
Naproxen	Aleve ,Naprosyn	2 × mg 250-500	نصف عمر أطول
Diclofenac	Cataflam ,Voltaren	2-3 × mg 50	قوى للألم العضلي والمفصلي
Ketoprofen	Profenid	2-3 × mg 50-100	قوى — أقل شيوعاً
Indomethacin	Indocid	2-3 × mg 25-50	قوى، آثار جانبية أكثر
Mefenamic acid	Ponstan	3 × mg 500	آلام الدورة الشهرية
Piroxicam	Feldene	1 × mg 20	يومي — ألم مزمن
Meloxicam	Mobic	1 × mg 7.5-15	انتقائي COX-2 جزئياً
Celecoxib	Celebrex	2 × mg 100-200	انتقائي COX-2 — أقل ضرراً للمعدة
Etoricoxib	Arcoxia	1 × mg 60-120	COX-2 خالص — مرضى حساسية المعدة

الآثار الجانبية المهمة للـ NSAIDs

الجهاز	المشكلة	الوقاية
المعدة	قرحة، نزيف	مع الطعام + PPI مع الاستخدام الطويل
الكلية	تراجع وظيفية الكلية	تجنب في مرضى الكلية والمسنين
القلب	رفع خطر الجلطة القلبية	تجنب COX-2 في مرضى القلب
الدم	تثبيط تجلط الدم	تحذر مع وارفارين
الحمل	إغلاق القناة الشريانية	ممنوعة في الثلث الثالث

4. الأسبرين (Aspirin / Acetylsalicylic Acid)

جرعتان — هدفان مختلفان تماماً:

الجرعة	الاستخدام	آلية العمل
75-100 mg يومياً	منع الجلطات (تخفيف الدم)	تثبيط COX-1 لارجعة فيه → منع تجمع الصفائح
500-1000 mg	مسكن / خافض حرارة	مثل باقي NSAIDs

⚠ ممنوع في الأطفال <16 سنة بجرعة المسكن: خطر متلازمة ري (Reye Syndrome) — فشل كبدي ودماعي نادر لكن قاتل.

5. المسكنات الأفيونية (Opioids)

ترتبط بمستقبلات المورفين (μ , κ , δ) في الجهاز العصبي المركزي والطرفي.

التردد من الأضعف للأقوى

ضعيف — كودين (Codeine)



متوسط — ترامادول (Tramadol)



متوسط-قوي — هيدروكودون (Hydrocodone)



قوي — أوكسيكودون (Oxycodone)



قوي جداً (المرجع) — مورفين (Morphine)



أقوى من مورفين 5× — هيدرومورفون (Hydromorphone)



أقوى من مورفين 100× — فنتانيل (Fentanyl)



أقوى 500-1000× — سوفنتانيل (Sufentanil)

جدول الأوبيويدات الشائعة

الاسم	التجاري	المطريق	الاستخدام
Codeine	كودين	فموي	سعال، ألم خفيف-متوسط
Tramadol	Ultram ,Tramal	فموي / حقن	ألم متوسط-شديد
Morphine	MST ,MS Contin	فموي / حقن / وريدي	ألم شديد، الأزمة القلبية الحادة
Oxycodone	OxyContin	فموي	ألم شديد مزمن
Fentanyl	Duragesic	لاصق / وريدي	ألم مزمن شديد، تخدير
(Meperidine)Pethidine	Demerol	حقن	ألم المخاض (يتراجع استخدامه)
Buprenorphine	Temgesic ,Subutex	تحت اللسان / لاصق	ألم مزمن، علاج الإدمان
Naloxone	Narcan	وريدي / أنفي	ترياق لجرعة الأوبيويد الزائدة

الآثار الجانبية الثابتة لكل الأوبيويدات

1. إمساك — لا يتطور تحمل له، دائماً يحتاج مسهل
2. غثيان وقيء — خاصة في البداية
3. تثبيط التنفس — الخطر الأكبر عند الجرعة الزائدة
4. النعاس والدوخة
5. الإدمان والاعتماد — خاصة مع الاستخدام الطويل

⚠ جرعة زائدة أوبيويد: ثلاثية كلاسيكية = تقلص حدقة العين ((pin-point pupils + تثبيط التنفس + فقدان الوعي. العلاج الفوري: نالوكسون ((Narcan IV.

6. مضادات الالتهاب الستيرويدية (Corticosteroids))

ليست مسكنات مباشرة لكنها تُكبح الالتهاب بقوة.

الاسم	التجاري	القوة النسبية	الاستخدام
Hydrocortisone	Solu-Cortef ,Cortef	×1 (المرجع)	قصور الغدة الكظرية، حساسية حادة
Prednisolone	Deltacortril	×4	الالتهابات، الربو، أمراض مناعية
Methylprednisolone	Solu-Medrol ,Medrol	×5	التهاب حاد، الحساسية الشديدة
Dexamethasone	Decadron	×25	وذمة الدماغ، غثيان الكيماوي، الإنتان
Betamethasone	Celestone	×25	استخدام موضعي على الجلد
Triamcinolone	Kenalog	×5	حقن مفصلي

مخاطر الاستخدام الطويل للستيرويدات

- ارتفاع السكر في الدم
- ارتفاع ضغط الدم
- ضعف العظام (هشاشة)
- كبت الجهاز المناعي
- تقلص الغدة الكظرية — لا تقف عن الستيرويد فجأة! يجب التوقف تدريجياً.

7. مسكنات الألم العصبي ((Neuropathic Pain

الألم العصبي لا يستجيب جيداً لـ NSAIDs أو أوبيويدات — له علاجات خاصة:

الدواء	الفئة الأصلية	الاستخدام في الألم العصبي
(Neurontin)Gabapentin	مضاد صرع	نيوروباثي السكري، ألم الهرس
(Lyrica)Pregabalin	مضاد صرع	الغبروميالوجيا، نيوروباثي سكري
Amitriptyline	مضاد اكتئاب ثلاثي	ألم مزمن، الصلع النصفى وقاية
(Cymbalta)Duloxetine	SNRI	نيوروباثي السكري، الغبروميالوجيا
(Tegretol)Carbamazepine	مضاد صرع	ألم العصب مثلث التوائم

8. جدول المقارنة السريعة

المعيار	باراسيتامول	NSAID	أوبيويد
مضاد للالتهاب	✗	✓	✗
مسكن	✓	✓	✓✓✓
خافض حرارة	✓	✓	✗
آمن للمعدة	✓	✗	✓
آمن للكلى	✓	⚠	✓
خطر إدمان	✗	✗	✓⚠
آمن في الحمل	✓ الأفضل	⚠	⚠
يحتاج وصفة	لا (معظم الدول)	بعضها	نعم دائماً

القسم الأول — المسكنات ومضادات الالتهاب · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

أدوية القلب والأوعية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: أدوية القلب والأوعية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

القلب والضغط معاً يمثلان أكثر من 30% من الأدوية المصروفة في الصيدليات. الطريق لهما واضح — فهم طبقة طبقة.

1. ضغط الدم — الأرقام التي يجب حفظها

التصنيف	الانقباضي (فوق)	الانقباضي (تحت)
طبيعي	120 ;lt&	80 ;lt&
مرتفع حدي (Elevated))	120-129	80 ;lt&
مرحلة 1	130-139	80-89
مرحلة 2	140 ≤	90 ≤
أزمة ضغط	180 ;gt&	120 ;gt& → طوارئ

2. خطوات علاج ارتفاع ضغط الدم

الخط الأول (أي منها أو تركيبة)

- └ ACE inhibitors (-pril)
- └ ARBs (-sartan)
- └ حاصرات قنوات الكالسيوم (-dipine)
- └ مدرات البول (الثيازيدات)

الخط الثاني:

- └ حاصرات بيتا (-olol)
- └ الفا بلوكر (-zosin)
- └ Spironolactone

الخط الثالث (ضغط مقاوم)

تركيبة 3-4 أدوية + دواء رابع

3. مثبطات ACE — (-)pril

الآلية: تمنع إنزيم ACE من تحويل Angiotensin I (→ Angiotensin II مضيق الأوعية)

الاسم	التجاري	الجرعة المعتادة
Lisinopril	Prinivil ,Zestril	40-5 mg يومياً
Enalapril	Renitec ,Vasotec	40-5 mg يومياً
Captopril	Capoten	50-12.5 mg 2-3 ×
Ramipril	Tritace ,Altace	10-2.5 mg يومياً
Perindopril	Coversyl	8-4 mg يومياً

فوائد إضافية: حماية الكلى في مرضى السكري، تحسين القصور القلبي.

⚠ السعال الجاف: عارض جانبي في 10-20% من المرضى — البديل هو ARB.

⚠ وذمة وعائية ((Angioedema): نادر لكن خطير — ورم الوجه والحلق → توقف فوري.

⚠ ممنوع في الحمل — تشوهات خطيرة في الجنين.

4. حاصرات ARB — (-)sartan

الآلية: تمنع ارتباط Angiotensin II بمستقبلاتها مباشرة — نفس التأثير بلا سعال.

الاسم	التجاري	الجرعة المعتادة
Losartan	Cozaar	mg 25-100 يومياً
Valsartan	Diovan	mg 80-320 يومياً
Irbesartan	Avapro	mg 150-300 يومياً
Candesartan	Atacand	mg 4-32 يومياً
Olmesartan	Benicar	mg 20-40 يومياً
Telmisartan	Micardis	mg 20-80 يومياً

⚠ لا تجمع ACE + ARB معاً — خطر فشل كلوي وارتفاع البوتاسيوم.

5. حاصرات قنوات الكالسيوم ((CCB — -) (dipine وغيرها)

الآلية: تمنع دخول الكالسيوم للخلية العضلية الملساء → ارتخاء الأوعية → انخفاض الضغط.

نوعان رئيسيان:

ديهيدروبيريدينات (تأثير على الأوعية أساساً):

الاسم	التجاري	ملاحظة
Amlodipine	Norvasc	الأفضل للضغط — مرة يومياً
Nifedipine	Adalat	سريع المفعول — للآزمات
Felodipine	Plendil	
Lercanidipine	Zanidip	أقل انتفاخاً للكاحل

غير ديهيدروبيريدينات (تأثير على القلب والأوعية):

الاسم	التجاري	ملاحظة
Verapamil	Isoptin	يُبطئ القلب — للرجفان الأذيني
Diltiazem	Cardizem	يُبطئ القلب — الذبحة

6. حاصرات بيتا (Beta-Blockers) — (-olol)

الآلية: تمنع مستقبلات بيتا الأدرينالية.

- بيتا-1 (القلب): تقلل معدل ضربات القلب وقوة الانقباض
- بيتا-2 (الرئة/الأوعية): التأثير هنا يسبب تضيق الشعب الهوائية

الاسم	التجاري	الانتقائية	الاستخدام
Metoprolol	Betaloc ,Lopressor	بيتا-1 ✓	ضغط، قصور قلبي، ذبحة
Atenolol	Tenormin	بيتا-1 ✓	ضغط، ذبحة
Bisoprolol	Concor	بيتا-1 ✓ (الأكثر انتقائية)	قصور قلبي
Carvedilol	Coreg	بيتا-1 + بيتا-2 + ألفا	قصور قلبي
Propranolol	Inderal	بيتا-1 + بيتا-2 (غير انتقائي)	صداع نصفي، قلق، فرط نشاط درقية
Nebivolol	Nebilet	بيتا-1 ✓ + NO	ضغط، قصور قلبي
Labetalol	Trandate	بيتا + ألفا	ضغط الحمل

⚠️ تحذيرات:

- تجنب في الربو والانسداد الرئوي المزمن (خاصة غير الانتقائية)

- لا تتوقف فجأة — تدريجياً لتجنب احتشاء القلب الارتدادي

- تسبب ببطء القلب وبرودة الأطراف

7. مدرات البول ((Diuretics

التيازيدات — خط أول للضغط

الاسم	التجاري	الجرعة
(HCTZ)Hydrochlorothiazide	Esidrex	mg 12.5-25 يومياً
Chlorthalidone	Hygroton	mg 12.5-25 يومياً
Indapamide	Natrilix	mg 1.5-2.5 يومياً

مدرات العروة — القوية

الاسم	التجاري	الاستخدام
Furosemide	Lasix	قصور القلب، الوذمة، الكلى
Bumetanide	Bumex	بديل فيبوروسيميد
Torasemide	Torem	نصف عمر أطول

مدرات موقرة للبوتاسيوم

الاسم	التجاري	الاستخدام
Spironolactone	Aldactone	قصور القلب، ارتفاع ألدوستيرون
Eplerenone	Inspira	مثل سبيرونولاكوتون بأقل أعراض
Amiloride	Midamor	مع التيازيدات لتوازن البوتاسيوم

8. أدوية الكوليسترول — الستاتينات (-)vastatin

الآلية: تثبط إنزيم HMG-CoA reductase → تقلل تصنيع الكوليسترول في الكبد.

الاسم	التجاري	المقوة	الجرعة
Rosuvastatin	Crestor	★★★★☆ الأقوى	mg 5-40
Atorvastatin	Lipitor	★★★★	mg 10-80
Simvastatin	Zocor	★★★	mg 10-40
Pravastatin	Pravachol	★★	mg 10-80
Fluvastatin	Lescol	★	mg 20-80

⚠️ الألم العضلي ((Myalgia: الأكثر شيوعاً. الأخطر هو انهيار العضلات ((Rhabdomyolysis → راقب CPK.

⚠️ ممنوعة في الحمل (فئة X).

أدوية كوليسترول غير ستاتينية

الاسم	التجاري	الآلية
Ezetimibe	Ezetrol	يمنع امتصاص الكوليسترول من الأمعاء
Fenofibrate	Lipanthyl	يخفض الدهون الثلاثية بشكل خاص
Evolocumab	Repatha	مثبط PCSK9 — حقن شهري — قوي جداً

9. أدوية قصور القلب ((Heart Failure

البروتوكول الحديث — ARNI + بيتا بلوكر + SGLT2i + MRA:

الدواء / الفئة	المثال	الدور
ACE / ARB / ARNI	(Entresto)Sacubitril+Valsartan	تقليل الحمل على القلب
حاصر بيتا	بيسوبرولول، كارفيديلول	تقليل معدل القلب وحمايته
(Anti-aldosterone)MRA	سبيرونولاكتون	تقليل التليف، ضبط البوتاسيوم
SGLT2 inhibitor	(Forxiga)Dapagliflozin	تقليل الوفيات — جديد نسبياً
مدر البول	فيوروسيميد	تخفيف الوذمة والاحتقان
Digoxin	لانوكسين	تقليل معدل القلب في الرجفان الأذيني

10. ملخص لواحق الأدوية القلبية

اللاحقة	الفئة
-pril	ACE inhibitor
-sartan	ARB
-dipine	CCB ديهيدروبيريدين
-olol	بيتا بلوكر
-vastatin	ستاتين
-zosin	ألفا بلوكر
-thiazide	ثيازيد مدر

القسم الأول — أدوية القلب والأوعية · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

الأشكال الصيدلانية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: الأشكال الصيدلانية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

الدواء الواحد قد يأتي في 5 أشكال مختلفة. لكل شكل سبب — معدل امتصاص، سهولة بلع، سرعة تأثير. هذا الملف يربط الشكل بالمنطق.

1. الأشكال الصلبة (Solid Dosage Forms)

الأقراص (Tablets)

النوع	الوصف	مثال
قرص عادي	يُبلع مع الماء	براسيتامول 500 mg
قرص مغلف (Coated)	طلاء يحمي المعدة أو يخفي الطعم	أسبرين معوي (Enteric-coated)
قرص بطيء الإطلاق (SR/XR/ER)	يُطلق الدواء تدريجياً	Diltiazem SR, Metformin XR
قرص تحت اللسان (SL)	يُذاب تحت اللسان للامتصاص السريع	نيتروغليسرين SL في الذبحة
قرص قابل للمضغ	يُمضغ لا يُبلع	أموكسيسيلين للأطفال
قرص فوار (Effervescent)	يُذاب في ماء	فيتامين C فوار، أسبرين فوار
قرص تحلل في الفم (ODT)	يذوب على اللسان — للذين يجدون صعوبة في البلع	أولانزابين ODT، أوندانسيترون ODT

❗ **قاعدة صارمة:** الأقراص ذات الإطلاق المعدل (SR, XR, ER, LA) لا تُكسر ولا تُسحق أبداً — يُطلق الدواء كله دفعة واحدة → جرعة زائدة.

الكبسولات (Capsules)

النوع	الوصف
كبسولة جيلاتين صلبة	محتواها مسحوق أو حبيبات — يمكن أحياناً فتحها
كبسولة جيلاتين لينة (Softgel)	محتواها سائل — لا تُفتح أبداً
كبسولة بطيئة الإطلاق	مثل قرص SR — لا تُفتح

المساحيق والحبيبات (Granules & Powders)

- تُذاب في الماء قبل الاستخدام
- شائعة للأطفال وكبار السن الذين لا يبلعون الأقراص
- مثال: مسحوق أموكسيسيلين معلق للأطفال

2. الأشكال السائلة (Liquid Dosage Forms)

الشكل	التعريف	مثال
محلول (Solution)	الدواء مذاب تماماً في السائل	شراب باراسيتامول
معلق (Suspension)	جزيئات الدواء معلقة — يُرج قبل الاستخدام	معلق أموكسيسيلين للأطفال
مستحلب (Emulsion)	خليط زيت وماء	بعض التغذية الوريدية
إكسير (Elixir)	محلول بكحول + سكر	بعض أسبروب الكحة القديمة
شراب (Syrup)	محلول مُحلّى	شراب السعال

⚠ **تحذير المعلق:** إذا نسي المريض الرج يحصل على جرعة منخفضة ثم جرعة مركزة جداً.

3. الأشكال شبه الصلبة ((Semi-solid Forms

الشكل	الفرق	الاستخدام
مرهم ((Ointment	قاعدة زيتية — لا تحتوى ماء	جلد جاف، حروق، الصدفية
كريم ((Cream	خليط ماء وزيت — يُمتص أسرع	التهابات جلدية، فطريات
جل ((Gel	قاعدة مائية — يُمتص بسرعة، لا يترك أثراً دهنياً	حب الشباب، ألم العضلات
لاصقة ((Paste	كثيف جداً — يبقى مكانه	تقرحات الفم، الحفاضات
لبوس ((Suppository	يُدخل شرجياً أو مهبلياً	براسيتامول مستقيمي، تحاميل مهبلية

4. أشكال الاستنشاق ((Inhalation Forms

مبدأ: يصل الدواء مباشرة للرئة — جرعة أقل وتأثير أسرع مع أعراض جانبية جهازية أقل.

الشكل	الاختصار	كيف يعمل	مثال
بخاخ بالضغط ((Pressurized MDI	pMDI	يُضغط ويُستنشق	(Ventolin سالبوتامول)
بخاخ جاف ((Dry Powder Inhaler	DPI	يُستنشق بقوة النفس	Seretide Accuhaler
محلول نفولايزر	Nebulizer	يُحوّل لضباب بجهاز	للأطفال وشديدي الربو
بخاخ أنفي	Nasal Spray	يُرش في الأنف	فلونيكازون أنفي ((Flonase

تقنية استخدام MDI الصحيحة (خمس خطوات)

1. هزّ البخاخ جيداً
2. ازفر هواء الرئة كاملاً
3. ضع المسنّة في الفم وأغلق شفّتيك
4. اضغط وابدأ الشهيق ببطء في نفس الوقت
5. احبس النّفس 10 ثوان ثم ازفر

5. أشكال الحقن (Injectable Forms)

المسار	الاختصار	السرعة	مثال
وريدي	IV	فوري ← الأسرع	المضادات الحيوية الشديدة
عضلي	IM	15-30 دقيقة	الأنسولين القديم، اللقاحات
تحت الجلد	SC / SQ	30-60 دقيقة	الأنسولين، الهيبارين
داخل الجلد	ID	بطيء	اختبار التوبركولين
داخل المفصل	Intra-articular	موضعي	كورتيزون للمفصل
داخل العمود	Intrathecal	مباشر للسائل النخاعي	تخدير شوكي

6. الأنظمة العابرة للجلد

Transdermal Systems))

الدواء يعبر الجلد ويصل للدم — يتجنب تأثير المرور الأول في الكبد.

المنتج	الدواء	الاستخدام	مدة اللاصقة
Duragesic Patch	فنتانيل	ألم مزمن شديد	72 ساعة
Nitro-Dur	نيتروغليسرين	وقاية من الذبحة	12-14 ساعة
Estraderm	إسترايول	علاج هرموني للإناث	3-4 أيام
Nicotinell	نيكوتين	الإقلاع عن التدخين	24 ساعة
Exelon Patch	ريفاستيغمين	الزهايمر	24 ساعة

7. قواعد ذهبية لكل فني صيدلاني

الموقف	القاعدة
قرص SR/XR/ER/LA	لا يُكسر أبداً
معلق	يُرج دائماً قبل الاستخدام
كبسولة لينة ((Softgel	لا تُفتح أبداً
لبوس مستقيمي	يُحفظ بالثلاجة
بخاخ الاستنشاق	يُهزّ قبل الاستخدام ((MDI
حقنة IV	لا تُعطى IM والعكس صحيح
قرص تحت اللسان	لا يُبلع — يُوضع تحت اللسان

ملخص بالأشكال والإيجابيات

الشكل	ميزة رئيسية	عيب رئيسي
قرص	سهل، دقيق، رخيص	يحتاج بلعاً
كبسولة	يخفي الطعم السيئ	أعلى
سائل	مناسب للأطفال	جرعة أقل دقة، مدة حفظ أقصر
بخاخ	مباشر للرئة	يحتاج تقنية صحيحة
لاصقة	جرعة منتظمة 24-72 ساعة	حساسية جلدية
حقن	امتصاص كامل وفوري	مؤلم، يحتاج تعقيم
لبوس	يتجاوز المعدة	غير مريح، امتصاص متغير

القسم الأول — الأشكال الصيدلانية · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

قراءة الوصفة الطبية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: قراءة الوصفة الطبية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

الوصفة الطبية هي الوثيقة القانونية التي تعمل بها كل يوم. قراءتها بشكل صحيح ليست مهارة — هي واجب مهني.

1. مكوّنات الوصفة الطبية الكاملة

اسم الطبيب + تخصصه + رقم ترخيصه

عنوان العيادة + رقم الهاتف

اسم المريض: التاريخ

العمر: الوزن (للأطفال)

R (Rx)

اسم الدواء + الجرعة + الشكل الصيدلاني 1.

التعليمات (متى، كيف، كم مرة): sig:

الكمية المصروفة Disp:

هل يُجَدِّد وكم مرة؟ Refill:

توقيع الطبيب

2. الاختصارات اللاتينية الكاملة — الجدول

الرئيسي

🕒 التكرار والتوقيت

الاختصار	اللاتيني الأصل	المعنى
QD أو OD	Quaque die / Once daily	مرة واحدة يومياً
BID أو BD	Bis in die	مرتان يومياً
TID أو TDS	Ter in die	ثلاث مرات يومياً
QID أو QDS	Quater in die	أربع مرات يومياً
Q4H	Quaque 4 hora	كل 4 ساعات
Q6H	Quaque 6 hora	كل 6 ساعات
Q8H	Quaque 8 hora	كل 8 ساعات
Q12H	Quaque 12 hora	كل 12 ساعة
Q24H	Quaque 24 hora	كل 24 ساعة
QOD	Quaque other day	كل يومين (يوم نعم يوم لا)
HS	Hora somni	عند النوم
AM	Ante meridiem	صباحاً
PM	Post meridiem	مساءً
PRN	Pro re nata	عند الحاجة / عند الألم
STAT	Statim	فوراً — الآن
SOS	Si opus sit	عند الضرورة (مرة واحدة)

❓ العلاقة بالأكل

الاختصار	اللاتيني	المعنى
AC	Ante cibum	قبل الأكل
PC	Post cibum	بعد الأكل
CC	Cum cibis	مع الأكل
IC	Inter cibos	بين الوجبات
HS	Hora somni	قبل النوم

طريقة الإعطاء

الاختصار	المعنى
PO	فموي — عن طريق الفم ((Per Os
SL	تحت اللسان ((Sublingual
PR	شرجي — مستقيمي ((Per Rectum
PV	مهبلية ((Per Vaginal
IV	وريدي ((Intravenous
IM	عضلي ((Intramuscular
SC أو SQ	تحت الجلد ((Subcutaneous
ID	داخل الجلد ((Intradermal
TOP	موضعي ((Topical
INH	استنشاق ((Inhalation
NAS	أنفي ((Nasal
OD	العين اليمينية ((Oculus Dexter
OS	العين اليسرى ((Oculus Sinister
OU	كلتا العينين ((Oculus Uterque
AD	الأذن اليمينية ((Auris Dextra
AS	الأذن اليسرى ((Auris Sinistra
AU	كلتا الأذنين ((Auris Utraque

٢؟ الكميات والأشكال

الاختصار	المعنى
Tab	قرص ((Tablet
Cap	كبسولة ((Capsule
Amp	أمبولة ((Ampoule
Vial	قارورة حقن
Supp	لبوس ((Suppository
Oint	مرهم ((Ointment
Soln	محلول ((Solution
Susp	معلق ((Suspension
Syr	شراب ((Syrup
gtts	قطرات ((Guttae
gtt	قطرة واحدة
Disp	صرف / الكمية الإجمالية ((Dispense
Sig	التعليمات للمريض ((Signa
Rx	وصفة طبية ((Recipe
Mitte	أرسل / صرف
Rep أو Refill	يُجَدَّد
NR	لا يُجَدَّد ((No Refill

❓ وحدات القياس

الرمز	المعنى
mg	ملليغرام
mcg أو μg	ميكروغرام (1/1000 ملليغرام)
g	غرام
kg	كيلوغرام
mL	مللتر
L	لتر
IU	وحدة دولية (International Unit)
mEq	ميلي مكافئ (للكهارل)
mmol	ميلي مول
%	نسبة مئوية
ppm	جزء في المليون

⚠️ **تحذير خطير:** μg و mcg تعني نفس الشيء. لكن إذا كُتبت μg وفُرئت خطأ كـ mg → الجرعة أكبر 1000 مرة! لهذا كثير من الأنظمة تطلب كتابة mcg بوضوح.

3. أخطاء القراءة الأكثر خطورة

هذه الأخطاء تسببت بحوادث حقيقية وفيات في الصيدليات:

الكتابة المشكوك فيها	الخطأ الممكن	القراءة الصحيحة
U (لا Units)	قُرئت 0 → الجرعة $10 \times$	اكتب "units" بالكامل
IU (International Units))	قُرئت IV → ويريد	اكتب "international units"
μg	قُرئت mg → $1000 \times$	اكتب mcg
5 mg (نقطة قبل الرقم)	قُرئت 5 mg → $10 \times$	اكتب دائماً 0.5 mg
1.0 mg (صفر بعد النقطة)	قُرئت 10 mg → $10 \times$	اكتب 1 mg بدون صفر
qd أو qod	يُخلط بينهما بسهولة	اكتب "daily" أو "every other day"
MS	يعني مورفين سلفات أو ماغنيسيوم سلفات	يجب التوضيح
MTX	ميثوتريكسات — جرعة خاطئة قاتلة	اكتب الاسم كاملاً

4. كيف تقرأ الوصفة خطوة بخطوة

الخطوة 1 - تحقق من هوية المريض

الاسم + تاريخ الميلاد / العمر

الخطوة 2 - تحقق من صلاحية الوصفة

التاريخ + توقيع الطبيب + رقم الترخيص

الخطوة 3 - اقرأ اسم الدواء بعناية

هل تعرفه؟ هل الخط واضح؟ إذا شككت - اتصل بالطبيب

الخطوة 4 - تحقق من الجرعة

هل هي منطقية للعمر والوزن؟ هل تتجاوز الحد الأقصى؟

(Sig) الخطوة 5 - افهم التعليمات

ترجم الاختصارات، تأكد أن التعليمات واضحة للمريض

الخطوة 6 - راجع التفاعلات الدوائية

خاصة إذا كانت وصفة متعددة أو مريض مزمن

الخطوة 7 - تحقق من التاريخ الانتهاء وموانع الاستخدام

حمل، حساسية، أمراض مصاحبة

5. أمثلة وصفات حقيقية وترجمتها

مثال 1 — بسيط

Amoxicillin 500 mg Cap

Sig: 1 cap TID × 7 days PC

Disp: 21 caps

NR

الترجمة: أموكسيسيلين 500 ملغ — كبسولة واحدة ثلاث مرات يومياً لمدة 7 أيام بعد الأكل — صرف 21 كبسولة — لا يُجدد.

مثال 2 — متوسط

Metoprolol 50 mg Tab

Sig: $\frac{1}{2}$ tab BID × 2 weeks, then 1 tab BID

Disp: 60 tabs

Refill × 2

الترجمة: ميتوبرولول 50 ملغ — نصف قرص مرتين يومياً لأسبوعين، ثم قرص كامل مرتين يومياً — 60 قرصاً — يُجدد مرتين.

🔔 ملاحظة: الجرعة تبدأ منخفضة ثم ترتفع (= Titration معايرة تدريجية)، شائعة في حاصرات بيتا وأدوية الضغط.

مثال 3 — للأطفال

Amoxicillin 250 mg/5 mL Susp

Sig: 7 mL TID × 10 days AC

Disp: 150 mL

NR

Shake well before use

الترجمة: معلق أموكسيسيلين — 7 مللتر 3 مرات يومياً لمدة 10 أيام قبل الأكل — يُرَجَّ جيداً — لا يُجَدَّد.

مثال 4 — متعدد الأدوية ((Polypharmacy

1. Metformin 500 mg Tab — 1 tab BID CC
2. Atorvastatin 20 mg Tab — 1 tab QD HS
3. Amlodipine 5 mg Tab — 1 tab QD AM
4. Aspirin 100 mg Tab — 1 tab QD CC

الترجمة:

1. ميتفورمين — قرص مع الأكل مرتين يومياً
2. أتورفاستاتين — قرص مرة يومياً عند النوم (الكبد يصنع الكوليسترول ليلاً)
3. أملوديبين — قرص صباحاً
4. أسبرين — قرص مع الأكل يومياً

6. متى تتصل بالطبيب وترفض الصرف؟

الموقف	الإجراء
الخط غير مقروء وأنت غير متأكد	اتصل بالطبيب — لا تخمّن
الجرعة تتجاوز الحد الأقصى المعروف	اتصل للتأكد قبل الصرف
المريض لديه حساسية من الدواء الموصوف	لا تصرف — أبلغ الطبيب فوراً
الدواء له تفاعل خطير مع دواء آخر للمريض	أبلغ الطبيب وانتظر تأكيده
الوصفة منتهية الصلاحية	لا تصرف
الوصفة تبدو مزورة أو معذلة	لا تصرف وأبلغ المسؤول
طلب الكمية غير طبيعية من مادة خاضعة للرقابة	تحقق من الجهة المختصة

ملخص الاختصارات الأكثر استخداماً

QD/OD = يومياً	BID = مرتين	TID = ثلاثاً	QID = أربعاً
AC = قبل الأكل	PC = بعد الأكل	CC = مع الأكل	HS = عند النوم
PRN = عند الحاجة	STAT = فوراً		
PO = فموي	IV = وريدي	IM = عضلي	SC = تحت الجلد
OD = العين اليمنى	OS = اليسرى	OU = كليهما	

القسم الأول — قراءة الوصفة الطبية · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

أسماء الأدوية الشائعة

[صورة غلاف توضيحية لفصل: أسماء الأدوية الشائعة]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

القاعدة: الاسم الجنيسي هو هويتك المهنية. الاسم التجاري هو ما يعرفه المريض. أنت بحاجة لكليهما.

1. الفرق بين الجنيسي والتجاري

الاسم التجاري ((Brand	الاسم الجنيسي ((Generic	
اسم الشركة المصنعة للمنتج	الاسم الدولي للمادة الفعالة	التعريف
بحرف كبير أو علامة ®	بحرف صغير	الكتابة
®Adol ,®Tylenol ,®Panadol	paracetamol	المثال
أعلى	أرخص عموماً	السعر
شركة واحدة	قد يكون متعدد المصادر	التوفر
نفس المادة الفعالة	متكافئة بيولوجياً	الفعالية

2. الأدوية الأكثر وصفاً — مرتبة بالتخصص

المسكنات وخافضات الحرارة

الجرعة الشائعة	الأسماء التجارية الشائعة	الجنسي
mg 500-1000	,Calpol ,Adol ,Tylenol ,Panadol Dexamol	Paracetamol
mg 400-600	Motrin ,Nurofen ,Advil ,Brufen	Ibuprofen
mg 50	Diclac ,Cataflam ,Voltaren	Diclofenac
mg 250-500	Flanax ,Aleve ,Naprosyn	Naproxen
mg 500	Ponstan	Mefenamic acid
mg 200	Celebrex	Celecoxib
mg 60-120	Arcoxia	Etoricoxib
mg 50-100	*Tramacet ,Ultram ,Tramal	Tramadol
mg 75-500	Disprin ,Aspocid ,Aspirin	Aspirin

*Tramacet ترامادول + باراسيتامول

المضادات الحيوية الشائعة

الجرعة الشائعة	الأسماء التجارية	الجنسي
3 × mg 250-500	Trimox ,Amoxil	Amoxicillin
2-3 × mg 625	Clavamox ,Augmentin	Amoxicillin + Clavulanate
mg 500 يوم 1، ثم 250 mg	Azitra ,Zithrocin ,Zithromax	Azithromycin
2 × mg 250-500	Klaricid ,Klacid	Clarithromycin
2 × mg 250-750	Cifran ,Cipro ,Ciprobay	Ciprofloxacin
2 × mg 250-500	Zinacef ,Zinnat	Cefuroxime
1-2 g IV/IM يومياً	Rocephin	Ceftriaxone
2 × mg 100	Doxine ,Vibramycin	Doxycycline
3 × mg 400-500	Metrogyl ,Flagyl	Metronidazole
2 × قرص DS	Seprin ,Bactrim	Trimethoprim-SMX
4 × mg 250-500	Floxapen	Flucloxacillin
1 g IV 2 × (يُراقب التركيز)	Vancocin	Vancomycin

❓ القلب والضغط والكوليسترول

الجنسي	التجاري	الاستخدام
Amlodipine	Istin ,Amlopin ,Norvasc	ضغط
Atenolol	Tenormin	ضغط، ذبحة
Metoprolol	Seloken ,Betaloc ,Lopressor	ضغط، قصور قلبي
Bisoprolol	Bisocard ,Concor	قصور قلبي
Lisinopril	Prinivil ,Zestril	ضغط
Enalapril	Renitec ,Vasotec	ضغط
Ramipril	Ramipace ,Tritace ,Altace	ضغط
Losartan	Lozar ,Cozaar	ضغط
Valsartan	Diovan	ضغط
Atorvastatin	Torvast ,Lipitor	كوليسترول
Rosuvastatin	Crestor	كوليسترول
Simvastatin	Simvotin ,Zocor	كوليسترول
Furosemide	Lasix	مدر
Hydrochlorothiazide	HydroDiuril ,Esidrex	مدر
Spironolactone	Aldactone	مدر موقر بوتاسيوم
Warfarin	Marevan ,Coumadin	تخفيف الدم
Aspirin 100 mg	Cardiprin ,Aspicid	تخفيف الدم
Clopidogrel	Plavix	مضاد الصفائح
Digoxin	Lanoxin	قصور قلبي، رجفان أذيني
Nitroglycerin	Nitromint ,Nitrostat	ذبحة — تحت اللسان
Isosorbide mononitrate	Monoket ,Imdur	وقاية من الذبحة

أدوية السكري

الجنسي	التجاري	الفئة
Metformin	Dianben ,Glucophage	بيغوانيد
Glibenclamide	Euglucon ,Daonil	سلفونيل يوريا
Glimepiride	Amaryl	سلفونيل يوريا
Gliclazide	Diamicron	سلفونيل يوريا
Sitagliptin	Januvia	DPP-4 inhibitor
Vildagliptin	Galvus	DPP-4 inhibitor
Empagliflozin	Jardiance	SGLT-2 inhibitor
Dapagliflozin	Forxiga	SGLT-2 inhibitor
Liraglutide	Victoza	GLP-1 agonist
Semaglutide	Rybelsus ,Ozempic	GLP-1 agonist
Insulin Glargine	Toujeo ,Lantus	أنسولين طويل المفعول
Insulin Aspart	NovoRapid	أنسولين سريع
Insulin Lispro	Humalog	أنسولين سريع
Insulin NPH	Humulin N ,Insulatard	أنسولين متوسط

الجينيبي	التجاري	الاستخدام
Fluoxetine	Fluctin ,Prozac	اكتئاب
Sertraline	Lustral ,Zoloft	اكتئاب، قلق
Escitalopram	Cipralex ,Lexapro	اكتئاب، قلق
Citalopram	Cipramil ,Celexa	اكتئاب
Paroxetine	Seroxat ,Paxil	اكتئاب، قلق، PTSD
Venlafaxine	Effexor	اكتئاب، قلق مزمن
Duloxetine	Cymbalta	اكتئاب، نيوروبائي
Amitriptyline	Elavil ,Tryptizol	اكتئاب، ألم مزمن، وقاية صناع نصفي
Diazepam	Valium	قلق، تشنج عضلي
Alprazolam	Xanax	قلق، نوبات هلع
Clonazepam	Klonopin ,Rivotril	قلق، صرع
Zolpidem	Ambien ,Stilnox	أرق
Quetiapine	Seroquel	ذهان، اكتئاب ثنائي
Olanzapine	Zyprexa	ذهان، هوس
Risperidone	Risperdal	ذهان
Haloperidol	Haldol	ذهان حاد
Carbamazepine	Tegretol	صرع، ألم عصبي
Valproic acid	Epilim ,Depakine	صرع، هوس
Phenytoin	Dilantin	صرع
Levetiracetam	Keppra	صرع
Gabapentin	Neurontin	ألم عصبي، صرع
Pregabalin	Lyrica	ألم عصبي، قلق
Methylphenidate	Concerta ,Ritalin	ADHD
Donepezil	Aricept	الزهايمر
Sumatriptan	Imitrex ,Imigran	صناع نصفي حاد

الجنسي	التجاري	الاستخدام
Propranolol	Inderal	وقاية صاع نصفي، قلق

❓ الجهاز التنفسي والحساسية

الجنسي	التجاري	الاستخدام
Salbutamol	Salamol ,Ventolin	موسع شعب — ربو حاد
Salmeterol	Serevent	موسع شعب طويل المفعول
Formoterol	Oxeze ,Foradil	موسع شعب طويل
Tiotropium	Spiriva	COPD
Fluticasone	Flonase (,Flixotide أنفي)	مضاد التهاب — ستيرويد
Budesonide	Rhinocort ,Pulmicort	ستيرويد استنشاق / أنفي
Salmeterol + Fluticasone	Advair ,Seretide	ربو مزمن
Formoterol + Budesonide	Symbicort	ربو مزمن، COPD
Montelukast	Singulair	حساسية، ربو
Cetirizine	Reactine ,Zyrtec	حساسية — لا يسبب نعاساً
Loratadine	Clarityne ,Claritin	حساسية — لا يسبب نعاساً
Fexofenadine	Telfast ,Allegra	حساسية — لا يسبب نعاساً
Diphenhydramine	Benadryl	حساسية — يسبب نعاساً / منوم
Chlorphenamine	Piriton	حساسية — جيل أول
Ipratropium	Atrovent	COPD، طوارئ الربو
Prednisolone	Deltacortril	ربو حاد، التهابات

؟ الجهاز الهضمي

الجنسي	التجاري	الاستخدام
Omeprazole	Prilosec ,Losec	حموضة، حماية المعدة
Esomeprazole	Nexium	حموضة
Pantoprazole	Protium ,Pantoloc	حموضة
Lansoprazole	Prevacid	حموضة
Ranitidine	Zantac	حاصر H2 — حموضة
Famotidine	Pepcid	حاصر H2
(Mg+Al)Antacid	Gaviscon ,Maalox	تعاقل حمض فوري
Metoclopramide	Reglan ,Maxolon	غثيان، تسريع إفراغ المعدة
Ondansetron	Emeset ,Zofran	غثيان شديد، غثيان الكيماوي
Domperidone	Motilium	غثيان، ببطء إفراغ المعدة
Loperamide	Imodium	إسهال
Bismuth subsalicylate	Pepto-Bismol	إسهال، H. pylori
Lactulose	Duphalac	إمساك مزمن
Bisacodyl	Dulcolax	إمساك
Senna	Senokot	إمساك
Psyllium	Fybogel ,Metamucil	ألياف — إمساك
(Scopolamine)Hyoscine	Buscopan	تشنج معوي
Mesalazine	Pentasa ,Asacol	التهاب القولون التقرحي

❓ العظام والمفاصل

الجنسي	التجاري	الاستخدام
Alendronate	Fosamax	هشاشة العظام
Risedronate	Actonel	هشاشة العظام
Calcium + Vitamin D	Oscal ,Sandocal	هشاشة، نقص كالسيوم
Methotrexate	Trexall ,Methofar	روماتويد، الصدفية
Hydroxychloroquine	Plaquenil	روماتويد، الذأب
Colchicine	Colcrys	نقرس حاد
Allopurinol	Lopurin ,Zyloric	منع النقرس المزمن
Febuxostat	Adenuric	نقرس — بديل ألوبيورينول

❓ الفيتامينات والمكملات الشائعة

الجنسي	التجاري / الشائع	الاستخدام
Folic acid	Folate ,Folicap	الحمل، فقر الدم
(Iron) Ferrous sulfate	Fergon ,Feosol	فقر الدم بالحديد
Vitamin D3	Vigantol ,Devit	نقص فيتامين D
(Vitamin B12) Cyanocobalamin	Cobavit ,B12	نقص B12، أعصاب
Vitamin C	Cevit ,Redoxon	مناعة، فلورات
Omega-3	Omacor ,Maxepa	قلب، دهون ثلاثية
Zinc	Zincomed ,Zinc sulfate	مناعة، جروح
Magnesium	Slow-Mag ,Magnesia B6	تشنج عضلي، صواعق نمفي
Calcium	Calcium Sandoz	عظام، نقص كالسيوم
Biotin	Biotine H ,Biotine	شعر وأظافر

3. الأدوية المركبة الشائعة (Combination Drugs))

الاسم التجاري	المكونات	الاستخدام
Augmentin	Amoxicillin + Clavulanate	عدوى مقاومة
Seretide / Advair	Salmeterol + Fluticasone	ربو مزمن
Symbicort	Formoterol + Budesonide	ربو مزمن
Zestoretic	Lisinopril + HCTZ	ضغط
Hyzaar	Losartan + HCTZ	ضغط
Glucovance	Metformin + Glibenclamide	سكري
Tramacet	Tramadol + Paracetamol	ألم
Codipront	Codeine + Phenyltoloxamine	سعال
Co-trimoxazole	Trimethoprim + Sulfamethoxazole	عدوى
Entresto	Sacubitril + Valsartan	قصور قلبي

4. الأدوية التي تُخلط أسماؤها — تحذير

هذه الأدوية متشابهة في الاسم لكن مختلفة تماماً:

الفرق	الزوج المتشابه
ARB للضغط vs ستاتين للكوليسترول	Lovastatin vs Losartan
مسكن vs NSAIDs مضاد اكتئاب	Celexa vs Celebrex
مزيل قلق vs روماتويد/ملاريا	Hydroxychloroquine vs Hydroxyzine
حموضة vs قلق/بنزوديازيبين	Alprazolam)Xanax (vs Ranitidine)Zantac (
حساسية ((Cetirizine vs ذهان ((Olanzapine	Zyprexa vs Zyrtec
سكري vs مضاد حيوي/طفيليات	Metronidazole vs Metformin
كيماوي — جرعات مختلفة تماماً	Vinblastine vs Vincristine

❗ كل الأزواج أعلاه تسببت في حوادث طبية موثقة. إذا شككت في الاسم — تأكد قبل الصرف.

ملخص نهائي — الأدوية العشرون الأكثر صرفاً عالمياً

#	الجنسي	الاستخدام
1	Atorvastatin	كوليسترول
2	Metformin	سكري
3	Amlodipine	ضغط
4	Omeprazole	حموضة
5	Lisinopril	ضغط
6	Metoprolol	ضغط، قلب
7	Levothyroxine	غدة درقية
8	Amoxicillin	مضاد حيوي
9	Sertraline	اكتئاب
10	Paracetamol	ألم، حمى
11	Losartan	ضغط
12	Azithromycin	مضاد حيوي
13	Salbutamol	ربو
14	Ibuprofen	ألم، التهاب
15	Aspirin 100 mg	قلب، وقاية جلطات
16	Cetirizine	حساسية
17	Furosemide	مدر
18	Fluoxetine	اكتئاب
19	Clopidogrel	تخفيف دم
20	Gabapentin	ألم عصبي

القسم الأول — أسماء الأدوية الشائعة · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

القسم الثاني

المحتوى الرئيسي — السيناريوهات

الجهاز العصبي والألم

[صورة غلاف توضيحية لفصل: الجهاز العصبي والألم]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

تذكر دائماً: الألم مش تشخيص — هو عرض. شغلتك تفهم مصدره وتقدّر تساعد أو تحوّل.

الموضوع الأول — الصداع

المريض: "يا دكتور عندي صداع من الصبح، آخذ إيه؟"

اسأل أولاً

- الصداع فين بالضبط؟ كله، جانب، وسط الجبهة، ورا الرأس؟
- من امتى؟ ساعة ولا أيام؟
- فيه حرارة معاه؟
- فيه إجهاد أو قلة نوم؟
- شرب ميه كافي النهارده؟ (الجفاف أكثر سبب للصداع)
- بياخد دواء ضغط أو أى أدوية مزمنة؟
- الصداع ده جديد ولا بييجيه كثير؟

مكان الصداع	الاحتمال الأول
الجبهة كلها	توتر، جفاف، إجهاد عين
جانب واحد + غثيان + حساسية للضوء	صداع نصفي ((Migraine

• وسط الجبهة + احتقان أنف | التهاب جيوب أنفية |

ورا الرقبة والرأس	توتر عضلي أو ضغط دم مرتفع
الصداع الأشد في حياته، مفاجئ	طوارئ — نزيف في المخ

التوصية

- صداع التوتر العادي:
- **Paracetamol 500-1000 mg** — الخيار الأول الآمن
- **Ibuprofen 400 mg** — أفضل لصداع التوتر إذا مغيث موانع
- شرب ماء كثير لو الصداع من الجفاف
- راحة في مكان هادي
- صداع التوتر المتكرر:
- مسكن **Caffeine +** (القهوة بتساعد كثير)
- أدوية مركبة: **(Paracetamol + Caffeine)** ميجرال، سيتيل

تحذير — أحوله فوراً

- الصداع الأشد في حياته ومفاجئ ((thunderclap headache
- صداع مع تصلب الرقبة وحمى (تفكير في التهاب سحايا)
- صداع مع ضعف في وجه أو ذراع أو صعوبة كلام
- صداع مع تغيير في الرؤية
- صداع بعد إصابة في الرأس

المريض: "يا دكتور عندي ميجرين من يومين، نص رأسي بيضرب وعندي غثيان ومش قادر أبص في النور"

اسأل أولاً

- عنده تشخيص بالميجرين من قبل؟
- بياخد دواء خاص بيه؟
- الألم بيضرب (نابض) ولا ثابت؟
- فيه أورة قبلها (تغيير بصري، وخز)؟
- جرب الدواء اللي بياخده وما اشتغلش؟

التوصية

- نوبة خفيفة-متوسطة (بدون دواء تخصصي):
- **Metoclopramide 10 mg + Ibuprofen 400-600 mg** (للغثيان وبيزود امتصاص المسكن)
- مكان هادي مظلم ومهدوء
- كمادة باردة على الرأس
- نوبة متوسطة-شديدة:
- **(Sumatriptan إيمجران):** 50-100 mg فموي، أو بخاخ أنفي 20 mg
- بيأثر خلال 30-120 دقيقة
- لو عاد الصّاع خلال 24 ساعة: جرعة ثانية
- يحتاج وصفة طبية
- وقاية (للي عنده نوبات كثيرة — أكثر من 4 في الشهر):
- **Propranolol 40-80 mg** يومياً — الأكثر استخداماً في مصر
- **Amitriptyline 25-50 mg** ليلاً
- **Topiramate** — يحتاج طبيب

تحذير — أحوله فوراً

- الميجرين اتغير في طبيعته أو شدته
- مش ردّ على أي علاج
- نوبات أكثر من مرتين في الأسبوع

لا تعطي

- أوبيويدات للميجرين — بيسبب صاع من الإفراط في المسكنات
- Sumatriptan لمريض قلبي أو ضغط غير منضبط أو حامل

الموضوع الثاني — ألم الظهر والعضلات

المريض: "يا دكتور ظهري بيأجيني من امبارح، مشيت كثير وحملت حاجة ثقيلة"

اسأل أولاً

- الألم بيمشي في الرجل؟ ((sciatic pain
- فيه تنميل أو وخز في الأرجل؟
- قادر يمشي ويتحرك؟
- فيه إشكالية في التبول؟ (خطر — cauda equina)
- حادث أو وقعة؟

الأعراض	الاحتمال
ألم محدود في الظهر بعد مجهود	توتر عضلي ((Muscle strain
ألم ينزل في الأرجل مع وخز	عرق النسا ((Sciatica
ألم مع إشكالية بول أو براز	طوارئ عصبية
ألم في شخص مسن + إصابة بسيطة	احتمال كسر فقرة

التوصية

- ألم عضلي بسيط:
- **Ibuprofen 400 mg** × 3 بعد الأكل — الأفضل للألم العضلي
- (أو **Diclofenac** فولتارين) **50 mg** × 2
- (أو **Cyclobenzaprine** فلكسيبريل) أو (**Methocarbamol** روباكسين) —
مرخي عضل لو فيه تشنج شديد
- فولتارين جل موضعي على منطقة الألم
- كمادة دافئة مهمة جداً:
- كمادة دافئة 20 دقيقة كل ساعتين للألم العضلي
- كمادة باردة أول 48 ساعة لو فيه التهاب حاد
- الراحة:
- راحة نسبية — مش راحة كاملة (الراحة الكاملة بتزيد الألم)
- بدأ يتحرك بعد يوم أو يومين

تحذير — أحوله فوراً

- الألم بيمشي في الأرجل مع وخز أو ضعف
- إشكالية في التبول أو التبرز — طوارئ فورية
- ألم بعد حادث أو وقعة
- الألم مش بيتحسن بعد أسبوع

المريض: "يا دكتور رقبتني مشدودة من شوية، شغلي على كمبيوتر طول اليوم"

التوصية

- **Ibuprofen 400 mg أو Paracetamol 1000 mg للألم**
- **جل فولتارين أو جل إيبوبروفين موضعي**
- **تمارين بسيطة للرقبة: دوران برفق، إمالة للجانب والأمام**
- **تعديل وضعية الشاشة والكرسي**
- **كمادة دافئة على الرقبة والكتف**

الموضوع الثالث — الألم العصبي

المريض: "يا دكتور أنا عندي سكري وبيجيني وخز ونار في قدامي بالليل مش قادر أنام"

اسأل أولاً

- السكر منضبط؟ كام آخر تحليل HbA1c؟
- من امتى؟
- بياخد أى علاج للألم ده؟
- الألم بيزيد بالليل؟

التشخيص

- اعتلال الأعصاب السكري ((Diabetic Neuropathy: الأكثر شيوعاً في مصر بين مرضى السكر
- ألم نابض أو حرقان أو وخز في القدمين، بيزيد بالليل

التوصية

- لا تعطى NSAIDs أو باراسيتامول — مش هيفيدوا في الألم العصبي
- خط أول:
- (Gabapentin نيورونتين): 300 mg ليلاً بداية، تزيد تدريجياً لـ 300 mg × 3
- يحتاج وصفة طبية
- (Pregabalin ليريكا): 75 mg × 2 — أفضل لبعض المرضى
- خط ثانى:
- Amitriptyline 10-25 mg ليلاً
- (Duloxetine سيمبالتا): 60 mg يومياً — يحتاج وصفة
- مكملات مهمة:
- (Alpha Lipoic Acid ثيوكتاسيد): 600 mg يومياً — مضاد أكسدة للأعصاب
- فيتامين B12: مهم خاصة لو بياخد ميتفورمين (بيقلل امتصاص B12)
- (فيتامين B1 + B6) مجمع فيتامين B

تحذير — أحوّله فوراً

- الألم شديد ومش متحكم فيه
- فيه ضعف في الأرجل
- جروح في القدم مش بتتعالج

المريض: "يا دكتور عندي طفح وحبوب في جني زي نصف دايرة وبأجع جداً كأنه نار"

اسأل أولاً

- من امتي؟ (3 أيام أو أقل من ظهور الطفح؟)
- الطفح محاط في ناحية واحدة من الجسم (يمين أو شمال بس؟)
- فيه حمى؟
- كم عمره؟ عنده مناعة منخفضة؟

التوصية

- خلال أول 72 ساعة من الطفح:
- لازم وصفة طبية لمضاد فيروسي:
- Acyclovir 800 mg × 5 يومياً × 7 أيام
- أو Valacyclovir 1000 mg × 3 × 7 أيام
- البدء مهم جداً خلال 72 ساعة — بعدها فائدته أقل
- للألم:
- Paracetamol + Ibuprofen
- Gabapentin للألم العصبي الشديد
- للطفح موضعياً:
- كاليمين لوشن ((Calamine — يبرد ويهدئ
- لا تضع كريم الهربس موضعياً — ما بيغيدش

تحذير — أحوله فوراً

- الطفح جاور العين (هربس العين — خطر فقدان البصر)
- الأعراض عند شخص كبير أو ضعيف المناعة
- ألم شديد جداً قبل أو بعد الطفح

الموضوع الرابع — ألم الأسنان والحلق

الحالة 7 — ألم أسنان

المريض: "يا دكتور عندي ضرسة بيأجيني جداً من إمبارح بالليل"

اسأل أولاً

- الألم مستمر ولا ييجي ويروح؟
- الخد منتفخ؟
- فيه حرارة؟
- الألم بيزيد مع الأكل الحار أو البارد؟

التوصية

- مسكن فوري:
- Ibuprofen 400-600 mg — الأفضل لألم الأسنان
- Paracetamol 1000 mg أو
- أو الاثنين مع بعض لو الألم شديد
- موضعي مؤقت:
- (Benzocaine gel، أوراجيل) — مخدر موضعي
- (Clove oil زيت القرنفل) — قطرة على القطن ووضع على الضرس
- ارسله للطبيب الأسنان:
- أي ألم أسنان محتاج دكتور أسنان — الدواء مسكن مؤقت فقط

تحذير — أحوله فوراً

- الخد منتفخ + حرارة = خراج في الأسنان — خطر ينتشر للرقبة
- صعوبة في البلع أو فتح الفم

المريض: "حلقي بيأجعني وصعب ابلع من امبارح"

اسأل أولاً

- فيه حرارة؟ كام؟
- اللوزتين منتفخين؟ أو فيه بقع بيضاء عليهم؟
- فيه كحة وزكام معاه؟ (يشير للفيروس)
- فيه رشح في الأنف؟

الأعراض	الاحتمال
حلق بيأجع + زكام + كحة + بدون حرارة عالية	فيروسي — 90% من الحالات
حلق أحمر + لوزتين منتفختين + بقع بيضاء + حرارة عالية + بدون كحة	بكتيري (عقدية) — محتاج مضاد

التوصية

- فيروسي (الغالبية):
- (Benzydamineتانتوم): بخاخ أو غرغرة — مضاد التهاب موضعي — كل 3 ساعات
- Paracetamol للألم والحرارة
- غرغرة بملح ودافي: فعالة ومثبتة
- (Pastillesحلولى الحلق): تهدئ التهيج
- بكتيري محتمل:
- حوِّله للطبيب لأخذ مسحة الحلق وتحديد نوع البكتيريا
- لو مشخص: Amoxicillin 500 mg $\times 3 \times 10$ أيام

لا تعطي

- مضاد حيوي بناءً على الألم فقط — معظمه فيروسي

الموضوع الخامس — القلق والنوم

المريض: "يا دكتور مش قادر أنام من أسبوع، بييجيني أفكار كثير في الليل"

اسأل أولاً

- من امتي؟ أسبوع ولا أشهر؟
- فيه ضغوط أو مشاكل واضحة؟
- بيشرب قهوة أو شاي كثير في المساء؟
- بيشتغل ليل؟ أو بيتفرج على موبايل قبل النوم؟
- بياخد أي أدوية؟
- فيه أعراض أخرى: حزن، قلق، خفقان؟

التوصية

- أرق عارضي (أقل من أسبوعين):
- (**Diphenhydramine** بيناديريل): مضاد هيستامين بيسبب نعاس — 25-50 mg قبل النوم
- (**Doxylamine** يونيسوم): مثله
- ⚠ لا تستخدم أكثر من أسبوعين — بيسبب تحمل سريع
- **Melatonin**: 1-5 mg قبل النوم بساعة — آمن جداً
- نصائح النوم ((Sleep Hygiene — الأهم:
- نم وصحي في نفس الوقت كل يوم
- اعمل الأوضة باردة ومظلمة
- متستخدمش الموبايل أو الشاشات ساعة قبل النوم
- ماتنامش نهار لو عندك أرق
- قل القهوة والشاي بعد 2 الظهر
- لو الأرق مستمر أكثر من شهر:
- حوله للطبيب — ممكن يحتاج (**Zolpidem** ستيلنوكس) أو علاج للقلق

لا تعطي

- بنزوديازيبينات (ديازيبام، ألبرازولام) بدون وصفة طبية ودون إشراف — إدمان سريع
- تجنب إعطاء أدوية النوم لكبار السن — خطر السقوط

المريض: "يا دكتور باحسس بقلق وضربات قلبي بتزيد، خايف على صحتي"

اسأل أولاً

- الخفقان ده جديد ولا من زمان؟
- فيه إغماء أو ضيق تنفس؟ (لازم تستبعد قلب أول)
- فيه مواقف بتسبب القلق؟
- فيه أفكار حزينة أو يأس؟
- بياخد دواء؟ قهوة كثير؟

التوصية

- قلق خفيف-متوسط:
- (Hydroxyzine أتراكس): 25-50 mg — مزيل قلق غير مسبب إدمان —
بيحتاج وصفة
- **Magnesium** 200-400 mg يومياً — بيهدي الجهاز العصبي
- تقنيات التنفس: تنفس عميق بطيء 4-7-8
- لو فيه قلق مزمن أو أعراض اكتئاب:
- حوله لطبيب نفسي أو نفسياتي — قد يحتاج SSRIs أو علاج سلوكي معرفي

تحذير — أحوله فوراً

- خفقان مع إغماء أو ضيق تنفس (استبعد قلب أولاً)
- أفكار إيذاء النفس

ملخص سريع للفصل

الشكوى	أول سؤال	الخط الأول
صداع	فين بالظبط؟ حرارة؟	باراسيتامول أو إيبوبروفين
ميجرين	نابض مع غثيان؟	إيبوبروفين + ماكسولون
ألم ظهر	بيمشي للأرجل؟	إيبوبروفين + مرخي عضل
وخز قدم سكري	السكر منضبط؟	Alpha Lipoic + Gabapentin
ألم حلق	فيه حرارة ويقع بيضاء؟	تانتوم + طبيب للبكتيري
أرق	من امتى؟	Melatonin + نفاقة نوم

❓ المبدأ الذهبي في الألم:

اسأل: أين؟ منذ متى؟ طبيعته؟ ما الذي يزيده ويخففه؟

الألم اللي بيصحى الإنسان من النوم أو اللي مش بيتحسن بالمسكن = طبيب.

الألم العصبي مش بيتعالج بمسكنات عادية.

القسم الثاني — الجهاز العصبي والألم · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

القلب والأوعية الدموية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: القلب والأوعية الدموية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

تذكر: أمراض القلب والضغط هي الأكثر شيوعاً في مصر. مريض الضغط والكوليسترول يجبى الصيدلية كل شهر. لازم تعرف تتعامل معاه كمتخصص.

الموضوع الأول — ضغط الدم المرتفع

المريض: "يا دكتور قاسوا ضغطي في الصيدلية وطلع 150/95، أنا مش حاسس بحاجة"

اسأل أولاً

- دي قراءة واحدة ولا اتقاست مرتين في أوقات مختلفة؟
- فيه أي أعراض؟ صداع، دوخة، ضيق تنفس؟
- فيه تاريخ عيلى بضغط؟
- بياخد أي دواء؟ (بعض الأدوية بترفع الضغط: NSAIDs، بعض الكورتيزون، حبوب منع حمل)
- بياكل ملح كثير؟ بيدخن؟ بيشرب قهوة زيادة؟

التوصية

- لا تصرف دواء ضغط بدون وصفة — الضغط المرتفع يحتاج تقييم طبي لتحديد النوع والدواء المناسب
- أرسله للطبيب عشان يقيس الضغط 3 مرات في أوقات مختلفة ويقرر العلاج
- نصائح فورية:
- قلّل الملح الزيادة (أقل من 5 جرام يومياً)
- قلّل القهوة
- اتحرك — 30 دقيقة مشي يومياً
- انقص الوزن لو زيادة

المريض: "يا دكتور عايز أجدد علاج الضغط بتاعي — أملوديبين 5 وليفزينوبريل 10"

اسأل أولاً

- الضغط منضبط على الدواء؟ بقيسه في البيت؟
- فيه أي أعراض: سعال (من الليفزينوبريل)، انتفاخ كاحل (من الأملوديبين)، دوخة (ضغط انخفض)؟
- بياخد الدواء بانتظام؟
- محتاج إعادة أي تحاليل؟

التوصية

- صرف الدواء بوصفة التجديد
- لو بيشكي من سعال جاف: ده من الليفزينوبريل — قوله يراجع طبيبه لتبديله بـ **لوسارتان ((ARB**)
- لو بيشكي من انتفاخ في الكاحل: ده من الأملوديبين — مش خطير لكن يراجع الطبيب لو مزعج
- لو الضغط في البيت باستمرار فوق 140/90 — يراجع الطبيب لتعديل الجرعة
- ذكره: لا يوقف الدواء لو حس بتحسن — ضغط الدم مزمن ومحتاج علاج مستمر

المريض: "يا دكتور صداعي شديد جداً وقست ضغطي 190/115"

اسأل أولاً

- فيه ضيق تنفس؟
- فيه ضعف في وجه أو ذراع؟
- الكلام متأثر؟
- فيه ألم في الصدر؟
- فيه تغيير في الرؤية؟

الحالة	الوصف	الإجراء
Hypertensive Urgency	ضغط >180/120 بدون تلف عضو	خفّض ببطء — طبيب خلال ساعات
Hypertensive Emergency	ضغط >180/120 + تلف عضو (صدر، دماغ، عين)	إسعاف فوراً

التوصية

- لو فيه أي من الأعراض أعلاه → اتصل بإسعاف فوراً (123)
- لو مريض ضغط معروف ونسي دواءه: ياخذ جرعته فوراً ثم يروح للطبيب
- لا تديه Captopril أو Nifedipine تحت اللسان بدون إشراف طبي — الإنخفاض السريع خطير
- أجلسه في مكان هادي، يتنفس بعمق، يرتاح

الموضوع الثاني — الكوليسترول والدهون

المريض: "يا دكتور من ما بدأت الأتورفاستاتين بييجيني ألم في عضلات رجليني"

اسأل أولاً

- الألم خفيف ولا شديد؟ قادر يمشي؟
- من امتى بدأ الدواء؟
- الجرعة كام؟ 10، 20، 40، 80 mg؟
- بياخد أى أدوية تانية؟ (بعض الأدوية بتزود تركيز الستاتين في الدم: Verapamil)، Amiodarone، Clarithromycin

التوصية

- الألم العضلي من الستاتين ((Statin Myopathy) — شائع في 5-10%
- لو الألم خفيف: ينتظر 2-4 أسابيع — أحياناً بيخف من نفسه
- لو الألم شديد أو فيه تغيير في لون البول لبني/أحمر → يوقف الدواء ويروح الطبيب فوراً (رابدوميوليسيس — انهيار العضلات — نادر لكن خطير)
- قوله يروح الطبيب لـ: تخفيف الجرعة، تبديل لستاتين تاني (Pravastatin أو Rosuvastatin أقل في الألم العضلي)، أو أخذ يوم راحة بين الجرعات

المريض: "يا دكتور التحليل جه، $LDL = 145$ ، ده عالي؟ أعمل إيه؟"

النوع	القيمة المستهدفة
LDL (الضار)	أقل من 100 mg/dl عموماً، أقل من 70 لمريض القلب
HDL (النافع)	فوق 40 (رجال)، فوق 50 (نساء) — الأعلى أحسن
Triglycerides (دهون ثلاثية)	أقل من 150 mg/dl
Total Cholesterol	أقل من 200 mg/dl

التوصية:

- $LDL = 145$ مرتفع — يحتاج تدخل
- لو مافيش أمراض قلب أو سكري أو ضغط: ابدأ بتغيير الأكل والرياضة لمدة 3 شهور أولاً
- لو عنده أمراض قلب أو سكري: الطبيب غالباً هيبداً ستاتين فوراً
- تغييرات الأكل المهمة:
 - قلّل الدهون المشبعة: لحم دهني، زبدة، جبنة صفراء
 - ابعد عن الدهون المتحولة: بسكويت، شيبس، مارجرين
 - زوّد: شوفان، فول، بقوليات، سمك (أوميغا 3)، زيت زيتون

الموضوع الثالث — الذبحة الصدرية

المريض: "يا دكتور عايز نيترومينت قرص تحت اللسان، عندي ذبحة صدرية"

اسأل أولاً

- استخدمه النهارده؟ كام مرة؟
- بييجيه الألم في الراحة ولا بس مع الجهد؟ (الراحة = أخطر)
- الألم بيستجيب للنيتروجليسرين؟ وفي كام دقيقة؟
- الألم اتغير مؤخراً؟ بييجيه من غير سبب؟

التوصية

- عند الألم: قرص تحت اللسان — انتظر 5 دقائق
- لو مش بيتحسن: جرعة ثانية — انتظر 5 دقائق
- لو مش بيتحسن بعد 3 جرعات في 15 دقيقة → إسعاف فوراً — دي قد تكون جلطة

- يحفظه في مكان بارد جاف بعيد عن الضوء — الحبوب بتتلف بالحرارة
- يغير العبوة كل 3-6 شهور حتى لو ما استخدمهاش

تحذير — أحوله فوراً

- الألم بدأ يجيه في الراحة ((unstable angina))
- محتاج نيترومينت أكثر من المعتاد
- الألم بقى أطول أو أشد

الموضوع الرابع — تخفيف الدم

المريض: "يا دكتور بياخد وارفارين وعنده ألم وعاليز مسكن"

التوصية

- الوارفارين بيتفاعل مع كتير جداً من الأدوية والأكل
- المسكن الوحيد الآمن معه: **Paracetamol** — بس بجرعة أقل من 2 غرام يومياً
- ممنوع تماماً مع الوارفارين: Aspirin، Ibuprofen، Diclofenac، أي NSAID — بيزودوا خطر النزيف بشكل خطير
- أكل بيؤثر على الوارفارين: الخضار الورقية الخضراء الكثيرة جداً (خس، سبانخ) بتقلل تأثيره — ينّبّهه يكون متسق في أكله

تحذير — أحوله فوراً

- دم في البول (بول أحمر أو بني)
- براز أسود قطراني
- نزيف لثة أو أنف ما بيوقفش
- كدمات كبيرة من ضربة بسيطة
- → يروح الطوارئ فوراً

المريض: "بياخذ بلافيكس بعد عملية قلب، عنده صداع، آخذ إيه؟"

التوصية

- **Paracetamol** — الآمن الوحيد
- **NSAIDs** (إيبوبروفين، فولتارين) — بتزود خطر النزيف
- **الأسبرين بجرعة المسكن (500 mg) ممنوع** — لكن الأسبرين 100 mg ممكن يكون هو نفسه جزء من علاجه — ما تزودش عليه

ملخص سريع للفصل

الشكوى	أول سؤال	الإجراء
ضغط مرتفع جديد	أعراض؟	طبيب — مش دواء من عندك
مريض ضغط — سعال	بياخذ pril؟	راجع الطبيب لتبديله بـ ARB
ضغط 180 + أعراض	ألم صدر؟ كلام متأثر؟	إسعاف فوراً
ألم عضلات من ستاتين	البول اتلون؟	وقف الدواء + طبيب
مريض وارفارين يطلب مسكن	باراسيتامول فقط 2g	ممنوع أي NSAID
ذبحة صدرية — 3 نيترو ما أثرتش	—	إسعاف فوراً

❓ المبدأ الذهبي في القلب:

مريض الضغط والكوليسترول مريض مزمن — علاقتك معاه طويلة.

أي ألم صدر مع تعرق وانتشار = إسعاف قبل أي دواء.

الوارفارين والكليبيدوجريل + NSAIDs تركيبة قاتلة.

الأمراض المزمنة والأيضية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: الأمراض المزمنة والأيضية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

الموضوع الأول — السكري في الصيدلية

الحالة 1 — مريض سكري جديد يستلم علاجه لأول مرة

المريض: "يا دكتور الدكتور كتبلي ميتفورمين 500 وجلوكوفاج XR، مش فاهم الفرق"

التوصية

- (Metformin 500 mg عادي): بياخد مع الأكل — ممكن يعمل غثيان في البداية
- (Glucophage XR Extended Release): نفس الدواء لكن إطلاق بطيء — أقل بكتير في الغثيان — بياخده مرة واحدة مع العشاء
- الفرق: مش في التأثير — في الراحة والأعراض الجانبية
- شرح مهم للمريض الجديد:
- الميتفورمين مش بيودي السكر ينزل خطر من نفسه (hypoglycemia) نادر معه لوحده
- ياخده مع الأكل أو بعده — مش على معدة فاضية
- ممكن يحس بغثيان في أول أسبوعين — ده طبيعي ويبخف
- لو هيعمل أشعة بصبغة (Contrast CT) → يوقف الميتفورمين 48 ساعة قبل وبعد — فيخبر الطبيب دايماً إنه بياخد ميتفورمين

المريض: "يا دكتور من ما بدأت الميتفورمين بطني خربان، إسهال وغثيان"

اسأل أولاً

- من امتى بدأ الدواء؟ (الغثيان طبيعي في الأول)
- بياخده على معدة فاضية؟
- الجرعة كام؟

التوصية

- **الحل الأول:** تأكد إنه بياخده مع الأكل — مش قبله
- **الحل الثاني:** اقترح على طبيبه الانتقال لـ Glucophage XR — بيقلل الأعراض الهضمية بشكل كبير
- **الحل الثالث:** يبدأ بجرعة أصغر (250 mg) ويزيد تدريجياً كل أسبوع

المريض: "يا دكتور محتاج جهاز سكر، أنهي أحسن؟ وإزاي أستخدمه؟"

التوصية

- الأجهزة الشائعة في مصر:
- (**Accu-Chek** أكيو-تشيك): دقيق ومعتد — الشرائط متاحة
- **OneTouch** شائع
- **Glucotrend**, **Contour**: بدائل جيدة
- تعليمات الاستخدام:
- اغسل إيدك بالماء والصابون وجففها
- لخز طرف الإصبع الجانب (مش في المنتصف — بيوجع أكثر)
- اعصر قطرة دم صغيرة
- ضع على الشريطة — القراءة في ثوان
- متى يقيس السكر:
- صيام (قبل الأكل): $80-130 \text{ mg/dl}$ طبيعى
- بعد الأكل بساعتين: أقل من 180 = كويس
- قبل النوم: 100-140 = مناسب
- تحذير:
- الشرائط بتتلف بالحرارة والرطوبة — يحفظها في مكان جاف بعيد عن الشمس
- الشرائط ليها تاريخ انتهاء — يتأكد منها

المريض: "يا دكتور الدكتور كتبلي نوفوراتش للسريع ولانتوس للطويل"

النوع	المثال	متى يؤخذ	مدة التأثير
سريع جداً ((Rapid	Humalog ,NovoRapid	قبل الأكل مباشرة أو أثناءه	4-6 ساعات
قصير ((Short	Humulin R ,Actrapid	30 دقيقة قبل الأكل	6-8 ساعات
متوسط ((Intermediate	NPH ,Insulatard	مرتين يومياً	12-18 ساعة
طويل ((Long	Levemir ,Lantus	مرة يومياً، نفس الوقت	20-24 ساعة

تعليمات الأنسولين اللازم تقولها للمريض:

التخزين:

- غير مفتوح: ثلاجة (2-8 درجة) — مش في الفريزر
- مفتوح/جاري استخدامه: درجة حرارة الغرفة — يدوم 28 يوم (نوفوراتش) إلى 42 يوم (لانتوس)
- لا تعرضه للشمس أو الحرارة الشديدة

الحقن:

- أفضل مكان: البطن (امتصاص أسرع وأكثر ثباتاً)
- أو الفخذ الخارجي، النراع
- لازم يغير مكان الحقن كل مرة — الحقن في نفس المكان دايماً يسبب تكتلات دهنية ((Lipodystrophy وامتصاص غير منتظم
- اللبنة (إبرة الحقن) تستخدم مرة واحدة فقط

التعامل مع القلم:

- لو بيستخدم قلم أنسولين: يختبر 2 وحدة في الهواء قبل الحقن — يتأكد إن الإبرة تشتغل

المريض: "يا دكتور داخ جداً وإيديا بترتجف وأنا بأخذ أنسولين"

اسأل أولاً

- قيس السكر فوراً لو عنده جهاز
- السكر أقل من 70 = هبوط

التوصية

- أعطه 15 غرام سكر سريع الامتصاص:
- نص كوباية عصير برتقال أو تفاح (150 ml)
- 3-4 أقراص جلوكوز ((Dextrose
- ملعقة كبيرة عسل أو سكر في ميه
- 3-4 حبات حلوى صلبة
- انتظر 15 دقيقة — قيس السكر تاني
- لو لسه أقل من 70 — كرر
- بعد التحسن: أكله وجبة حقيقية

تحذير — أحوله فوراً

- لا تديه حاجة عن طريق بقه — هيتنفسها
- اتصل بإسعاف فوراً
- لو عنده Glucagon kit — حقنه IM في الفخذ
- الأسباب الشائعة لهبوط السكر:
- نسي الأكل بعد الأنسولين
- جهد زيادة من المعتاد
- جرعة أنسولين أو سلفونيل يوريا كبيرة
- شرب كحول (نادر في مصر لكن يذكر)

المريض: "يا دكتور سمعت عن أوزمبيك للسكر والتخسيس، أعمل إيه؟"

التوصية

- (Ozempic)Semaglutide: حقنة تحت الجلد — أسبوعياً
- فعال جداً لخفض السكر وفقدان الوزن (7-15 kg في المتوسط)
- يحتاج وصفة طبية — لا تصرفه بدون وصفة
- أعراض جانبية شائعة: غثيان وإسهال في البداية
- مناسب لمريض سكري نوع 2 مع زيادة وزن
- مش للتخسيس بدون سكري — يحتاج إشراف طبي دقيق

الموضوع الثاني — الغدة الدرقية

المريض: "بياخذ ثيروكسين للغدة، فيه حاجة ممنوع ياخذها معاه؟"

السبب	ممنوع مع الثيروكسين
بيقلل الامتصاص — فصل 4 ساعات	كالسيوم (أقراص كالسيوم)
بيقلل الامتصاص — فصل 4 ساعات	حديد (أقراص حديد)
بيقلل الامتصاص — فصل 4 ساعات	مضادات الحموضة (أومبرازول، مالوكس)
بيتناخل مع الامتصاص	الصويا (حليب الصويا، منتجات)
فصل ساعة على الأقل	الكالسيوم في الألبان

القاعدة الذهبية للثيروكسين:

- ياخذه على معدة فاضية — صباحاً أول حاجة
- ينتظر ساعة كاملة قبل الأكل والقهوة والأدوية الثانية
- ده مش تفضيل — ده ضروري عشان الدواء يشتغل صح

المريض: "يا دكتور بيجيني خفقان وحاسس بحرارة زيادة في جسمي وعصي من غير سبب وبينزل وزني"

اسأل أولاً

- التعرق زيادة؟
- فيه رعشة في الإيدين؟
- الدورة اتأثرت؟ (للسيدات)
- فيه انتفاخ في الرقبة؟

التشخيص

- الأعراض دي كلاسيكية لفرط نشاط الغدة الدرقية ((Hyperthyroidism
- خفقان + حرارة + عصبية + فقدان وزن + تعرق + رعشة = فرط نشاط

التوصية

- لا تصرف أي دواء — حوِّله للطبيب لعمل تحليل TSH و T4
- لو التشخيص مؤكد، الطبيب هيصرف: Carbimazole أو Propylthiouracil وأحياناً Propranolol للسيطرة على الخفقان

الموضوع الثالث — هشاشة العظام

المریضة: "یا دكتور عندي 55 سنة والدكتورة قالت عندي هشاشة في العظام، أعمل إيه؟"

التوصية

- المكملات الأساسية:
- كالسيوم 500-1000 mg يومياً: من الأكل مثالي (لبن، جبنة، سمسم) أو أقراص
- Calcium Carbonate الأرخص — يؤخذ مع الأكل
- Calcium Citrate يؤخذ بدون أكل — أفضل لمن عنده حموضة
- لا تأخذ أكثر من 500 mg في مرة — الجسم ما يمتصش أكثر
- فيتامين D3: 800-2000 IU يومياً — ضروري مع الكالسيوم
- الدواء (لو مشخص هشاشة):
- (Alendronate فوساماكس): قرص أسبوعياً على معدة فاضية + يقف 30 دقيقة واقف أو جالس — لا يرقد
- (Risedronate أكتونيل): بديل
- نصائح مهمة:
- رياضة حمل الأثقال (المشي، السلالم) أهم من الكالسيوم
- تجنب التدخين والكحول
- تجنب السقوط: إضاءة كافية، شبكة في الحمام، أحذية ثابتة

الموضوع الرابع — النقرس

المريض: "يا دكتور إبهام رجلي ورم واحمر وبيأجني بشكل مش طبيعي، صحنيني من النوم"

اسأل أولاً

- حصله قبل كده؟
- أكل لحم كتير أو كبدة أو مأكولات بحرية مؤخراً؟
- عنده حمض يوريك مرتفع في التحاليل؟
- يشرب فيه كافي؟

التشخيص

- الألم المفاجئ الشديد في إبهام القدم مع احمرار وورم وحرارة = **نقرس حاد (Gout)**

التوصية

- نوبة النقرس الحادة:
- **NSAIDs — 2 × Naproxen 500 mg أو 3 × Indomethacin 50 mg**
- الأكثر فعالية للنقرس
- **Colchicine: 1 mg فوراً ثم 0.5 mg بعد ساعة** — فعال جداً لو أخذ في أول 12-24 ساعة من النوبة
- **NSAIDs: 30-40 mg Prednisolone** يومياً لـ 5 أيام
- راحة القدم، رفعها، كمادات باردة، شرب فيه كتير
- للوقاية (بعد النوبة، مع الطبيب):
- **(Allopurinol زيلوريك):** يبدأ بعد انتهاء النوبة — مش أثناءها (بيطول النوبة)
- تجنب: اللحم الحمر الكثير، المأكولات البحرية، الفركتوز الزيادة
- شرب فيه 2-3 لتر يومياً

ملخص سريع للفصل

الشكوى	أول سؤال	الإجراء
مريض سكري جديد	عارف يستخدم جهاز السكر؟	شرح الجهاز والأهداف
دوخة ورعشة — مريض أنسولين	قيس السكر فوراً	قاعدة 15-15
غثيان من ميتفورمين	بإخذه على معدة فاضية؟	انتقل لـ XR
خفقان وفقدان وزن	رعشة إيديين؟ تعرق؟	تحليل TSH — طبيب
ألم مفاجئ في إبهام القدم	حمض يوريك مرتفع؟	Colchicine أو NSAID
سيده بعد سن اليأس — هشاشة	بتاخذ كالسيوم + D؟	500 mg كالسيوم + D3

❓ المبدأ الذهبي في السكري:

الميتفورمين وحده مش يعمل هبوط سكر — السلفونيل يوريا والأنسولين يعملوا.

مريض الأنسولين دائماً لازم معاه سكر سريع في جيبيه.

التيروكسين على معدة فاضية — ساعة قبل أي حاجة.

القسم الثاني — الأمراض المزمنة والأبضية · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

الجهاز التنفسي والحساسية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: الجهاز التنفسي والحساسية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

طريقة القراءة: كل حالة فيها شكوى المريض، الأسئلة التي لازم تسألها، التوصية، وعلامات الخطر. احفظ المنطق —
مش الإجابة.

الموضوع الأول — الكحة (السعال)

المريض: "يا دكتور أنا عندي كحة وحاجة في زوري تقريباً بلغم، آخذ إيه؟"

اسأل أولاً

- البلغم لونه إيه؟ أبيض، أصفر، أخضر، أو فيه دم؟
- الكحة من امتي؟ يومين؟ أسبوع؟ أكثر من 3 أسابيع؟
- فيه حرارة معاها؟
- فيه ضيق في التنفس؟
- المريض بيدخن؟
- بياخد أي أدوية دلوقتي؟ (خصوصاً ACE inhibitors زي الليزينوبريل — بتسبب كحة جافة)

اللون والمدة	الاحتمال
بلغم أبيض شفاف، أقل من أسبوع، بدون حرارة	التهاب فيروسي — نزلة برد عادية
بلغم أصفر أو أخضر + حرارة	التهاب بكتيري — الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي
بلغم أخضر كثيف + ألم في الجبهة أو الخدود	التهاب جيوب أنفية
كحة أكثر من 3 أسابيع بدون سبب واضح	لازم تحويل للطبيب — مش شغلتك هنا
فيه دم في البلغم	طوارئ — حوِّله فوراً

التوصية

- نزلة برد فيروسية بسيطة (بلغم أبيض، بدون حرارة، أقل من أسبوع):
- (Guaifenesin مذيّب بلغم) — Balm, Mucinex — يرقق البلغم ويسهّل خروجه
- ينصح بشرب مياه كثيرة — تفيد أكثر من أي دواء
- عسل + ليمون — فعّال ومثبت علمياً للكحة الخفيفة
- إذا فيه احتقان في الأنف معها: ناتال بخاخ أو سودافيد ((Pseudoephedrine — بس تحت إشراف
- إذا البلغم أصفر/أخضر مع حرارة:
- لا تعطي مضاد حيوي من عندك — المريض يروح للطبيب أولاً
- ممكن تعطي خافض حرارة (باراسيتامول) ريخة مؤقتة
- نصحه يروح طبيب خلال 24-48 ساعة

تحذير — أحوله فوراً

- الكحة مستمرة أكثر من 3 أسابيع
- فيه دم في البلغم (ولو قليل)
- ضيق تنفس أو صوت صغير في الصدر
- حرارة فوق 38.5 لأكثر من 3 أيام
- مريض مسن أو ضعيف المناعة
- الكحة بتمنعه من النوم تماماً

لا تعطي

- كودين (مضاد كحة أوبيويد) بدون وصفة طبية — مش من حقه
- مضاد حيوي بناءً على لون البلغم لوحده
- كحة مهدئة (مثبطة) مع بلغم كثيف — هتجس البلغم جوا

المريض: "عندي كحة ناشفة بتأذي من أسبوع، زي ما حاجة بتخدش في حلقي، مش قادر أنام"

اسأل أولاً

- بياخد دواء ضغط؟ (خصوصاً pril- زي Capoten أو Enalapril)
- فيه حساسية معروفة؟
- فيه إحساس بحرقه في الصدر أو طعم حمضي في بقه؟ (علامة ارتجاع معدي)
- بيدخن؟
- الكحة بتزيد لما ييجي بالقرب من حيوانات أو تراب؟

الموقف	الاحتمال
بياخد (ACE inhibitor-pril)	الكحة من الدواء نفسه — شائعة في 15% من المرضى
حرقه في الصدر + حموضة	ارتجاع المريء → يحتاج علاج الارتجاع
تزيد مع التراب والحيوانات	حساسية مجرى هوائي → يحتاج مضاد هستامين
بتيجي في الليل بس	ربما ارتجاع أو ربو ليلي

التوصية

- إذا السبب دواء ضغط (-pril):
- لا تعطي أي دواء — كلمه إنه يرجع للطبيب عشان يغير الدواء لـ (ARB -sartan) اللي ما يسببش كحة
- هذا مهم جداً: متقولوش "خد كحة ومش مشكلة" — الكحة هنا ما هتتحسنش بأي دواء طالما هو ماخذ الـ -pril
- إذا السبب حساسية أو تهيج بسيط:
- (Loratadine كلارييتين) أو (Cetirizine زيرتك) — مضاد هستامين بدون نعاس
- (Benzydamine تنتوم) — بخاخ للحلق يهتئ التهيج
- إذا السبب ارتجاع معدي:
- Omeprazole 20 mg صباحاً قبل الأكل
- ينصح بعدم النوم فوراً بعد الأكل ورفع رأس السرير

تحذير — أحوله فوراً

- الكحة مستمرة أكثر من 3 أسابيع بدون سبب واضح
- فقدان وزن غير مبرر مع الكحة

لا تعطي

- دواء كحة فوق آخر بدون تشخيص سبب الكحة أولاً

المريض (الأم): "ابني 4 سنين عنده كحة من 3 أيام ومتضايق، آخذ إيه؟"

اسأل أولاً

- عنده حرارة؟ كام؟
- الكحة فيها بلغم ولا جافة؟
- بيتنفس كويس؟ مش بيلهث؟
- عنده صوت صغير في صدره؟
- كم وزنه؟ (لحساب الجرعة)
- أي أدوية بياخذها؟

التوصية

- كحة بسيطة بدون حرارة، تنفس عادي:
- غسل نص ملعقة صغيرة — الأفضل للأطفال فوق سنة، مثبت علمياً
- Saline nasal drops — يرطب ويساعد
- Paracetamol syrup حسب الوزن لو فيه حرارة (15 mg/kg)
- شرب سوائل كثير وبخار دافي

تحذير — أحوله فوراً

- عمره أقل من 3 شهور وعنده أي كحة
- فيه صوت صغير ((Wheeze في صدره
- بيتنفس بسرعة أو بصعوبة أو بيشد جلده على صدره
- حرارة فوق 38 في طفل أقل من 6 شهور
- الكحة نباحية زي صوت الكلب (تفكر في خناق — Croup)
- ازرق أو شاحب

لا تعطى

- كودين — ممنوع قانونياً للأطفال أقل من 12 سنة (كان سبب وفيات)
- مضادات الهيستامين القديمة (كلور فينيرامين) للأطفال أقل من 6 سنين
- أسبرين لطفل بأي عمر — خطر متلازمة ري
- أي دواء كحة بدون استشارة الطبيب للأطفال أقل من 4 سنين

الموضوع الثاني — الربو

المريض: "يا دكتور أنا عندي ربو وخلص مني الفنتولين، عايز أجده"

اسأل أولاً

- معاه وصفة؟
- بيستخدم الفنتولين كثير؟ أكثر من مرتين في الأسبوع؟
- عنده بخاخ ستيرويد (وقائي) زي بيكلوميثازون أو فلوتيكازون؟
- فيه نوبة دلوقتي؟ أو بيطلب للاحتياط؟

التوصية

- لو مش في نوبة، بس بيستخدمه كثير (أكثر من مرتين أسبوعياً):
- صرف الفنتولين ((Salbutamol كموسع في الأزمة
- لكن — لازم تنبهه: الاستخدام الكثير دليل إن الربو مش متحكم فيه — لازم يروح طبيببه عشان يبدأ بخاخ وقائي ((Inhaled Corticosteroid
- اشرح له الفرق: الفنتولين = إطفاء حريق، البيكلوميثازون = منع الحريق
- لو في نوبة خفيفة-متوسطة:
- 4 بخات من الفنتولين كل 20 دقيقة $\times 3$ — لو اتحسن، يروح طبيببه
- لو ما اتحسنش بعد الدوسة الأولى — اتصل بالإسعاف

تحذير — أحوله فوراً

- مش قادر يكمل جملة بدون انقطاع
- لون أزرق حول الشفاه أو الأظافر
- معدل تنفس فوق 30 في الدقيقة
- خفقان قلب سريع جداً
- ما ردش على 3 جرعات فنتولين

لا تعطي

- أسبرين أو إيبوبروفين (NSAIDs) لمرضى ربو إلا لو بيأخذها من قبل بدون مشكلة — ممكن تحرض نوبة في 10-20% من المرضى
- بيتا بلوكر (أي -lolol) — تضيق الشعب الهوائية وتحرض الربو

الحالة 5 — أم جابت طفلها عنده صغير في صدره

المريض (الأم): "ابني 6 سنين، لما بينام بسمع صوت زي الصفارة من صدره وبيكح كمان"

اسأل أولاً

- الصغير جديد ولا من زمان؟
- فيه حد في العيلة عنده ربو أو حساسية؟
- الصوت ده بيزيد مع الجري أو التعب؟
- بيزيد في الليل؟
- فيه أكزيما أو حساسية جلدية على الطفل؟ (مثلث الحساسية = ربو + أكزيما + التهاب أنف تحسسي)

التوصية

- لا تصرف أي دواء من عندك — الطفل لازم يتشخص من طبيب أطفال أو متخصص صدر
- طمّن الأم إن الصورة دي شايعة تعهّدها، وإن الربو عند الأطفال تحت السيطرة لو اتعالج صح
- لو فيه ضيق تنفس حالي — حوّل للطوارئ

الموضوع الثالث — الحساسية الموسمية والمزمنة

المريض: "يا دكتور كل سنة في الربيع بييجيني عطس وعيني بتدمع وأنفي بيسيل ومش قادر أتنفس من أنفي"

اسأل أولاً

- الحساسية دي كل سنة في نفس الوقت؟ (موسمية = حبوب اللقاح)
- بتزيد في الخارج أو الداخل؟
- فيه حيوانات في البيت؟
- عنده ربو؟
- جرب أي دواء قبل كده؟ واشتغل معاه؟

التشخيص

- عطس + سيلان أنف + دموع عيون + احتقان = التهاب الأنف التحسسي
(Allergic Rhinitis)
- موسمي = رد فعل لحبوب اللقاح في الهواء

التوصية

- الخط الأول:
- مضاد هيستامين جيل ثاني (بدون نعاس):
 - Cetirizine (زيرتك) 10 mg مرة يومياً
 - Loratadine (كلاريتين) 10 mg مرة يومياً
 - Fexofenadine (تيلفاست) 120-180 mg مرة يومياً — الأقل في النعاس
 - لو الأنف محتقن بشكل رئيسي:
- **Nasal Corticosteroid Spray:**
 - Fluticasone (فلوناز) — بخاخ أنفي
 - Budesonide (رينوكورت)
- الأفضل للاحتقان المزمن — أفضل من مضادات الهيستامين للأنف تحديداً
- يحتاج أسبوع عشان يأثر — ليس للطوارئ
- لو فيه احتقان شديد مؤقت:
- **OtrivinXylometazoline**, **Xynosine** — قطرات أنف مضيقة
- تحذير هام: لا تستخدم أكثر من 3 أيام متتالية — بسبب احتقان ارتدادي (**Rhinitis Medicamentosa**) أشد من الأصلي
- لو العيون بدمع وبتحكك:
- قطرات عين مضادة هيستامين: (**Olopatadine**) (**Pataday**), (**Ketotifen** (**Zaditen**))

تحذير — أحوله فوراً

- ما ردش على مضادات الهيستامين
- الأعراض طول السنة مش موسمية
- فيه انتفاخ في الوجه أو صعوبة تنفس

لا تعطى

- مضادات الهيستامين جيل أول (كلورفينيرامين، ديفينهيدرامين) للأشخاص اللي شغالين أو بيقودوا — نعاس شديد
- Xylometazoline أكثر من 3 أيام

المريض: "أكلت جمبري أمارح وبعدها أجسمي كلها حكة وفيه طفح أحمر"

اسأل أولاً

- فيه انتفاخ في الوجه أو الشفايف أو اللسان؟
- فيه صعوبة في التنفس أو البلع؟
- قلبه بيدق بسرعة؟
- دوخة أو حاسس إنه هيمغمى عليه؟
- الطفح واسع ولا محدود؟

التشخيص

- الطفح والحكة بدون أعراض تانية = شرى ((Urticaria — حساسية جلدية
- مع انتفاخ وجه وضيق تنفس = أنافيلاكسيس = طوارئ قاتلة

التوصية

- لو شرى بسيط بدون أعراض تانية:
- Cetirizine 10 mg أو Loratadine 10 mg فوراً
- Hydrocortisone cream للمناطق المتأثرة
- يتجنب الجمبري وأي مأكولات بحرية تانية
- لو فيه انتفاخ وجه أو ضيق تنفس:

تحذير — أحوله فوراً

- لو في الصيدلية عندك (Epinephrine) amp Adrenaline — استعد لتطبيقها IM في الفخذ
- لا تديه حاجة فموية — هيتقاع

الموضوع الرابع — نزلة البرد والإنفلونزا

المريض: "يا دكتور معلقني نزلة برد من يومين، أنفي ماشي ومش قادر أشم حاجة"

اسأل أولاً

- فيه حرارة؟ كام درجة؟
- آلام في الجسم كمان؟
- الأنف ببسيل ولا محتقن بس؟
- أي أمراض مزمنة؟ سكري، ضغط؟

العرض	نزلة برد	إنفلونزا
البداية	تدريجية	مفاجئة
الحرارة	خفيفة أو مفيش	عالية >38.5
آلام الجسم	خفيفة	شديدة جداً
الإرهاق	خفيف	شديد
احتقان الأنف	رئيسي	ثانوي
المدة	7-10 أيام	7-14 يوم

التوصية

- نزلة برد بسيطة — العلاج أعراض فقط:
- احتقان أنف: (Xylometazoline أو Pseudoephedrine) — لا تزيد عن 3 أيام
- سيلان أنف: Loratadine أو Cetirizine
- حرارة/آلام: Paracetamol 500-1000 mg
- بلغم: (Guaifenesin بالجم)
- تهيج الحلق: (Benzydamine spray تانتوم) أو بيتادين غرغرة

💡 الحقيقة: مفيش علاج للنزلة الفيروسية — الجسم بيعالج نفسه. الأدوية بس بتريح من الأعراض.

إنفلونزا موثقة خلال 48 ساعة من الأعراض:

- (Oseltamivirتاميفلو) — يحتاج وصفة — يبقصر المدة بيوم أو يومين بس
- فعّال فقط لو أخذ خلال 48 ساعة من أول عرض

تحذير — أحوله فوراً

- حرارة فوق 39 مش بتد على الباراسيتامول
- ضيق تنفس أو ألم في الصدر
- تصلّب رقبة (تفكير في التهاب سحايا)
- مريض مزمن: سكري، قلب، ضعف مناعة
- أعراض مستمرة أكثر من 10 أيام

لا تعطي

- مضاد حيوي — نزلة البرد فيروسية والمضاد الحيوي ما يثرش عليها
- لو المريض مصرّ قوله: "المضاد الحيوي مش هيفيدك هنا وهيعمل مقاومة"

الموضوع الخامس — الجهاز التنفسي المزمن ((COPD

المريض: "يا دكتور أنا عندي ضيق في التنفس من زمان خصوصاً لما بجري أو أشيل حاجة ثقيلة، وبكح كتير في المبح"

اسأل أولاً

- بيدخن؟ من امتي؟ كام سيجارة في اليوم؟
- عمره كام؟
- سبق وراح طبيب وتتشخص بإيه؟
- بياخد أي بخاخات؟
- فيه حرارة أو تغيير في لون البلغم مؤخراً؟

التشخيص

- COPD = انسداد رئوي مزمن — الأكثر شيوعاً عند المدخنين فوق 40 سنة
- الثلاثة الكلاسيكية: ضيق تنفس + كحة صباحية + بلغم

التوصية

- لو مش متشخص: لازم يروح طبيب رئة عشان يعمل مقياس تدفق الهواء (Spirometry)
- لو عنده تشخيص ودواء: تأكد إنه بياخد دواءه صح وتقنية البخاخ سليمة
- أهم توصية: الإقلاع عن التدخين — هو الوحيد اللي بيبطئ تقدم المرض
- أدوية COPD الشائعة في مصر:
- (Tiotropium) Spiriva: موسع طويل المفعول — مرة يومياً
- (Salbutamol) Ventolin: للطوارئ
- (Salmeterol + Fluticasone) Seretide: للحالات الأشد
- (Roflumilast) Daliresp: للحالات الشديدة المتكررة

تحذير — أحوله فوراً

- لون أزرق في الشفايف أو الأظافر
- مش قادر يكلم جملة
- بلغم أخضر كثيف مع حرارة (تفاقم بكتيري)
- الحالة أسوأ من المعتادة بشكل مفاجئ

الموضوع السادس — التهاب الجيوب الأنفية

المريض: "عندي ألم تحت عيني وفي جبھتي وأنفي محتقن، كمان الوجع بيزيد لما بانحنى"

اسأل أولاً

- من امتی؟ یومین، أسبوع، أكثر من 10 أيام؟
- فيه حرارة؟
- لون البلغم إيه؟
- حسيت بتحسن بعد كده رجع؟ (علامة على عدوی بكتيرية ثانوية بعد نزلة برد)
- عنده حساسية أنف معروفة؟

المدة	الاحتمال
أقل من 10 أيام	التهاب جيوب فيروسي — الغالبية العظمى
أكثر من 10 أيام أو اتحسن وبعدین راجع	التهاب جيوب بكتيري — محتاج مضاد حيوي
أكثر من 12 أسبوع	مزمن — محتاج طبيب

التوصية

- فيروسي (الأغلب، أقل من 10 أيام):
- **Xylometazoline nasal spray** لفتح الأنف — لا تزيد عن 3 أيام
- **Paracetamol** أو **Ibuprofen** للألم
- **Saline nasal rinse** غسيل الأنف بالملح — مثبت علمياً — يساعد كثير
- بخار ساخن
- مفيش حاجة تانية — الجسم بيعالج نفسه
- بكتيري (أكثر من 10 أيام أو أعراض شديدة):
- لازم وصفة طبية — لا تعطي مضاد حيوي من عندك
- الطبيب عادةً بيصرف: **Amoxicillin-Clavulanate** أو **Augmentin** أو **Doxycycline**

تحذير — أحوله فوراً

- ورم حول العين أو احمرارها
- صداع شديد جداً أو تصلب رقبة
- تغيير في الرؤية
- حمى مع تدهور سريع

ملخص سريع للفصل

الشكوى	أول سؤال تسأله	الخط الأول
كحة مع بلغم	لون البلغم؟	مذيب بلغم + سوائل
كحة جافة مزعجة	بياخد -pril؟	راجع الطبيب لتغيير الدواء
ضيق تنفس وصغير	عنده ربو مشخص؟	+ Salbutamol طبيب
عطس ودموع موسمي	بيزيد برّه؟	مضاد هستامين + بخاخ أنفي
نزلة برد	فيه حرارة وآلام جسم؟	علاج أعراض فقط
ألم وجه واحتقان	من امتى؟	غسيل ملح + مضيق أنف (3 أيام)

❓ المبدأ الذهبي في الجهاز التنفسي:

لا مضاد حيوي بدون تشخيص واضح.

الفيروس أكثر من 90% من الحالات في الشتاء.

الجسم يعالج نفسه في 7-10 أيام.

شغلتك هي إراحة الأعراض ورصد علامات الخطر.

العيون والأذن والأنف

[صورة غلاف توضيحية لفصل: العيون والأذن والأنف]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

تذكر: معظم حالات ENT والعيون اللى بتيجي للميدلية خفيفة وقابلة للعلاج. لكن فيه علامات خطر تميزها عن غيرها بسرعة.

الموضوع الأول — العيون

المريض: "يا دكتور عيني احمرت ونازل منها إفرازات صفراء وبتلرزق في الصباح"

اسأل أولاً

- الإفرازات لونها إيه؟ صفراء/خضراء كثيفة ولا مائية شفافة؟
- فيه حكة؟ (حساسية)
- العينين كلتيهما ولا واحدة؟
- فيه ألم داخل العين أو تغيير في الرؤية؟
- فيه مخالطة لحد عنده رمد مؤخراً؟ (وبائي)
- بيستخدم عدسات لاصقة؟

نوع الإفراز	+ أعراض أخرى	الاحتمال
أصفر/أخضر كثيف	إفرازات تلرزق الجفون صباحاً	بكتيري
مائي شفاف	قشور خفيفة	فيروسى (كثير مع الزكام)
مائي + حكة شديدة + عطس	موسمي أو مع حيوانات	حشاشي
أصفر + ألم في العين	رؤية ضبابية	قرنية — طبيب عيون

التوصية

- بكتيري:
- **Chloramphenicol 0.5%** قطرة: كل 2 ساعات اليومين الأولين، ثم كل 4 ساعات x 5 أيام
- (أو **Tobramycin** توبريكس) **0.3%**: أقوى، للحالات الأشد
- (أو **Fusidic acid** فيوسيتالميك) **1%** جل: مرتين يومياً — أسهل للأطفال
- فيروشي:
- لا مضاد حيوي — الجسم يعالج نفسه في 7-14 يوم
- دموع اصطناعية للراحة وتخفيف الاحمرار
- كمادات دافئة لإزالة الإفرازات
- مهم جداً: ممكن ينتقل للعين الثانية ولأفراد الأسرة — نظافة الإيديين والمناشف
- حساشي:
- (**Olopatadine**) **Pataday 0.1%**: قطرة مرة أو مرتين يومياً — الأفضل
- (**Ketotifen**) **Zaditen**: قطرة: مرتين يومياً
- **2% Sodium Cromoglycate** وقائي للحساسية المزمنة
- كمادات باردة للحكة — لا دافئة

تحذير — أحوله فوراً

- ألم شديد داخل العين (مش على الجفن)
- رؤية ضبابية أو انخفاض حدة الرؤية
- حساسية شديدة للضوء ((Photophobia
- الإفرازات خضراء كثيفة مع ألم (احتمال قرنية)
- لا يتحسن بعد 3 أيام من قطرة المضاد الحيوي
- يستخدم عدسات لاصقة — خطر أعلى على القرنية
- نصائح النظافة مع الرمد:
- لا يلمس عينيه بإيديه
- يغسل إيديه كل ما لمس وجهه
- منشفة خاصة — لا يشاركها
- يغير وسادته يومياً حتى يتعافى
- العدسات اللاصقة: يوقفها حتى الشفاء الكامل

المريض: "يا دكتور عيني بتحرقني وبتتعب خصوصاً على الشاشة، وأحياناً بتدمع كمان"

اسأل أولاً

- يشتغل على كمبيوتر أو شاشة كثير؟
- في بيئة مكيفة أو جافة؟
- فيه أمراض مزمنة؟ (مرض الغدة الدرقية، المناعة الذاتية — s)'grenöSj)
- بياخد أى أدوية؟ (مضادات الهيستامين، بعض أدوية الضغط بتسبب جفاف عين)
- بيرتدي عدسات لاصقة؟

التوصية

- دموع اصطناعية — اختر حسب الشدة:

المنتج	المادة الفعالة	مناسب لـ
Hialid, Hylocomod	Sodium Hyaluronate	الأفضل عموماً، يدوم طويل
Systane Ultra	HPMC + Dextran	جفاف متوسط-شديد
Refresh Tears	CMC	يومي متكرر
Natural Tears	PVA	خفيف ورخيص
Systane Gel / Liposic Gel	جل كثيف	للنوم وللجفاف الشديد

نصائح مهمة:

- قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة شاشة، بص 20 ثانية على حاجة على بعد 20 قدم (6 متر)
- رفر رعينيك بوعي — الناس بتقل الرفيف على الشاشة من 20 مرة/دقيقة لـ 7
- رطب هواء الأوضة لو جاف أو فيه تكييف
- ضبط إضاءة الشاشة على مستوى مناسب
- العدسات اللاصقة: قلل وقت الارتداء + استخدم نقطة ترطيب مخصصة للعدسات

⚠ لو بيستخدم قطرة احمرار (مثل Visine Redness Relief):

- تحتوي على مضيّق أوعية (Tetrahydrozoline)
- للاستخدام قصير المدى فقط — الاستخدام المزمن يسبب احمرار ارتداديّ أشد
- مش علاج — مجرد مخفي للعرض

المريض: "يا دكتور عندي شعيرة في جفن عيني من 3 أيام، حمراء ومؤلمة"

اسأل أولاً

- على الحافة الخارجية للجفن ولا في الداخل؟
- ييجيه كثير؟
- فيه حمى؟

التشخيص

- **Hordeolum** الشعيرة الحادة: خراج في جريب شعرة الجفن — خارجي، مؤلم، يُحل وحده
- **Chalazion** الباردة: تورم دهني غير مؤلم في الغدة المبطنة — داخلي، أبطأ

التوصية

- **الكمامة الدافئة هي العلاج الرئيسي:**
- كمامة دافئة (ماء دافئ أو بيضة مسلوقة ملفوفة) على الجفن 10-15 دقيقة $\times$ 4 مرات يومياً
- تليين الإفراز وتسهيل الصرف الطبيعي
- **Chloramphenicol eye ointment** مرهم مضاد حيوي على الجفن ليلاً (وليس داخل العين)
- لا تعصر الشعيرة — بتنتشر العدوى

تحذير — أحوله فوراً

- التورم انتشر لمنطقة الخد أو الجفن كله
- فيه حمى
- بتتكرر كثير (استبعاد سكري أو ضعف مناعة)
- ما اتحسننتش بعد أسبوعين

المريض: "يا دكتور دكتور العيون كتبلي لاتانوبروست ((Xalatan قطرة، عايز أفهم أستخدمها ازاي"

التوصية

- تُستخدم في الليل فقط — مرة واحدة يومياً قبل النوم
- الاستخدام في النهار يقلل فعاليتها
- عارضة جانبية مميزة: بتغيير لون القرنية تدريجياً (من رمادي/أزرق/أخضر لبني أغمق) — غير ضار لكن دائم
- ممكن تطيل الرموش وتزيد كثافتها — أيضاً غير ضار
- احتفظ بالقطرة في الثلاجة قبل الفتح — بعد الفتح درجة حرارة الغرفة $6 \times$ أسابيع
- تقنية وضع قطرة العين:
- اغسل إيديك
- اسحب الجفن الأسفل للأسفل وكَوّن جيب
- ضع القطرة في الجيب — لا على سطح العين مباشرة
- أغمض عينك برفق $\times$ دقيقتين
- اضغط على الزاوية الداخلية للعين ((nasolacrimal occlusion — يقلل امتصاص الدواء للجسم بنسبة 50% ويزيد فعاليته في العين

الموضوع الثاني — الأذن

المريض: "يا دكتور أذني بتأجيني لما بلمسها أو بأكل، وفيه إحساس بامتلاء"

اسأل أولاً

- الألم بيزيد لما بيمسك الأذنة ((Tragus ويضغط عليها؟ — (ده علامة التهاب خارجي)
- كان بيعوم مؤخراً؟
- فيه إفرازات من الأذن؟
- فيه حمى؟
- فيه طنين أو فقدان سمع؟

التشخيص

- ألم بيزيد بلمس الأذنة = **Otitis Externa** (التهاب الأذن الخارجي)
- السباحة وتراكم الرطوبة في قناة الأذن + خدش يعود قطن = أكثر الأسباب

التوصية

- التهاب خارجي بسيط:
- **Acetic acid drops 2%**: قطرات حمض الخليل المخفف — تغيير درجة حموضة القناة يمنع البكتيريا والفطريات — 5 قطرات كل 6 ساعات $\times$ 7 أيام
- **Sofradex drops (Framycetin + Gramicidin + Dexamethasone)**: أكثر استخداماً في مصر — 3 قطرات 3-4 مرات يومياً
- **Otosporin (Polymyxin + Neomycin + Hydrocortisone)**: بديل جيد
- للألم:
- **Ibuprofen أو Paracetamol**
- كمادة دافئة على الأذن
- نصائح وقاية أذن السباح:
- بعد السباحة: جفّ الأذن برفق بترف منشفة — لا تدخلها
- أو جفّ بهواء مجفف الشعر على حرارة منخفضة من بعيد
- **Acetic acid drops 2%** بعد كل سباحة كوقاية

تحذير — أحوله فوراً

- ورم خلف الأذن أو أمامها ((Mastoiditis
- الألم شديد جداً مع حمى عالية
- فقدان سمع مفاجئ
- مريض سكري مع أي التهاب أذن — خطر **Malignant Otitis Externa**

الأم: "ابني 3 سنين صبح الليل وهو بيعيط وبيمسك أذنه وعنده حرارة"

اسأل أولاً

- قبلها كان عنده زكام؟ (التهاب أذن وسطى يجي بعد نزلة برد)
- فيه إفرازات من الأذن؟ (لو فيه: طبلة انتقبت — فرصة للتدهور أو التحسن)
- كام مرة اتعمله؟
- بياخد مضاد حيوي حالياً؟

التشخيص

- الثلاثية: ألم أذن + حمى + بعد زكام = Otitis Media التهاب أذن وسطى

التوصية

- التهاب الأذن الوسطى يحتاج تشخيص طبي — الطبيب يشوف طبلة الأذن بالمنظار
- لا تعطي قطرات الأذن في التهاب الأذن الوسطى — القطرات للقناة الخارجية فقط
- خافض حرارة ومسكن: Paracetamol أو Ibuprofen حسب الوزن
- المضاد الحيوي: Amoxicillin 40-90 mg/kg/day × 5-10 أيام — من الطبيب
- ملاحظة مهمة في مصر:
- بعض الآباء بجوا الصيدلية مباشرة بدون طبيب لأطفالهم. حاول تحثهم على الطبيب خاصة لو:
- الطفل أقل من 2 سنة
- الحرارة عالية فوق 39
- الأعراض مستمرة أكثر من 48 ساعة

المريض: "يا دكتور أذني مسدودة وسمعي خف، حاسس بامتلاء"

اسأل أولاً

- البداية مفاجئة (بعد استحمام: ابتلع الشمع ماء وانتفخ) ولا تدريجية؟
- سبق نطفها بعود القطن؟
- فيه ألم؟ (لو فيه: احتمال التهاب مش بس شمع)

التوصية

- إذابة الشمع:
- زيت الزيتون أو زيت اللوز ((**Ear drops**: 2-3 قطرات دافئة في الأذن × مرتين يومياً × 5-7 أيام
- يلين الشمع ويسهل خروجه أو شطفه
- **Otex**, **Waxsol**, **Cerumol** محاليل طبية جاهزة لإذابة الشمع — أسرع
- 3% Hydrogen Peroxide أو Carbamide Peroxide مع Glycerin
- بعد التليين — الشطف:
- الطبيب أو الممرض يشطف القناة بماء دافئ بسرينجة خاصة
- لا تحاول تشطف لوحك أو بعود قطن

لا تعطي

- أعواد القطن: بتدفع الشمع أعمق وبتكسبه وممكن تجرح
- (**Ear Candles** الشمعة): لا أدلة علمية على فعاليتها وخطر الحرق

المريض: "يا دكتور في صوت زى الطنين أو الصغير في أذني، من شهر"

اسأل أولاً

- في أذن واحدة أو الاثنين؟
- مستمر ولا يبجي ويروح؟
- فيه فقدان سمع؟
- تعرض لضوضاء شديدة مؤخراً (حفلة، مصنع، طلق نارى)؟
- بياخد أى أدوية؟ (الأسبرين بجرعات عالية، مضادات حيوية أمينوغليكوزيدات، Quinine)
- فيه دوخة مع الطنين؟ (s disease)'reèMeni)

التشخيص

- تعرض للضوضاء: الأشهر — خصوصاً عند الشباب
- أدوية: ototoxic أسبرين جرعات عالية، جنتاميسين، فيوروسيميد
- شمع الأذن: يسبب طنين مع سد
- ارتفاع ضغط الدم: طنين نابض مع القلب
- s:'reèMeni طنين + دوخة + فقدان سمع متذبذب

التوصية

- لو السبب دواء: يرجع لطيببه — قد يغير الجرعة أو الدواء
- لو شمع: يعالج الشمع أولاً
- مكمل: Ginkgo Biloba 120 mg يومياً — يحسن الدورة الدموية للأذن الداخلية، أدلة محدودة لكن آمن
- (Serc)Betahistine: للطنين مع الدوخة (s)'reèMeni — يحتاج وصفة
- حوّه لطبيب أذن إذا الطنين مستمر أكثر من 3 شهور

الموضوع الثالث — الأنف

الحالة 9 — احتقان أنف مزمن من الأوتريفيين

المريض: "يا دكتور بستخدم أوتريفيين من شهرين ومش قادر أنام بدونه"

التشخيص

- **Rhinitis Medicamentosa:** الاحتقان الارتدادي من الاستخدام المفرط للمضيقات الأنفية ((Decongestants
- الجسم يبتعد على المادة الفعالة (Xylometazoline أو Oxymetazoline) فلما تخف تأثيرها يحتقن الأنف أكثر من قبل

التوصية

- الطريقة الأسهل:
- أوقف إحدى المنخرين — استخدم الأوتريفيين في المنخر الأيمن بس × أسبوع
- أوقف المنخر الأيمن في الأسبوع التالي — استخدم اليسار بس إذا كان لسه صعب
- أوقف الاثنين في الأسبوع الثالث
- مع فطام الأوتريفيين — أضف بخاخ ستيرويد أنفي:
- (Fluticasone furoate (Avamys أو Mometasone (Nasonex: بخة في كل منخر يومياً
- المهم: الستيرويد الأنفي بياخد 7-14 يوم عشان يآثر — ليس فورياً
- ده هو اللي هيجي الأنف ويقلل الاحتقان الارتدادي
- الرسالة للمريض:
- "الأوتريفيين مش دواء للاحتقان — ده دواء للطوارئ بس. استخدامه أكثر من 3 أيام يخلي جسمك يعتمد عليه وتبقى محتاجه أكثر وأكثر."

الأم: "ابني يبجبله نزيف في أنفه كثير خصوصاً في الصيف"

اسأل أولاً

- النزيف من منخر واحد ولا الاثنين؟
- فيه تاريخ كدمات كثيرة أو نزيف من مكان ثاني؟ (اضطراب تجلط؟)
- بيدخل إصبعة في أنفه؟ (السبب الأول عند الأطفال)
- الهواء في البيت جاف جداً؟

التشخيص

- نزيف متكرر من منطقة **Kiesselbach** الأمامية — كثافة عروق بالجزء الأمامي من الحاجز الأنفي
- الهواء الجاف + حك الأنف = تشقق + نزيف

التوصية

- إيقاف النزيف الحاد:
- أجلس الطفل منحنياً للأمام (مش للخلف)
- اضغط على الجزء اللين من الأنف $\times 10-15$ دقيقة متواصلة بدون ما تشوف
- لا تملخ أنفه بعدها لساعة
- للوقاية من التكرار:
- **Naseptin Cream (Neomycin + Chlorhexidine)**: ضع كمية صغيرة في مدخل كل منخر $\times$ مرتين يومياً $\times$ أسبوعين — تساعد على شفاء الغشاء المخاطي
- **Saline nasal spray**: رطب الغشاء المخاطي يومياً
- قلّم أطراف الطفل — يقلل الخدش
- رطب هواء غرفته لو جاف

تحذير — أحوله فوراً

- نزيف من الاثنين معاً
- لا يوقف بعد 20 دقيقة ضغط
- فيه كدمات سهلة في الجسم أو نزيف من اللثة — استبعاد اضطراب تخثر

المريض: "يا دكتور أنفي محتقن دائماً من شهور، وبيجيلي صلاع فوق عيني وبيجيلي بلغم بينزل في حلقي ((Post-nasal drip"

اسأل أولاً

- البلغم بينزل في حلقه خصوصاً في الصباح؟
- فيه حساسية معروفة؟
- سبق عمل أشعة جيوب؟
- جرب أي علاج؟

التشخيص

- احتقان مزمن + صلاع جيوب + بلغم ينزل = **Chronic Rhinosinusitis**
- في مصر: الحساسية التنفسية هي السبب الأكثر شيوعاً

التوصية

- الخط الأول:
- **Nasal Corticosteroid Spray:** العلاج الرئيسي للحالة المزمنة
- (Budesonide أو (Nasonex) Mometasone أو (Flixonase) Fluticasone (Rhinocort)
- بخة في كل منخر صباحاً × 4-8 أسابيع على الأقل
- الاستخدام الصحيح: إمل رأسك للأمام قليلاً، وجه البخاخ نحو الأذن (مش نحو حاجز الأنف)
- **Saline nasal irrigation** غسيل الأنف بالملح):
- الأكثر فعالية وفروة والأرخص
- محلول ملحي دافئ ويومي يطهر ويرطب ويزيل المخاط
- جهاز Neti Pot أو قارورة غسيل أنف
- إذا فيه حساسية:
- أضف مضاد هستامين جيل ثاني: Loratadine أو Cetirizine يومياً

تحذير — أحوله فوراً

- ما ردش على 4 أسابيع علاج
- احتمال حاجة لأشعة على الجيوب
- بعض الحالات تحتاج تنظير أو جراحة جيوب

ملخص سريع للفصل

الشكوى	أول سؤال	الخط الأول
رمد بكتيري	إفرازات صفراء؟	Chloramphenicol قطرة
رمد حساسي	حكة وعطس؟	Olopatadine قطرة
جفاف عيون	شاشة كثير؟	Hyaluronic acid drops
شعيرة جفن	خارجي أم داخلي؟	كمادة دافنة 4 ×
التهاب أذن خارجي	الأذنة بتأجع عند اللمس؟	Sofradex drops
شمع أذن	عود قطن سابق؟	زيت + شطف عند طبيب
احتقان ارتدادي	أوتريفين أكثر من أسبوع؟	فطام تدريجي + ستيرويد أنفي
نزيف أنف طفل	من منخر واحد؟	Naseptin + ضغط 15 دقيقة

📌 المبدأ الذهبي في ENT والعيون:

أي ألم داخل العين أو تغيير في الرؤية = طبيب عيون فوراً.

أعواد القطن والأوتريفين المتكرر = مشاكل لا حلول.

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال = طبيب، مش قطرة.

غسيل الأنف بالملح أفضل وأرخص من معظم البخاخات.

القسم الثاني — العيون والأذن والأنف · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

الجهاز الهضمي والكبد

[صورة غلاف توضيحية لفصل: الجهاز الهضمي والكبد]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

ملاحظة: شكاوى الجهاز الهضمي هي الأكثر تكراراً في الصيدليات المصرية يومياً. 80% منها يتتعالج بدون وصفة، 20% محتاجة تحويل.

الموضوع الأول — الحموضة والارتجاع

المريض: "يا دكتور بييجيني حرقه في المعدة والصدر بعد الأكل خصوصاً، وأحياناً بطلع طعم حامض في بقي"

اسأل أولاً

- بتيجي من امتي؟ أيام ولا شهور؟
- بتزيد بعد الأكل مباشرة؟ أو لما بيتكوم؟
- بياخد أسبرين أو إيبوبروفين أو مسكنات بانتظام؟
- بيدخن؟ بيشرب قهوة كثير؟
- فيه ألم في الصدر ينتشر للكتف أو الذراع؟ (مهم جداً — يستبعد قلب)
- فيه صعوبة في البلع؟
- فقدان وزن؟

الأعراض	الاحتمال
حرقه بعد الأكل، طعم حامض، بتزيد لما بيتكوم	ارتجاع معدي (GERD)
حرقه مع أسبرين/إيبوبروفين	تهيج معدة من NSAIDs
ألم في الصدر ينتشر للكتف أو الذراع	قد يكون قلبي — حوله فوراً
صعوبة البلع + فقدان وزن	محتاج تنظير — حوله للطبيب

التوصية

- حالة خفيفة عرضية:
- **Antacid: Rennie, Gaviscon, Maalox** — يعادل الحمض فوراً
- يُؤخذ بعد الأكل بساعة وعند النوم
- **Gaviscon أفضل** — يعمل طبقة فوق المعدة تمنع الارتجاع
- حالة متكررة أو مزعجة:
- **PPI مثبت مضخة البروتون):**
- **Omeprazole 20 mg** صباحاً قبل الأكل بـ 30 دقيقة
- **Esomeprazole** نيكسيوم (20-40 mg)
- **Pantoprazole 40 mg**
- مدة: 4-8 أسابيع — مش دايـم بدون إشراف طبيب
- نصائح غير دوائية لازم تقولها:
- متاكلش 2-3 ساعة قبل النوم
- ارفع رأس السرير 15-20 سم
- قلّل: قهوة، شيكولاتة، أكل حار، تدخين، كحول
- انقص الوزن لو زيادة
- خفف ضغط الملابس على البطن

تحذير — أحوله فوراً

- فيه صعوبة في البلع
- فقدان وزن غير مبرر
- الأعراض مستمرة أكثر من 4-8 أسابيع مع الدواء
- الألم شديد ومفاجئ
- فيه غثيان وقيء مع الدم (قهوة سوداء في القيء)

المريض: "أنا بباخذ فولتارين للظهر من شهرين وعنده حرقة معدة بقالي أسبوع"

اسأل أولاً

- فيه دم في البراز أو البراز لونه أسود (زفت)؟
- فيه ألم شديد في البطن؟
- قبل ما يبدأ الفولتارين كان عنده حرقة؟

التوصية

- الفولتارين (ديكلوفيناك) بيهيج المعدة — ده من أكثر NSAIDs ضرراً للمعدة
- أضف PPI فوراً: Omeprazole 20 mg قبل الأكل بـ 30 دقيقة يومياً
- انصح: ياخذ الفولتارين مع الأكل مش على معدة فاضية
- لو الألم شديد أو فيه دم: حوِّله للطبيب فوراً — احتمال قرحة

🚫 قاعدة مصرية مهمة: كل مريض بياخذ NSAID أكثر من أسبوع ولا مريض بقلب أو ضغط — لازم PPI جنبه. ده بروتوكول لازم تحفظه.

الموضوع الثاني — القرحة الهضمية و *H. pylori*

المريض: "عندي ألم في نص بطني فوق السرة، بيخف بعد الأكل بس بعدين بيزيد تاني، وصحيني من النوم كمان"

اسأل أولاً

- الألم بيخف مع الأكل؟ (قرحة اثنا عشرية) ولا بيزيد مع الأكل؟ (قرحة معدة)
- فيه دم في البراز؟ ولا لون أسود؟
- فيه غثيان أو قيء؟
- بياخد أسبرين أو NSAIDs؟
- أي حد في عيلته عنده *H. pylori* أو قرحة؟

التشخيص

- الألم اللي بيخف مع الأكل = قرحة الاثني عشر ((**Duodenal Ulcer**) — الأكثر شيوعاً في مصر
- الألم اللي بيزيد مع الأكل = قرحة المعدة
- ***H. pylori*** موجود في 70-90% من المرضى القرحة في مصر

التوصية

- لا تعطي علاج قرحة من عندك بدون تشخيص
- قوله يروح طبيب يعمل اختبار (*H. pylori* تنفس، برازي، أو تنظير)
- لو التشخيص واضح من تاريخ سابق وعنده وصفة قديمة:
- **× Omeprazole + Clarithromycin + Amoxicillin Triple therapy:**
- 14 يوم
- أو **Quadruple therapy** لو منطقة مقاومة

تحذير — أحوله فوراً

- براز أسود قطراني ((Melena = نزيف قرحة
- قيء فيه دم أو مادة زبي القهوة
- ألم حاد مفاجئ في البطن (انتقاب قرحة)
- انخفاض ضغط + إغماء

الموضوع الثالث — الغثيان والقيء

المريض: "واكلت حاجة من برّه بليل وصحيت الصبح وأنا باقيء وعندي غثيان"

اسأل أولاً

- فيه إسهال كمان؟ (تسمم غذائي غالباً)
- فيه حرارة؟
- فيه ألم في البطن؟ فين بالضبط؟
- أكثر من شخص في البيت زي كده؟ (تسمم جماعي)
- مريضة حامل؟ (غثيان الحمل)
- بياخد أي دواء جديد؟ (آثار جانبية)

الأعراض	الاحتمال
قيء + إسهال + بعد أكل مشبوه	تسمم غذائي — Gastroenteritis
قيء بدون إسهال + حرارة	التهاب فيروسي أو بكتيري
غثيان صباحي + سيدة في سن الإنجاب	احتمال حمل — اعمل اختبار
قيء مع ألم في اليمين أسفل	التهاب زائدة — طوارئ
قيء مع صداع شديد	تفكر في ضغط مرتفع أو هجرة

التوصية

- تسمم غذائي بسيط:
- أولاً: إمالة — الأهم من أي دواء
- (ORS محلول إمالة فموي) أو ماء + ملح + سكر
- سوائل صافية: شاي، مرق، ماء
- (Metoclopramide ماكسولون): 10 mg قبل الأكل بـ 30 دقيقة — ضد الغثيان
- (Domperidone موتيليوم): 10 mg قبل الأكل — أقل أعراض جانبية من ماكسولون
- (Ondansetron زوفران): للغثيان الشديد — الأقوى — يحتاج وصفة في الغالب
- نصائح أكل:
- البسكويت والرز والموز والتفاح ((BRAT diet الأول
- ابعد عن الأكل الدسم والحار

تحذير — أحوله فوراً

- جفاف شديد: جفاف الفم، مافيش بول، دوخة
- دم في القيء
- ألم بطن شديد
- قيء أكثر من 24 ساعة بدون تحسن
- أطفال صغار أو مسنين مع قيء

المريض (قريب المريض): "أمي بتعمل كيماوي وبتاقي جداً، فيه حاجة تساعدنا؟"

التوصية

- **Ondansetron** (زوفران): الأقوى ضد غثيان الكيماوي — بحسب وصفة
- **Metoclopramide** مساعد
- **Dexamethasone** بيدي مع الكيماوي كمضاد غثيان — من الطبيب
- نصح غير دوائي: وجبات صغيرة متكررة، ابعد عن روائح قوية، زنجبيل طبيعي
- المريضة محتاجة تتكلم مع طبيبتها اللي بيعملها الكيماوي

الموضوع الرابع — الإمساك

المريض: "يا دكتور أنا ماعتش من 4 أيام وبيأجيني بطني"

اسأل أولاً

- عادي بيوم إيه؟ يومي ولا كل يومين؟
- لون البراز؟ فيه دم؟
- فيه ألم شديد أو انتفاخ كبير؟
- بياخد أدوية بتسبب إمساك؟ (أوبيويدات، حديد، مضادات حموضة بالألومنيوم)
- مشروبات كافية؟ أكل ألياف؟
- كم عمره؟ وبيتحرك كافي؟

التشخيص

- قلة السوائل والألياف
- قلة الحركة
- الأدوية: الحديد، مضادات الاكتئاب، كودين
- الحمل
- كبر السن
- متلازمة القولون العصبي (IBS)

التوصية

- إمساك بسيط/عرضي:
- الخيار 1 — تحريك خفيف:
- (Lactulose دوبالاك): شراب — يجذب الماء للأمعاء — آمن حتى للحمل
- 15-30 مل مرتين يومياً — يبدأ أثر بعد 24-48 ساعة
- الأفضل للاستخدام طويل الأمد
- الخيار 2 — تحريك سريع:
- (Bisacodyl دولكولاكس): قرص أو لبوس — يؤثر بعد 8-12 ساعة (قرص) أو 30-60 دقيقة (لبوس)
- (Senna سينناكوت): عشبة طبيعية — آمنة ومتاحة
- لا تستخدم تحريك أكثر من أسبوع بدون استشارة
- الخيار 3 — ألياف:
- (Psyllium فيبوجل، ميتاموسيل): ألياف طبيعية — شرب ماء كثير معها ضروري
- نصائح غير دوائية:
- 8 كوبايات ماء على الأقل يومياً
- خضروات وفاكهة وخبز أسمر
- المشي 30 دقيقة يومياً
- ماتستنيش الحاجة الشديدة قبل ما تروح الحمام

تحذير — أحوله فوراً

- فيه دم في البراز
- إمساك جديد مع ألم وفقدان وزن — خاصة فوق 50 سنة (استبعاد سرطان)
- الإمساك مستمر أكثر من 3 أسابيع
- البطن منتفخ جداً وما فيش ريح

المريض (سيدة حامل): "يا دكتور الدكتور كتبلي حديد وبقيت متعبة جداً في الحمام"

التوصية

- الإمساك من الحديد شائع جداً — بالأخص كبريتات الحديد
- لا توقفي الحديد — مهم لك وللجنين
- أضيفي Lactulose مع الحديد — آمن في الحمل
- خدي الحديد بعد الأكل بدلاً من قبله — يقلل الإمساك والغثيان
- شربي ميه وعصير برتقال كثير (فيتامين C ييزود امتصاص الحديد كمان)

💡 ملاحظة: لو التحميل شديد، جربي Ferrous gluconate أو Ferrous fumarate بدل كبريتات الحديد — أقل إمساكاً

الموضوع الخامس — الإسهال

المريض: "عندي إسهال من الصبح، رحت الحمام 5 مرات تقريباً"

اسأل أولاً

- فيه دم أو مخاط في البراز؟
- فيه حرارة؟
- فيه ألم شديد في البطن؟
- أكل برة؟ أو فيه حد تاني في البيت زيه؟
- بياخد مضاد حيوي مؤخراً؟ (إسهال من المضاد)
- كم عمره؟ (مهم للأطفال)

الأعراض	الاحتمال
إسهال مائي بعد وجبة مشبوهة	تسمم غذائي / Gastroenteritis
دم ومخاط في البراز + حرارة	عدوى بكتيرية (سالمونيلا، شيجيلا)
إسهال بعد مضاد حيوي	إسهال مصاحب للمضاد الحيوي
إسهال متناوب مع إمساك + انتفاخ	قولون عصبي (IBS)
إسهال مزمن أكثر من 4 أسابيع	لازم تحقيق طبي

التوصية

- إسهال فيروسي / تسمم بسيط:
- ORS أولاً وأهم شيء — محلول إماعة
- محضّر: لتر ماء + ملعقة ملح + 6 ملاعق سكر + عصير ليمون
- أو جاهز: حفنة، بيدرياليت
- (**Loperamide** إيموديوم): يبطئ حركة الأمعاء — 2 mg بعد كل برازة سائلة، حد أقصى 16 mg/يوم
- لا تعطيه لو فيه دم في البراز أو حرارة — هيجس الميكروب جوا
- (**Smecta** ديوسمكتيت): يمص السموم — آمن وفَعَال — حتى للأطفال
- إسهال بكتيري (دم + حرارة):
- لا تعطي لوبراميد — حوّل للطبيب عشان يوصف مضاد حيوي مناسب (Ciprofloxacin أو Azithromycin حسب التشخيص)
- إسهال من مضاد حيوي:
- (**Saccharomyces boulardii** إنترول): خميرة طبيعية تحمي الأمعاء
- (**Lactobacillus** لاكيتاليت، بروبيوتيك): يعيد الفلورا الطبيعية
- استمر في المضاد الحيوي — ما توقفوش وحدك

تحذير — أحوّله فوراً

- دم في البراز مع حرارة
- جفاف شديد: مافيش بول 8 ساعات، جفاف فم، دوخة
- أطفال أقل من سنتين مع إسهال أكثر من يوم
- إسهال مستمر أكثر من 5 أيام

الموضوع السادس — انتفاخ وغازات

المريض: "يا دكتور بطني منتفخ دائماً ومعاي غازات كتير ويبأجعي"

اسأل أولاً

- يزيد بعد أكل معين؟ فول، عدس، ملوخية، مشروبات غازية؟
- فيه إسهال أو إمساك كمان؟
- الألم بيروح بعد الريح أو البراز؟ (علامة قولون عصبي)
- فقدان وزن؟ دم في البراز؟
- مريض بياخد أدوية جديدة؟

التشخيص

- انتفاخ + غازات + ألم بيخف بعد الريح = القولون العصبي ((IBS — الأكثر شيوعاً
- انتفاخ بعد الألبان = عدم تحمل اللاكتوز
- انتفاخ مستمر + دم + فقدان وزن = لازم طبيب فوراً

التوصية

- انتفاخ وغازات عادي:
- (**FlatulexSimethicone**, **Espumisan**): يكسر الفقاعات — آمن تماماً حتى للرضع
- (**Hyoscine** بوسكوبان): مضاد للتشنج المعوي — 10-20 mg
- **Charcoal tablets**: يمس الغازات
- قولون عصبي ((**IBS**):
- (**Mebeverine** دسباتالين): مضاد تشنج خاص للقولون — 135-200 mg قبل الأكل
- (**Peppermint oil** كبسولات نعناع): مثبت علمياً في **IBS**
- **Lactulose** أو **Psyllium** للإمساك المصاحب
- نصائح أكل: تجنب الكافيين، الكحول، الأكل الدسم، الغازيات
- عدم تحمل اللاكتوز:
- (**Lactase enzyme** لاكتيز) — يتأخذه مع منتجات الألبان
- أو تبديل لمنتجات خالية من اللاكتوز

الموضوع السابع — الكبد والصفراء

المريض: "يا دكتور عيني اصفرت من يومين وجلدي كمان، وبولي لونه أصفر غامق"

اسأل أولاً

- فيه ألم في الجنب الأيمن؟
- فيه حرارة؟
- قريب من حد مريض بالكبد؟
- بياخذ أى أدوية؟ (خصوصاً باراسيتامول بكميات كبيرة، مضادات حيوية)
- البراز لونه فاتح؟ (دليل انسداد)

التوصية

- لا تعطي أى دواء وحدك — الاصفرار دليل على مشكلة في الكبد أو الصفراء وتحتاج تشخيص
- حوِّله للطبيب فوراً — اليرقان (الصفراء) محتاج تحاليل: وظائف كبد، بيليروبين، فيروسات كبد
- إذا فيه ألم شديد في اليمين + حمى: ده تشير لالتهاب المرارة — طوارئ

المريض: "الدكتور قالي إنزيمات كبدي مرتفعة وطلب مني أخسر وزن وياخد حاجة، في حاجة تنفع؟"

اسأل أولاً

- كام الإنزيمات؟ ضعف الطبيعي ولا أكثر؟
- الدكتور قاله السبب إيه؟
- بياخد أى دواء؟
- بيشرّب كحول؟ (مهم للتشخيص)
- فيه سكري أو كولسترول؟

التوصية

- مكملات مدعومة علمياً لصحة الكبد:
- (Silymarin شوك الجمل — Milk Thistle: حماية خلايا الكبد —
Hepatoreg, Legalon 140 mg × 3
- (Ursodeoxycholic acid أورشوفالك): لالتهاب الكبد الدهني والصفراوي —
بيحتاج وصفة
- فيتامين E: مفيد في الكبد الدهني بدون كحول (NAFLD)

⚠ تحذير مهم جداً: مريض الكبد لازم يتجنب الباراسيتامول بجرعات عالية. الحد الأقصى له 2 غرام يومياً بدل
4.

ملخص سريع للفصل

الشكوى	أول سؤال	الخط الأول
حرقة معدة	من امتى؟ بياخذ NSAIDs؟	Antacid / Omeprazole
غثيان وقيء	فيه دم؟ فيه إسهال؟	ORS + Metoclopramide
إمساك	من امتى؟ فيه دم؟	Lactulose / Bisacodyl
إسهال	فيه دم؟ فيه حرارة؟	(ORS + Loperamide بدون دم)
انتفاخ وغازات	بيروح بعد الريح؟	Simethicone / Mebeverine
اصفرار	ألم فى اليمنى؟	حوّله فوراً للطبيب

❓ المبدأ الذهبى في الجهاز الهضمي:

الإمالة أهم من أى دواء فى الغثيان والإسهال.

الباراسيتامول آمن للمعدة — الإيبوبروفين لأ.

أى دم فى البراز أو القيء = طوارئ.

الإمساك المزمن الجديد فوق 50 سنة = طبيب.

القسم الثانى — الجهاز الهضمى والكبد · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

المضادات الميكروبية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: المضادات الميكروبية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

هذا الفصل مختلف عن **prereq_03** في الـ prereq اتعلمت العلم — هنا تتعلم القرار. متى تصرف؟ متى ترفض؟ متى تحول؟ وكيف تشرح للمريض؟

الموضوع الأول — قرارات الصرف

المريض: "يا دكتور عندي زكام وكحة من 4 أيام، عايز أموكسيسيلين عشان يخلص بسرعة"

التوصية

- أولاً — افهم المريض:
- المريض مش غلطان إنه يطلب — ده اللي اتعود عليه. شغلتك تصح الفكرة بدون ما تخليه يحس بالإهانة.
- ما تقوله:

"أنا فاهم إنك عايز تتعالج بسرعة، لكن خليني أوضحك — الزكام والكحة دول في 90% من الحالات بيحوا من فيروس، والمضاد الحيوي بيقتي على البكتيريا بس مش على الفيروسات. لو اخدته دلوقتي هيعمل حاجتين: أولاً مش هيفيدك، وتانياً هيدمر البكتيريا النافعة في جسمك ويخليك عرضة لبكتيريا مقاومة المرة الجاية لما تحتاجه فعلاً."

بعدين صرف له علاج أعراض فعلي:

- مذيّب بلغم (جوايفينيسين)
- مضاد احتقان (سودافيد أو أوتريفين $\times 3$ أيام)
- مسكن للصداع والحرارة
- قوله إن النزلة بتخلص لوحدها في 7-10 أيام

المريض: "يا دكتور حلقي بيأجيني وعارف إن الأموكسيسيلين ينفعني، عايزه"

اسأل أولاً

- فيه حرارة عالية؟
- فيه كحة وزكام معه؟ (يشير لفيروس)
- اللوزتين منتفختين فيهم بقع بيضاء؟
- عنده حساسية من البنسلين؟

العرض	نقطة
حرارة فوق 38	1+
تضخم غدد الرقبة الأمامية	1+
بقع بيضاء على اللوزتين	1+
غياب الكحة	1+

- 0-1 نقطة: فيروسي — لا مضاد حيوي
- 2-3 نقاط: محتمل — رأي الطبيب
- 4 نقاط: بكتيري محتمل جداً — مضاد حيوي

التوصية

- لو ≥ 1 Centor: رفض الأموكسيسيلين وصرف علاج أعراض (تانتوم، باراسيتامول)
- لو: 3-4 Centor حوِّله للطبيب — هو اللي يقرر ويأخذ مسحة حلق
- لا تصرف من عندك على علامات بكتيرية إلا لو الصورة واضحة جداً وفيه بروتوكول واضح

المريض: "يا دكتور عندي حرقان في التبول من امبارح، عارف إنه التهاب بول، عايز أموكسيسيلين"

اسأل أولاً

- رجل ولا امرأة؟ (التهاب البول في الرجال أقل شيوعاً واحتاج تقييم أعمق)
- فيه حرارة أو ألم في الظهر أو جانبه؟ (يشير لالتهاب الكلية — Pyelonephritis)
- حامل؟
- مريض سكري؟
- من امتى؟
- سبق حصله وعرف التشخيص؟

الحالة	الأعراض	الإجراء
UTI بسيطة (سيدة، بدون حمى)	حرق + تكرار بول	ممكن علاج بدون ثقافة
UTI مع حمى وألم ظهر	+ حمى + ألم جانبي	طبيب — Pyelonephritis
UTI في رجل	أى أعراض	طبيب دائماً
UTI عند حامل	أى أعراض	طبيب دائماً

التوصية

- سيدة غير حامل، UTI بسيطة متكررة عندها تشخيص سابق:
- (**Trimethoprim-Sulfamethoxazole**) **Bactrim / Septrin**: DS قرص مرتين يومياً $\times 3$ أيام
- أو **Nitrofurantoin** 100 mg مرتين يومياً $\times 5$ أيام — ممتاز للبول بس
- أو **Ciprofloxacin** 250-500 mg مرتين $\times 3$ أيام
- لا أموكسيسيلين وحده — مقاومة عالية جداً لـ *E. coli* في مصر
- للتخفيف الفوري:
- (**Phenazopyridine**, **Urotabs**, **Pyridium**): مسكن موضعي لحرقان البول — يلون البول بني/برتقالي (طبيعي)
- شرب ميه كثير جداً — 2-3 لتر يومياً
- حوِّله للطبيب إذا:
- فيه حمى أو ألم ظهر
- رجل أو حامل
- ما اتحسنش بعد 3 أيام

الأم: "ابني عنده 2 سنة وحرارته من يومين، كتبوله في المستشفى أموكسيسيلين معلق، عايزه"

اسأل أولاً

- الوصفة معاهما؟
- كام وزن الطفل؟ (لتأكيد الجرعة)
- فيه حساسية من البنسلين في العيلة؟

التوصية

- **25-50 mg/kg/day** مقسمة على 3 جرعات
- لو وزنه 12 كيلو:
- الجرعة اليومية: $40 \times 12 = 480$ mg
- كل جرعة: 160 mg = حوالي 6.5 mL من معلق 125 mg/5 mL
- تعليمات المعلق:
- لازم يرجه كويس قبل كل جرعة — المادة الفعالة بتترسب في الأسفل
- بعد تحضير المعلق: يتحفظ في الثلاجة — يصلح 7-14 يوم حسب النوع (اقرأ التعبئة)
- استخدم السرينجة الصغيرة اللي جاية مع العبوة مش ملعقة — أدق

الموضوع الثاني — الأعراض الجانبية والتفاعلات

المريض: "يا دكتور الدكتور كتبلي أموكسيسيلين لكن عندي حساسية من البنسلين"

اسأل أولاً

- إيه اللي حصل لما أخذ البنسلين قبل كده؟
- طفح جلدي بسيط؟ ولا انتفاخ وجه وضيق تنفس؟

النوع	الأعراض	الخطورة
حساسية حقيقية (IgE-mediated)	شرى + انتفاخ + ضيق تنفس (أنفيلاكسيس)	خطير — ممنوع مطلق
حساسية غير حقيقية	طفح جلدي خفيف أو إسهال	قد يكون من الدواء نفسه مش تفاعل مناعي

التوصية

- حساسية حقيقية (أنفيلاكسيس): ممنوع تماماً أي بنسلين أو سيفالوسبورين
- البديل: (Azithromycin زيثروماكس) أو (Clarithromycin كلاسيدي) أو Doxycycline حسب نوع العدوى
- طفح خفيف فقط (ليس أنفيلاكسيس):
- احتمال تصالب مع سيفالوسبورينات 1-2% فقط
- الطبيب هو اللي يقرر لو السيفالوسبورين ضروري
- لا تصرف الأموكسيسيلين — أبلغ الطبيب الكاتب وعدّله

المريض: "يا دكتور بياخد أزيثروميسين وبياخد كمان كلاريثروميسين للمعدة ((H. pylori. ينفع يجمعهما؟"

التوصية

- لا — لا تجمع ماكروليدين مع بعض
- الكلاريثروميسين ((Clarithromycin نفسه ماكروليد — تضاعف الآثار الجانبية
- كلاهما يبطل QT في مخطط القلب — مجتمعين أكثر خطورة
- أبلغه يرجع للطبيب لمراجعة الوصفة

المريض: "يا دكتور الدكتور في الخارج كاتبلي Z-pack، إيه ده؟"

التوصية

- Azithromycin 500mg Z-pack = 500mg 1 يوم، ثم 250mg × 4 أيام
- في مصر عادةً ببيجي بحبتين 250 mg في اليوم الأول (= 500) ثم حبة يومياً × 4 أيام
- مجموع الكورس: 5 أيام
- فعّال لـ: التهاب الجهاز التنفسي، الكلاميديا، التهاب الأذن
- ملاحظة مهمة:
- نصف عمره طويل جداً (68 ساعة) — الدواء بيظل في الجسم أسابيع بعد آخر جرعة
- ده سبب قصر الكورس مقارنة بالأمبيسيلين أو الأموكسيسيلين

الموضوع الثالث — المضادات الحيوية الشائعة في مصر

الحالة 8 — مريض يسأل عن الفرق بين أوجمنتين وأموكسيسيلين

المريض: "يا دكتور الأوجمنتين أحسن من الأموكسيسيلين؟ ليه بعض الدكاترة بيكتبوا الأعلى؟"

Augmentin (Amoxicillin + Clavulanate)	Amoxicillin	
أموكسيسيلين + كلافيانات	أموكسيسيلين فقط	التركيب
يثبط بيتا-لاكتاماز (إنزيم البكتيريا المقاومة)	—	دور الكلافيانات
عدوى بكتيريا مقاومة للأموكسيسيلين	عدوى بكتيريا حساسة	الاستخدام
إسهال وغثيان أكثر	أقل	الأعراض الجانبية
أعلى	أرخص	السعر

متى يُستخدم الأوجمنتين؟

- عدوى لم تستجب للأموكسيسيلين
- التهاب الجيوب الأنفية البكتيري
- لدغات حيوانات (تغطي Pasteurella)
- التهاب الأذن الوسطى عند مرضى سبق غُولجوا بمضاد
- عدوى جلدية شديدة

الخلاصة: الأموكسيسيلين أولاً لو البكتيريا ليها حساسية — الأوجمنتين للمقاومة.

المريض: "يا دكتور الفلاجيل ده لإيه بالظبط؟"

التوصية

• (Flagyl) Metronidazole يُستخدم في:

الحالة	الجرعة	الملاحظة
جيارديا (إسهال مزمن)	250-500 mg $\times$ 3 $\times$ 5-10 أيام	شائع جداً في مصر
أميبيا (أميبيازيس)	750 mg $\times$ 3 $\times$ 10 أيام	مع ديلوكسانيد بعدها
Bacterial Vaginosis	400 mg $\times$ 2 $\times$ 7 أيام	أو جل مهبلي
C. difficile	500 mg $\times$ 3 $\times$ 10 أيام	من المضادات الحيوية
أسنان (لاموائيات)	400 mg $\times$ 3 $\times$ 5-7 أيام	مع أموكسيسيلين للخراج
(H. pylori مع أدوية أخرى)	500 mg $\times$ 2 $\times$ 14 أيام	جزء من الثلاثي

⚠ تحذيرات الفلاجيل:

- ممنوع مع الكحول تماماً — يسبب تفاعل (antabuse) حمراً، غثيان، قيء شديد، خفقان) حتى 48 ساعة بعد آخر جرعة
- طعم معدني في الفم — طبيعي
- ممكن يغير لون البول لأحمر-بنّي — طبيعي
- تجنب في الثلث الأول من الحمل

المريض: "يا دكتور عندي التهاب وحرقان في منطقة حساسة وإفرازات"

اسأل أولاً

- الإفرازات لونها إيه؟ صفراء؟ بيضاء؟ مائية؟
- فيه ألم عند التبول؟
- فيه تقرح أو جرح؟
- متزوج؟ العلاقة الجنسية الأخيرة؟

الأعراض	الاحتمال
إفراز أصفر/أخضر + حرقان في التبول	سيلان (Gonorrhea)
إفراز مائي شفاف + حرقان	كلاميديا
تقرح مؤلم	هريس تناسلي
تقرح بدون ألم	سيفلس (الزهري)
فطريات بيضاء	كانديدا — شائع مع مضادات حيوية

التوصية

- للكلاميديا: Azithromycin 1g جرعة واحدة أو Doxycycline 100 mg $\times$ 7 أيام
- للسيلان: Ceftriaxone 500 mg IM جرعة واحدة — يحتاج حقنة عند طبيب
- للفطريات (كانديدا): Fluconazole 150 mg جرعة واحدة فموي

⚠ مهم جداً: الأمراض التناسلية في مصر تُعالج لكن غالباً سرية. تعامل مع المريض باحترام وخصوصية. الشريك يحتاج علاج أيضاً. بعض الحالات تحتاج طبيب جلدية أو تناسلية.

الموضوع الرابع — مقاومة المضادات الحيوية

المريض: "يا دكتور أخذت أموكسيسيلين 3 أيام ومش بتحسن، أغير؟"

اسأل أولاً

- أخذ الكورس كامل بانتظام؟
- الجرعة صح؟
- التشخيص مؤكد؟ (التهاب فيروشي مش هستجيب أصلاً)
- فيه تاريخ أخذ نفس المضاد كثير؟

التوصية

- لو أخذ 3 أيام بس وما اشتغلش:
- لو التشخيص فيروسي: الأموكسيسيلين ما كانش هيشغل أصلاً
- لو بكتيري: قد تكون البكتيريا مقاومة — يرجع الطبيب لثقافة مزرعة وتغيير الدواء
- لا تعطيه مضاد حيوي مختلف من عندك — الطبيب يقرر بعد تقييم
- شرح مبسط للمقاومة للمريض:

"لما الواحد بياخد مضاد حيوي من غير ما يحتاجه أو يوقفه قبل ما يخلص، البكتيريا بتتعلم تتحملة وتبقى أقوى. الوقت الجاي نفس الدواء ما يأثرش عليها."

المريض: "أنا بجيلي التهاب حلق كل شتاء وكل مرة الدكتور بيكتيلي كلاريثروميسين، عايزه بدون وصفة"

التوصية

- إذا كانت الصورة متطابقة (حمى + لوزتين + بقع بيضاء) وعنده تشخيص موثق سابق:
- اسمحله بالكورس لكن مع تحذير واضح
- **Clarithromycin 500 mg** مرتين يومياً $\times 10$ أيام (مش أقل)
- لو الصورة مختلفة هذه المرة (مثلاً زكام معه أو بدون حمى): لا تصرف
- ⚠ تحذير الكلاريثروميسين:
- تفاعلات دوائية كثيرة — يزيد تركيز: ستاتينات، warfarin، بعض أدوية القلب
- يُطيل QT — تجنب مع أدوية قلب الإيقاع
- يحتاج تخفيف جرعة في الفشل الكلوي

ملخص قرارات المضادات الحيوية

الطلب	قرارك	البديل لو رفضت
نزلة برد + طلب أموكسيسيلين	✗ رفض	علاج أعراض
حلق أحمر بدون حمى	✗ رفض	تانتوم + براسيتامول
حلق + حمى + بقع بيضاء	⚠ طبيب	تانتوم + طبيب
حرق بول في سيدة متكررة	✓ ممكن	Bactrim $\times 3$ أيام
حرق بول في رجل	✗ طبيب دائماً	—
كورس ناقص يطلب تكملة	✓	صرف الباقي
غير مضاد بدون طبيب	✗ رفض	رجعه للطبيب

❓ المبدأ الذهبي في المضادات الحيوية:

الفيروس لا يستجيب للمضاد الحيوي — أبداً.

أكمل الكورس حتى لو تحسنت — البكتيريا الباقية هي المقاومة.

مريض سبق أخذ المضاد كثير = احتمال مقاومة.

التهاب البول في الرجل دائماً يحتاج طبيب.

القسم الثاني — المضادات الميكروبية · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

الأدوية الحيوية والحقن

[صورة غلاف توضيحية لفصل: الأدوية الحيوية والحقن]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

تذكر: في الصيدلية مش بتعطى الحقن أنت — لكن بتصرفها ويتشرح للمريض كيفية الاستخدام والتخزين. الفهم الغلط في الحقن = علاج غلط.

الموضوع الأول — الأنسولين

المريض: "يا دكتور الدكتور حولني للأنسولين وأنا خائف، مش عارف أعمل إيه"

اسأل أولاً

- أي نوع أنسولين وصفه؟
- وصفه قلم ((Pen ولا سرنجة؟
- الجرعة كام وحدة؟
- عنده جهاز قياس السكر؟

التوصية

- أولاً — أنواع الأنسولين وأوقاتها:

النوع	المثال	متى تُعطى	تأثير في دقائق
سريع جداً Rapid-acting))	Humalog , NovoRapid Apidra	مع وجبة الأكل مباشرة أو قبلها بـ 5 دقائق	يبدأ في 15 دقيقة
قصير Short-acting))	Humulin R , Actrapid	قبل الأكل بـ 30 دقيقة	يبدأ في 30-45 دقيقة
متوسط Intermediate NPH))	Humulin N , Insulatard	مرتين يومياً	يبدأ في 1-2 ساعة
طويل Long-acting))	(Glargine) Lantus , Levemir	مرة واحدة يومياً في نفس الوقت	لا قمة — يعمل 24 ساعة
مخلوط Mixed))	Mixtard , NovoMix 30	قبل الإفطار والعشاء	مزيج سريع وبطيء

ثانياً — تقنية الحقن بالقلم:

1. اغسل إيديك بالماء والصابون
2. امسح مكان الحقن بكحول وانتظر يجف
3. اضبط الجرعة بدوّار القلم
4. اختبر قطرتين في الهواء قبل الحقن ((Air shot — يضمن تدفق الأنسولين
5. اقرص الجلد بـ إبهامك وسبابتك (لو نحيف) أو حقن مباشرة (لو وزن طبيعي)
6. ادخل الإبرة بزاوية 90 درجة

7. اضغط الزر تماماً واحسب 10 ثواني قبل ما تسحب
 8. اسحب الإبرة وارمي الكاب الخارجي فوراً — اللبنة تُستخدم مرة واحدة فقط
- ثالثاً — أماكن الحقن ودوارها:

البطن (الأسرع امتصاصاً)

- على جنين السرة - 5 سم على الأقل بعيد عنها -
- يسار الجزء العلوي → يمين الجزء العلوي → يسار الأسفل → يمين الأسفل

الفخذ الخارجي (أبطأ امتصاصاً)

- الجزء الخارجي الأمامي فقط - مش الداخلي ومش الخلفي -

الذراع الخارجي

- الجزء الخلفي الخارجي - يحتاج مساعدة غالباً -

الدوران بين الأماكن مهم جداً — الحقن في نفس المكان دائماً يسبب Lipodystrophy (تكتلات دهنية) تخلي الامتصاص غير منتظم والسكر يتقلب.

رابعاً — التخزين:

- غير مفتوح: ثلاجة 2-8 درجة — بعيد عن الفريزر والحائط (مش يتجمد)
- مفتوح / جاري استخدامه:
- درجة حرارة الغرفة أقل من 30 درجة
- Lantus و Levemir 28 يوم بعد الفتح
- NovoRapid 28 يوم
- NovoMix 14 يوم
- لا تعرضه لشمس مباشرة أو حرارة — الصيف في مصر مشكلة حقيقية

المريض: "يا دكتور بياخذ أنسولين بانتظام لكن السكر بيتقلب بشكل غريب"

اسأل أولاً

- بيحقن في نفس المكان دايماً؟ (أول سؤال)
- بيدور أماكن الحقن؟
- فيه تكتلات صلبة في مكان الحقن؟
- القلم أو الأنسولين اتعرض لحرارة زيادة؟
- اللبنة جديدة كل مرة؟

التشخيص

- **Lipodystrophy** السبب الأول — الحقن في نفس المنطقة دايماً
- **Lipoatrophy** تضرر الأنسجة الدهنية
- أنسولين تالف من الحرارة
- إبرة مكسورة أو مسدودة
- جرعة غير صحيحة

التوصية

- افحص مكان الحقن — لو فيه تكتلات: تجنب الحقن فيها تماماً لعدة أشهر
- ذكره بأهمية الدوران
- تأكد من سلامة تخزين الأنسولين
- غير اللبنة كل حقنة

الحالة 3 — مريض يسأل عن الفرق بين لانتوس وتوجيو

المريض: "يا دكتور الدكتور غير اللانتوس بتاعتي بتوجيو — في فرق؟"

Glargine U-300)Toujeo (	Glargine U-100)Lantus (	
300 وحدة/mL	100 وحدة/mL	التركيز
~36 ساعة، أكثر استقراراً	~24 ساعة	المدة
أصغر (نفس الجرعة في ثلث الحجم)	أكبر	الحجم
شبه معدومة — أكثر ثباتاً	خفيفة	القمة
هبوط سكر ليلي متكرر، احتياج جرعة عالية	معظم المرضى	المناسب لـ

تحذير مهم:

- الجرعة بالوحدات لا تتغير (لو الطبيب كتب 20 وحدة لانتوس = 20 وحدة توجيو)
- لكن الحجم في القلم مختلف — السرنجة لا تُستخدم لتوجيو — قلم مخصص فقط

الحالة 4 — انتهاء صلاحية الأنسولين قبل الاستخدام

المريض: "يا دكتور كارتريج الأنسولين بتاعتي خلص قبل الوقت، أكمل الجرعة بالمتبقي؟"

التوصية

- لو الكارتريج مفتوح من أكثر من 28 يوم: لا تستخدمه — الأنسولين يتلف
- لو الجرعة الباقية في الكارتريج أقل من المطلوبة في وجبة واحدة:
- لا تخلط أنسولينات من كارتريجات مختلفة
- استخدم الباقي وكمل الفرق من كارتريج جديد بحقنيتين منفصلتين
- أفضل: افتح كارتريج جديد

الموضوع الثاني — الحقن الطبية الأخرى

المريض: "يا دكتور عايز حقنة B12 بياخدها كل شهر"

اسأل أولاً

- فيه تشخيص بنقص B12؟
- سبق عمل تحليل؟
- ليه فضل الحقن على الأقراص؟

التوصية

- فموي vs حقن B12:

حقن (IM)	فموي (أقراص/تحت اللسان)	
—	متساوية في معظم الحالات	الفعالية
مباشر — يتجاوز الأمعاء	يحتاج Intrinsic Factor سليم	الامتصاص
نقص بسبب Pernicious Anemia أو سوء امتصاص	نقص بسبب قلة الأكل أو ميتفورمين	المناسب لـ
يحتاج ممرض	أسهل وأرخص	السهولة

جرعة حقن B12 لو لازم:

• **Cyanocobalamin 1000 mcg IM:**

- بداية: يومياً $7 \times$ أيام، ثم أسبوعياً $4 \times$ أسابيع
- صيانة: شهرياً مدى الحياة (لو سبب مزمن)

• لو مجرد نقص من قلة أكل أو ميتفورمين: **Methylcobalamin 1000 mcg فموي** يومياً كافي تماماً

تحذير: الحقنة نفسها ممكن تسبب ألم وأحياناً تفاعل حساسية — لازم الصيدلية تكون مجهزة لأي تفاعل.

المريض: "يا دكتور عندي ألم في ركبتي، سامع إن في حقنة كورتيزون في المفصل بتريح"

التوصية

- حقن الكورتيزون في المفصل ((Intra-articular: تتم فقط من طبيب متخصص (روماتولوجي أو عظام)
- لا تصرف ولا توجه لحقنة غير طبية
- لو محتاج كورتيزون جهازى ((systemic: من وصفة طبيب
- للألم المؤقت:
- أقراص Prednisolone مع وصفة طبيب
- أو Diclofenac جل موضعي + مسكن فموي

المريض: "يا دكتور الدكتور في المستشفى كتبلي إنوكسابارين (كلكسان) حقن SC في البيت بعد العملية"

التوصية

- ما هو الكلكسان؟
- (Clexane)Enoxaparin: هيبارين منخفض الوزن الجزيئي — يمنع تجلط الدم
- يُعطى بعد العمليات الكبرى، الجلطات، السفر الطويل
- طريقة حقن (SCتحت الجلد):
- اختر منطقة البطن (يمين أو يسار السرة — لا تحقن فيها مباشرة)
- امسح بكحول وانتظر يجف
- اقرص جلدة البطن برفق
- ادخل الإبرة 90 درجة (أو 45 لو نحيف جداً)
- اضغط الجالّة ببطء حتى تنتهي كل المحلول
- انتظر 10 ثواني قبل السحب
- لا تفرك المنطقة بعد الحقن — ببسبب كدمة
- تحذيرات:
- علامات نزيف: دم في البول أو البراز، كدمات كبيرة، نزيف لا يتوقف — روح الطبيب فوراً
- لا تحقن في مناطق كدمات أو ندوب
- تخزين: ثلاثة — أو درجة حرارة الغرفة لو في المسافرة قصيرة

الموضوع الثالث — اللقاءات في الصيدلية

المريض: "يا دكتور عايز تطعيم الإنفلونزا، هل ممكن هنا في الصيدلية؟"

التوصية

- من الأولى بالتطعيم؟
- مسنون فوق 65 سنة
- مرضى السكري، القلب، الرئة المزمنة، الكلى
- حوامل — آمن في كل مراحل الحمل
- مرضى ضعف المناعة (كيماوي، HIV، ستيرويد مزمن)
- العاملون في الصحة
- أي شخص يريد الوقاية
- متى؟
- أكتوبر — نوفمبر الأفضل (قبل موسم الإنفلونزا)
- مرة واحدة سنوياً
- تعليمات اللقاح:
- الحقنة IM في عضلة الذراع ((Deltoid
- لا تعطى في الوريد أبداً
- ممكن يعمل ألم في مكان الحقن، خفقان خفيف أو حرارة طفيفة $1-2 \times$ يوم — هذا طبيعي ومش الإنفلونزا
- مش صح إن اللقاح يعمل إنفلونزا — المحتوى لقاح معطل مش فيروس حي
- تحذير:
- تأجيل لو عنده حمى وقت التطعيم
- حساسية من البيض الشديدة: استشر الطبيب أولاً (لقاحات خالية من البيض متاحة)
- تخزين اللقاح:
- 2-8 درجة ثلاجة — لا يتجمد
- لا يتعرض للضوء

المريض: "يا دكتور انجرحت بحاجة صدئة وما أتذكرش آخر مرة أخذت تطعيم كزاز"

التوصية

- تقييم الحاجة للتطعيم:

التاريخ التطعيمي	الجرح نظيف	الجرح متلوث / صدئ
أخذ جرعة كاملة منذ أقل من 5 سنين	لا يحتاج	لا يحتاج
أخذ جرعة كاملة منذ 5-10 سنين	لا يحتاج	جرعة تقوية (Td Booster)
أخذ جرعة كاملة منذ أكثر من 10 سنين	جرعة تقوية	جرعة تقوية
مش عارف تاريخه أو ما أطلعمش	جرعة تقوية	جرعة تقوية + Immunoglobulin

الجرعة:

• **Td أو Tdap: 0.5 mL IM** في عضلة النراع

• لو مش عارف تاريخه وجرح متلوث: محتاج (**TIG**)Tetanus Immunoglobulin
أيضاً — من الطبيب

المريضة: "أنا حامل 7 شهور، أي تطعيمات ممكن أخذها أو لازم أخذها؟"

التوصية

- آمن وموصى به في الحمل:
- إنفلونزا ((Influenza: آمن في كل الثلاثات — ينصح به بشدة
- (Tdap كزاز + دفتيريا + سعال ديكبي): في الثلث الثالث (27-36 أسبوع)
- يحمي الرضيع بعد الولادة
- ممنوع في الحمل — لقاحات حية:
- (MMR حصة + تكاف + حصة ألمانية)
- جدري الماء ((Varicella)
- لقاح الأنفلونزا الأنفي ((Live attenuated)

الموضوع الرابع — أمبولات وحقن شائعة في الصيدلية

المريض: "يا دكتور عندي ألم شديد في ظهري، عايز حقنة فولتارين"

اسأل أولاً

- عنده وصفة؟
- فيه كلى ضعيفة أو ضغط؟
- بياخد مضاد تخثر؟
- فيه إشكالية في ضغطه؟

التوصية

- (Diclofenac amp فولتارين حقن) 75 mg IM في العضلة — مسكن وضاد التهاب قوي
- لا تُعطى في الوريد — فقط IM عميق في عضلة الـردفين
- آثار جانبية: تهيج معدة، كلى، خطر نزيف
- موانع: كلى ضعيفة، قرحة نشطة، الحمل (الثالث الثالث)، مع وارفارين
- مدة التأثير:
- تأثير سريع خلال 20-30 دقيقة
- يستمر 8-12 ساعة
- لو مفيش وصفة: صرف فولتارين أقراص أو جل — الحقن تحتاج إشراف طبي.

المريض: "يا دكتور بييجيلي تشنج في رجلي بالليل، قالولي أأخذ مغنيسيوم"

التوصية

- لتشنج العضلات الليلي:
- **Magnesium oxide/citrate/glycinate** أقراص: أفضل وأمن من الحقن
- **Magnesium oxide 400 mg** رخيص لكن أقل امتصاصاً — ممكن يسبب إسهال
- **Magnesium citrate**: أفضل امتصاصاً وأقل إسهالاً
- **Magnesium glycinate** الأفضل في الامتصاص والأقل في الأعراض الجانبية
- للحقن (لو إشارة طبية):
- **Magnesium sulfate amp**: للحالات الشديدة فقط في المستشفى — خطر على القلب لو أُعطى بسرعة
- نصائح إضافية للتشنج:
- تمدد العضلات قبل النوم
- ترطيب كافٍ — شرب مياه كافية
- تدليك خفيف للعضلة أثناء التشنج
- كمادة دافئة بعد التشنج

ملخص سريع للفصل

الموقف	أول سؤال	الإجراء
أنسولين جديد	قلم ولا سرنجة؟	شرح كامل للتقنية والتخزين والدوران
سكر متقلب رغم الأنسولين	بيحقن في نفس المكان؟	تحقق من Lipodystrophy
مرضى يطلب حقن B12	فيه نقص مؤكد؟	Methylcobalamin فموي كافي في معظم الحالات
تطعيم إنفلونزا	عنده أمراض مزمنة؟	موصى به بشدة لمرضى المزمّن
كزاز بعد جرح	آخر تطعيم امتى؟	فوق 10 سنين = جرعة تقوية
حقنة فولتارين بدون وصفة	عنده كلى أو قرحة؟	أقراص بديل — الحقن يحتاج طبيب

❓ المبدأ الذهبي في الحقن:

الأنسولين بيتلف بالحرارة وبالحقن في نفس المكان.

اللبنة مرة واحدة فقط — ليس توفيراً.

اللقاحات في الثلاجة — لا تُجمّد ولا تُعرّض للحرارة.

أى حقن IV تتم في المستشفى — مش في الصيدلية.

القسم الثانى — الأدوية الحيوية والحقن · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

الجلد والعناية الموضعية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: الجلد والعناية الموضعية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

الجلد هو الأكثر وضوحاً — المريض بيجيلك يعرفك شوف وتشخص. لازم تعرف تميز اللي بتصرف له من اللي بتحوّله لطبيب جلدية.

الموضوع الأول — الفطريات الجلدية

المريض: "يا دكتور بين أصابع قدامي تشقق وحكة وبيجيلي رائحة"

اسأل أولاً

- فيه قشور أو احمرار بين الأصابع؟
- الجلد بين الأصابع رطب ومتفسخ؟
- بيتمرن ولا بيتوقف في أماكن مشتركة (جيم، حمام سباحة)؟
- ببيجيه في الصيف أكثر؟
- فيه مريض سكري؟

التشخيص

• **Tinea Pedis** قدم الرياضي: فطريات بين أصابع القدمين — الأكثر شيوعاً

التوصية

- كريم مضاد فطريات موضعي:
- **Clotrimazole** كلوتريمازول: كريم 1% × مرتين يومياً
- **Terbinafine** لاميزيل: كريم 1% — الأسرع مفعولاً — مرة يومياً
- **Miconazole** داكلارين: كريم أو بودرة
- المدة: استمر أسبوعين بعد اختفاء الأعراض (4 أسابيع كلهم)
- نصائح مهمة جداً:
- جفف القدمين كويس خصوصاً بين الأصابع بعد الاستحمام
- مش جرب في الجيم أو الأماكن المشتركة
- غيّر الجوارب يومياً — كوتون أفضل
- استخدم بودرة مضاد فطريات في الجوارب

تحذير — أحوّله فوراً

- مريض سكري — الفطريات عنده أخطر وبتتعدد
- انتشرت لباقي الجسم
- ما ردّتش على الكريم بعد 4 أسابيع

المريض: "يا دكتور عندي حكة وطفح في الفخذ والمنطقة اللي تحت البطن، دايرة شكل بيتوسع"

اسأل أولاً

- الحلقة بتكبر؟ فيه حدود واضحة محمرة؟
- فيه إفرازات؟
- بيحصل معاه كتير؟ بيعرق كتير؟
- بيستخدم ملابس ضيقة؟

التشخيص

- (**Tinea Cruris** سعفة الفخذ): فطريات — الشكل الدائري المميز

التوصية

- **Clotrimazole** أو **Terbinafine** كريم — نفس أسابيع التي ذكرناها
- مهم: ابتعد عن الملابس الضيقة والصناعية
- ملابس قطن فضفاضة
- جفف المنطقة كويس بعد الاستحمام
- لو السعفة واسعة جداً أو بتتكرر → طبيب لعلاج فموي (**Fluconazole** أو **Terbinafine** أقراص)

لا تعطي

- كريم الكورتيزون وحده ((**Hydrocortisone** — بيوسع الفطريات
- كريم **Betamethasone** وحده — نفس المشكلة
- استخدم دايماً مضاد فطريات أولاً أو مركّب

المريض: "أظافر قدامي اصفرت وبقت سميكة وهشة من شهور"

اسأل أولاً

- من امتى؟ كم ظفر متأثر؟
- فيه فطريات في القدم كمان؟
- جرب علاج؟

التشخيص

• **Onychomycosis** فطريات الأظافر — الأبطأ علاجاً

التوصية

- الكريمات الموضعية لا تكفي للأظافر
- (**Amorolfine** ليوسيل) طلاء الأظافر: علاج موضعي يحتاج 6-12 شهر
- للعلاج الجذري: أقراص فموية من الطبيب:
- Terbinafine 250 mg يومياً $\times 6$ أسابيع (أصابع يد) أو $\times 3$ شهور (أصابع رجل)
- Fluconazole 150 mg أسبوعياً $\times 6-12$ شهر
- يحتاج متابعة وظائف كبد
- أحوله للطبيب — الأقراص بتحتاج وصفة ومتابعة.

المریضة: "یا دکتورة عندي إفرازات بيضاء وحكة تعبتني"

اسأل أولاً

- الإفرازات بيضاء زى الجبنة الكريمة (يشير لفطريات)؟
- أو فيه رائحة كريهة وإفرازات خضراء/صفراء (يشير لعدوى بكتيرية — بكتيريا بور bacterial vaginosis أو STI)؟
- فيه حرقان في التبول؟
- عامل كيميائي جديد: صابون جديد، مناديل؟
- أخذت مضاد حيوي مؤخراً؟
- حامل؟

الإفرازات	الاحتمال
بيضاء كثيفة زى جبنة، حكة شديدة	فطريات ((Candida
رمادية مع رائحة سمك	Bacterial Vaginosis
خضراء رغوية	Trichomonas
صفراء مع ألم	عدوى بكتيرية / STI

التوصية

- **Clotrimazole pessary** (تحميلة مهبليّة): 100 mg × 6 أيام أو 500 mg مرة واحدة
- **Fluconazole 150 mg** فموي مرة واحدة — أسهل وبيحتاج وصفة في مصر
- **Nystatin** تحاميل — أمنة في الحمل
- نصائح:
- ملابس داخلية قطن
- تجنب الصابون داخل المنطقة — مبه عادية بس
- ما تستخدميش (douche غسيل مهبلي) — بيكسر الحماية الطبيعية

تحذير — أحوله فوراً

- الإفرازات مش بيضاء — احتمال عدوى تانية
- ألم في أسفل البطن (التهاب الحوض)
- فيه دم خارج الدورة
- حامل — إشراف طبي ضروري

الموضوع الثاني — الأكزيما والتهاب الجلد

المريض: "عندي منطقة في ركبتي حمراء وبتحكي كثير وبتتقشر"

اسأل أولاً

- من امتي؟ موجود من الصغر ولا جديد؟
- فيه حساسية معروفة؟ حساسية أنف، ربو؟ (مثلث الحساسية)
- بيزيد في الشتاء؟ (جفاف)
- ملاس لصابون جديد أو عطر أو منظف؟
- فيه مريض سكري؟

التشخيص

- احمرار + حكة + قشور في مناطق معينة = أكزيما تأتوبية
(Atopic Dermatitis — غالباً وراثية)
- لو بعد ملامسة مادة = التهاب جلد تماسي (Contact Dermatitis)

التوصية

- خط أول — ترطيب دائم:
- **Moisturizer** (مرطب طبي): Vaseline, Eucerin, Cetaphil — وفيرة على المنطقة المتأثرة
- الترطيب هو أهم علاج في الأكزيما — قبل الكريمات
- بعد الاستحمام فوراً (الجلد لسه رطب) — الأفضل توقيت
- خط ثاني — كريم ستيرويد موضعي:
- **Hydrocortisone 1%** (كريم هيدروكورتيزون): للوجه وأماكن الطيات — خفيف وآمن
- **Betamethasone** (بيتنوفيت): أقوى — للجسم — لفترة قصيرة
- لا تستخدم الستيرويد القوي على الوجه — ترقق الجلد
- مضاد الحكة:
- **Cetirizine** أو **Loratadine** — لتخفيف الحكة ليلاً
- **Diphenhydramine** (بيناديريل) ليلاً — يبخّر ويخفف الحكة
- نصائح الأكزيما:
- استحمام بماء فاتر — مش ساخن
- صابون خالي من العطور (Dove, Cetaphil)
- لبس قطن — ابعد عن الصوف والملابس الخشنة
- تجنب العرق الزيادة

تحذير — أحوله فوراً

- المنطقة بقت ملتهبة، حمراء جداً، فيها سيلان (عدوى جرثومية فوق الأكزيما)
- الأكزيما منتشرة كثير
- ما ردّتش على الكريم بعد أسبوعين

المريض: "عملت إيدي في مواد تنظيف وبعدها احمرت وبتحكني"

التوصية

- اغسل المنطقة بماء وصابون بسيط فوراً
- **Hydrocortisone 1%** كريم × مرتين يومياً × 5-7 أيام
- ابعد عن المادة المسببة
- ارتدي قفازات للأعمال المنزلية

الموضوع الثالث — حب الشباب

المريض: "يا دكتور عندي حبوب في وشي وبتزيد، جربت حاجات كتير ومش بتصح"

اسأل أولاً

- الحبوب نوعها إيه؟ رؤوس بيضاء، رؤوس سوداء، أو حبوب حمراء عميقة؟
- من امتي؟
- جرب إيه من قبل؟
- البنات: الحبوب بتزيد مع الدورة؟
- فيه أحد في العيلة عنده حب شباب شديد؟

الدرجة	الوصف	العلاج
خفيف	رؤوس بيضاء وسوداء قليلة	موضعي فقط
متوسط	بثور حمراء متعددة	موضعي + فموي أحياناً
شديد	حبوب عميقة كبيرة، ندوب	طبيب جلدية

التوصية

- خط أول — علاج موضعي:
- **Benzoyl Peroxide** بنزويل بيروكسيد (2.5-5%): كريم أو جل — يقضي على البكتيريا
- **Adapalene** ديفرين (0.1% جل: ريتينويد موضعي — يقلل انسداد المسام
- **Clindamycin gel 1%** مضاد حيوي موضعي — للحبوب الملتهبة
- نصائح الجلد:
- مرطب خفيف غير دهني (Non-comedogenic)
- واقى شمس خفيف
- لا تعصر الحبوب — بتخلي ندوب
- غسيل الوجه مرتين فقط يومياً — الأكثر بيزيد الجفاف والحبوب

تحذير — أحوّله فوراً

- حب شباب شديد أو حبوب كيسية ((cystic
- بدأت تعمل ندوب
- ما ردّش على العلاج الموضعي بعد 6-8 أسابيع
- (الطبيب قد يصرف Isotretinoin — روكيوتان — بس بمتابعة صارمة)

الموضوع الرابع — الحروق والجروح

المريض: "أمسكت حافة ساخنة وبقت إيدي تأجفني واحمرت"

اسأل أولاً

- أد إيه المنطقة المحترقة؟
- فيه فقاعات؟
- الجلد سليم ولا اتقشر؟
- فين في الجسم؟ (الوجه، الأيدي، المناطق الحساسة أخطر)

الدرجة	الوصف	العلاج
أولى	احمرار بس، مغيث فقاعات	علاج منزلي
ثانية	فقاعات، ألم شديد	تعقيم + ضماد — طبيب لو كبيرة
ثالثة	جلد متفحم، مغيث ألم	طوارئ فوراً

التوصية

- أولاً:
- ماء بارد جاري 20 دقيقة — الأهم — لا ثلج
- لا تضع: معجون أسنان، زبدة، زيت — بتحبس الحرارة وتتلوث
- بعدين:
- **Silver Sulfadiazine كريم (سيلفيديازين):** مضاد حيوي موضعي للحروق — وضع بعد تبريد
- **Aloe Vera جل:** طبيعي، مهدئ، مرطب — للحرق الأول
- **Sterile dressing ضماد معقم):** غطي الحرق برفق
- **Paracetamol أو Ibuprofen** للألم

تحذير — أحوّله فوراً

- الحرق في الوجه، الأيدي، الأعضاء التناسلية، المفاصل
- حرق أكثر من 10% من مساحة الجسم
- الجلد متفحم أو أبيض (الدرجة الثالثة)
- مريض سكري — أي حرق يحتاج متابعة

المريض: "انجرحت وعندي جرح بسيط في إيدي"

اسأل أولاً

- الجرح بيتنزف منه دم؟ كثير؟
- فيه أي جسم غريب جوا؟
- متى آخر تطعيم كزاز (تيتانوس)؟
- هل الجرح من حيوان (عضة أو خدش؟)

التوصية

- جرح بسيط:
- اغسله بماء جاري وصابون كثير (الأهم)
- (Povidone Iodine بيتادين سائل): للتطهير
- ضماد معقم
- (Antibiotic ointment نيوسبورين أو باسيتراسين) فوق الجرح
- تطعيم الكزاز:
- لو آخر جرعة أكثر من 5 سنين من جرح قدر — لازم جرعة تقوية
- لو مش عارف تاريخ تطعيمه — حوِّله للطبيب

تحذير — أحوِّله فوراً

- النزيف ما وقفش بعد ضغط 10-15 دقيقة
- الجرح عميق أو بيحتاج خياطة (فاغر وأطراف بعيدة عن بعض)
- عضه حيوان — لازم تقييم داء الكلب (رابيز)
- علامات التهاب بعد يومين: احمرار بيكبر، سخونة، سيلان

الموضوع الخامس — كريمات الكورتيزون



المريض: "يا دكتور عايز كريم كورتيزون قوي للحكة عندي"

اسأل أولاً

- فين الحكة؟ الوجه ولا الجسم؟
- من امتى بتستخدم الكورتيزون؟
- سبق استخدمت وبجيب نتيجة؟
- تشخيص إيه المشكلة؟
- ⚠ درجات قوة كريمات الكورتيزون:

القوة	الأمثلة	للاستخدام
خفيفة جداً	Hydrocortisone 0.5-1%	الوجه، أكزيما الأطفال
خفيفة	(Clobetasone إيموفات)	الوجه والطيات — استخدام أقصر
متوسطة	Betamethasone 0.025%	الجسم — بعيداً عن الوجه
قوية	Betamethasone 0.1%	الجسم — لفترة قصيرة فقط
شديدة القوة	(Clobetasol ديرموفيت)	الصدفية الشديدة — بوصفة طبية

قواعد الكورتيزون الموضعي التي لا تتجاوزها:

- الوجه: هيدروكورتيزون 1% فقط — لا تزيد عن أسبوعين متواصلين
- الأطفال: هيدروكورتيزون فقط للأطفال أقل من 2 سنة
- لا تستخدم الكورتيزون القوي أكثر من أسبوعين بدون إشراف طبي
- لا تغطي المنطقة بعد الكريم (ما عدا لو الطبيب قال كده)
- لا تستخدم على جروح أو جلد مكسور

أعراض جانبية من الاستخدام الطويل:

- ترقق الجلد
- ظهور خطوط زرقاء (striae)
- نمو شعر زيادة

- تأخر في التئام الجروح
- في الاستخدام الواسع جداً: تأثير على الجسم كله

ملخص سريع للفصل

الشكوى	أول سؤال	الخط الأول
فطريات قدم	رياضي؟ مكان مشترك؟	Clotrimazole أو Terbinafine
فطريات مهبلية	لون الإفرازات؟	Clotrimazole تحميلة
أكزيما	من الصغر ولا جديد؟	مرطب + Hydrocortisone
حب شباب	درجة الحبوب؟	Benzoyl Peroxide + Adapalene
حرق	فيه فقاعات؟	ماء بارد 20 دقيقة + سيلفيريم
جرح	بيتئزف؟ آخر كزاز؟	غسيل + بيتادين + ضماد

📌 المبدأ الذهبي في الجلد:

الاستخدام الزيادة للكورتيزون القوي على الوجه هو الأكثر خطورة.

الفطريات والكورتيزون لا يجتمعان بدون مضاد فطريات.

أي طفح مصحوب بحمى وانتشار = طبيب.

الترطيب هو أساس علاج الجلد الجاف والأكزيما.

القسم الثاني — الجلد والعناية الموضعية · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

الفيتامينات والمكملات

[صورة غلاف توضيحية لفصل: الفيتامينات والمكملات]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

تذكر: المكملات مش أدوية — لكنها مش بلا تأثير. الجرعة الزائدة منها بتضر، والنقص الحقيقي منها بيسبب أمراض. شغلتك تفرق بين اللي يحتاجه المريض فعلاً واللي بيتباع على الموضة.

الموضوع الأول — فيتامين D

المريض: "يا دكتور عايز فيتامين D، سمعت إنه مهم"

اسأل أولاً

- عمل تحليل 25-OH Vitamin D مؤخراً؟
- فيه أعراض نقص؟ (تعب، آلام عظام، تكرار مرض)
- بيتعرض للشمس كفاية؟
- عنده أمراض مزمنة: كلى، كبد، سوء امتصاص؟

المستوى	ng/mL	التصنيف
أقل من 10	نقص حاد	يحتاج جرعة علاجية عالية
10-20	نقص	جرعة تحميل
20-30	قصور	جرعة يومية متوسطة
30-100	طبيعي	صيانة فقط
فوق 100	زيادة — تحذير	وقف المكمل

التوصية

- نقص حاد (أقل من 10 ng/mL):
- **Devit-3** أو **000, Vigantol IU** أسبوعياً $\times 8-12$ أسبوع
- ثم صيانة 1000-2000 IU يومياً
- قصور (10-30 ng/mL):
- **2000 IU** يومياً $\times 3$ شهور ثم إعادة تحليل
- أو 50,000 IU مرة كل أسبوعين $\times 2$ شهر
- وقاية (مستوى طبيعي أو مجهول):
- **1000 IU** يومياً — آمن للجميع بدون تحليل
- الأشكال المتاحة في مصر:
- **Devit-3** أمبول **200,000 IU** للجرعة الواحدة العالية — IM
- **Vigantol drops** مريح للأطفال والكبار (1 mL = 20,000 IU)
- **D-Pearls 1000 IU / 5000 IU** كبسولات ناعمة — الأشهر
- متى تُعطى مع الكالسيوم؟
- لو في نقص كالسيوم مصاحب أو هشاشة عظام: D3 مع كالسيوم معاً
- لو الهدف مناعة أو عضلات فقط: D3 وحده كافٍ

تحذير — أحوله فوراً

- فيتامين D قابل للتراكم في الدهون ((Fat-soluble
- الأعراض: غثيان، كلى، تكلس الأنسجة
- لا تزيد عن 4000 IU يومياً طويل الأمد بدون إشراف طبي
- لو مريض يأخذ **50,000 IU** يومياً (مش أسبوعياً) — هذا خطأ خطير

الأم: "يا دكتور ابني شهر ونص، الدكتور قاله أدبه فيتامين D — كام قطرة؟"

التوصية

- فيتامين D للرضع:
- **IU 400** يومياً للرضع من أول أسبوع حتى سنة
- الرضاعة الطبيعية لا تكفي — حليب الأم محتواه من D3 منخفض جداً
- حليب الصناعي: يحتوي على D3 مُضاف — لو بيأخذ أكثر من لتر يومياً ربما يكفي
- منتجات الأطفال الشائعة في مصر:
- **IU 400 Baby D Drops** في قطرة واحدة — سهل الاستخدام
- **Vidrop** أو **D-Drops Infant** قطرات مائية
- طريقة الإعطاء: قطرة في بداية الرضعة أو على الثدي أو على الملعقة — لا تُضاف للحليب في الزجاج (قد تلتصق بالجدران)

الموضوع الثاني — الحديد

المریضة: "یا دكتور وجهی شاحب وتعبانة ومش قادرة أتحمّل المجهود، أصحابی قالولي أخذ حديد"

اسأل أولاً

- عملت تحليل CBC أو فيريتين مؤخراً؟
- الدورة الشهرية منتظمة ولا غزيرة؟
- بتأكل لحمة بانتظام؟
- حامل؟
- فيه ضيق تنفس مع التعب؟

التشخيص

- شحوب الوجه والملتحمة (داخل الجفن السفلي)
- تعب وإجهاد مع مجهود بسيط
- ضيق تنفس خفيف
- دوخة عند الوقوف
- هشاشة الأظافر وتقعرها ((Koilonychia
- رغبة غريبة في أكل التراب أو الثلج أو الطباشير ((Pica — شائع في مصر

التوصية

- الأشكال وفروقها:

الشكل	الامتصاص	الإمساك	ملاحظة
Ferrous Sulfate كبريتات	جيد	كثير	الأرخص
Ferrous Fumarate فيومارات	جيد	أقل	موجود في هيماتنيك
Ferrous Gluconate جلوكونات	أقل	أقل	أنسب لو فيه إمساك
(Ferric حديد ثلاثي)	يحتاج تحويل	أقل	أعلى، يؤخذ بدون أكل
Iron Bisglycinate	الأعلى	الأقل	الأفضل تحملاً

الجرعة:

• العلاج: 150-200 mg حديد عنصري يومياً — مقسمة

• الوقاية: 60 mg حديد عنصري يومياً

قواعد الأخذ المهمة:

- على معدة فاضية — امتصاص أفضل بـ 40%
- لو ما قدرش على معدة فاضية: مع الأكل مقبول
- مع عصير برتقال (فيتامين C): يضاعف الامتصاص
- بعيداً عن: شاي، قهوة، لبن، كالسيوم، مضادات الحموضة — كلها تقلل الامتصاص بشكل كبير
- لون البراز هيبقي أسود — طبيعي، مش دم

مدة العلاج:

• 3-6 شهور حتى بعد تطبيع الهيموجلوبين — عشان تملئ مخازن الفيريتين

تحذير — أحوله فوراً

- الهيموجلوبين أقل من 8 g/dL — قد يحتاج حقن حديد IV أو نقل دم
- ما ردش على الحديد الفموي بعد شهرين
- فقر دم عند رجل — السبب غير الدورة يحتاج بحث (نزيف خفي؟)

الأم: "يا دكتور الدكتور قال ابني 10 شهور محتاج حديد، أنهى أحسن؟"

التوصية

- جرعة الأطفال:
- علاج: 3-6 mg/kg/ يوم من الحديد العنصري
- وقاية: 1 mg/kg/ يوم
- منتجات شائعة للأطفال:
- (Hemofer drops Ferrous Chloride): قطرات — كل 44 mL mg حديد عنصري
- Ferro-drops / Iron drops: قطرات محسوبة
- Ferrogradumet syrup / Hemovit شراب: للأطفال الأكبر
- طريقة الإعطاء للرضع:
- بسرينجة صغيرة في الفم — مش في اللبن
- بعد الأكل لو عنده غثيان على معدة فاضية
- يغسل فمه بعدها أو يرضع فوراً — الحديد يلون الأسنان

الموضوع الثالث — فيتامين B12 وحمض الفوليك

المريض: "يا دكتور بياخذ ميتفورمين من 4 سنين وبجيلة تنميل في إيديه وقدامه"

التوصية

- الميتفورمين يقلل امتصاص B12 في الأمعاء عبر الوقت — يحدث في 30% من المرضى
- التنميل هنا قد يكون نيوروباثي من نقص B12 وليس دائماً من السكري
- خطوات العمل:
- اقترح تحليل (B12 طبيعي: فوق 300 pg/mL — لو أقل: علاج)
- **Methylcobalamin 1000 mcg** يومياً فموي — الشكل الأفضل امتصاصاً
- أو **Neurobion** أقراص ((B1 + B6 + B12)
- أو حقن **Methylcobalamin IM** لو النقص شديد
- الفرق بين **Methylcobalamin** و **Cyanocobalamin**:

Methylcobalamin	Cyanocobalamin	
النشط — جاهز للاستخدام	الأرخص والأشهر	الشكل
جاهز مباشرة	يحتاج تحويل في الجسم	التحويل
أفضل بكثير	أقل	للأعصاب
نيوروباثي وتنميل	وقاية عامة	الاختبار

المريضة: "يا دكتور أنا ناوية أتجوز وأنجب قريباً، محتاجة آخذ حاجة؟"

التوصية

- حمض الفوليك ((Folic Acid — الأهم قبل الحمل:
- **400 mcg** يومياً لكل امرأة في سن الإنجاب (حتى لو مش ناوية حمل عن قصد)
- يبدأ قبل الحمل بـ **3 شهور** على الأقل وليس بعد معرفة الحمل
- يمتد حتى نهاية الثلث الأول (12 أسبوع)
- الهدف: الوقاية من عيوب الأنبوب العصبي (Spina Bifida, Anencephaly)
- لو عندها تاريخ طفل سابق بعيب أنبوب عصبي:
- **4 mg** يومياً (10 مرات الجرعة العادية) — من الطبيب
- المكملات الشاملة للحمل:
- معظم "مكملات الحمل" المتاحة (Elevit, Pregnacare, Femibion) تحتوي على:
- حمض الفوليك 400-800 mcg
- حديد 30-60 mg
- فيتامين D
- يود
- أوميغا 3 (في بعضها)
- هي بديل مناسب للمكملات المنفردة

الموضوع الرابع — الكالسيوم ومغنيسيوم

المریضة: "یا دكتور عندي 52 سنة وبدأت ألاحظ ألم في عظامي، الدكتور قال أخذ كالسيوم"

التوصية

- الاحتياج اليومي من الكالسيوم:
- بالغون: 1000 mg يومياً
- نساء فوق 50 سنة ورجال فوق 70: 1200 mg يومياً
- حوامل ومرضعات: 1000-1300 mg
- مصادر الكالسيوم من الأكل (الأفضل):

الأكل	الكالسيوم في الحصة
لبن كامل (كوب 250 mL)	300 mg
جبنة قريش (100 g)	130 mg
بيضاء جبنة (30 g)	200 mg
سمك سردين مع العظم	350 mg
سبانخ مطبوخ (كوب)	250 mg
سمسم (ملعقتين)	180 mg

أقراص الكالسيوم:

- لا تأخذ أكثر من 500 mg في المرة الواحدة — الجسم ما يمتص أكثر
- لو الجرعة 1000 mg: قسّمها — 500 في الصباح + 500 في المساء

أنواع الكالسيوم:

النوع	% عنصري	يؤخذ	ملاحظة
Calcium Carbonate	40%	مع الأكل	الأرخص والأشهر — يحتاج حمض معدي
Calcium Citrate	21%	في أي وقت	أفضل لو عنده حموضة أو بياخذ PPI
Calcium Gluconate	9%	في أي وقت	جرعة أعلى للوصول لنفس الكمية

الكالسيوم + D3 معاً — دائماً:

• D3 ضروري لامتصاص الكالسيوم — بدون 90% من الكالسيوم يُهدر

منتجات شائعة في مصر:

• **Calcium Sandoz Forte** 500 mg carbonate + D3 — فوار

• **Caltrate** 600 mg carbonate + D3

• **Oscal** متاح بأشكال متعددة

المريض: "يا دكتور بيجيلي تشنج في عضلات ساقي كل ليلة وبصحيني من النوم"

اسأل أولاً

- من امتي؟
- يشرب فيه كافية يومياً؟
- مريض سكري أو كلي؟
- بياخذ أى أدوية؟ (الستاتينات يتسبب تشنج عضلي)
- يمارس رياضة؟

التشخيص

- نقص الماء والمعادن (الأكثر شيوعاً)
- نقص المغنيسيوم
- نقص البوتاسيوم
- تعب العضلات من الرياضة
- ستاتينات (أتورفاستاتين، روسوفاستاتين)
- بداية نيوروباثي

التوصية

- المغنيسيوم — الأهم للتشنج:
- **Magnesium Citrate / Glycinate / Malate:** 200-400 mg يومياً — قبل النوم
- **Magnesium Oxide:** أرخص لكن أقل امتصاصاً وأكثر إسهالاً
- ابدأ بجرعة صغيرة وازد تدريجياً لتجنب الإسهال
- البوتاسيوم:
- لا تصرف أقراص بوتاسيوم بدون إشراف طبي — الزيادة تؤثر على القلب
- زوّده في الأكل: موز، برتقال، بطاطس، طماطم
- الماء:
- 8-10 أكواب يومياً — أبسط علاج وأكثره إهمالاً
- تمارين قبل النوم:
- تمّد عضلة الساق قبل النوم $5 \times$ دقائق — مثبت علمياً للتشنج الليلي

الموضوع الخامس — أوميغا 3 والزنك والبروبيوتيك

المريض: "يا دكتور سمعت إن أوميغا 3 مفيد للقلب، أخذه؟"

التوصية

- الفوائد المدعومة علمياً:
- تخفيض الدهون الثلاثية ((TG: الأكثر ثباتاً — بجرعات 2-4 غرام يومياً
- تقليل الالتهاب المزمن
- صحة المفاصل (تخفيف آلام الروماتويد قليلاً)
- صحة العين (الماقولا)
- دعم الدماغ والذاكرة
- الجرعات:

الهدف	الجرعة المطلوبة
وقاية عامة	1 غرام EPA+DHA يومياً
تخفيض TG	2-4 غرام EPA+DHA يومياً
ضغط وقلب	1-2 غرام يومياً

ملاحظة مهمة على الملمصقات:

• **Omega-3 1000 mg ≠ Fish Oil 1000 mg**

• زيت السمك 1000 mg يحتوي عادةً على 300-600 mg EPA+DHA فعلاً

• ابحث عن المحتوى الفعلي من EPA+DHA في الملمصق

أنواع:

• **Fish oil** (زيت سمك): الأرخص والأشهر

• **Krill oil**: امتصاص أفضل — أعلى

• **Algae oil** للنباتيين — مصدر نباتي لـ DHA

تحذيرات:

• فوق 3 غرام يومياً قد يقلل تجلط الدم — تحذر مع وارفارين

• يطلع رائحة سمك — يأخذه مع الأكل أو يعمل freeze للكبسولات

الحالة 10 — أم تطلب زنك لطفلها بعد إسهال

الأم: "يا دكتور ابني 2 سنة اتعالج من إسهال، الدكتور قاله زنك بعدها"

التوصية

- لماذا الزنك بعد الإسهال؟
- WHO و UNICEF توصي بـ Zinc بعد الإسهال الحاد عند الأطفال
- يقصر مدة الإسهال
- يقلل احتمال تكراره خلال 3 شهور
- يعوّض ما فقده الطفل
- الجرعة:
- أقل من 6 شهور: 10 mg يومياً $\times 10-14$ يوم
- 6 شهور - 5 سنين: 20 mg يومياً $\times 10-14$ يوم
- منتجات:
- Zinc sulfate شراب أو أقراص قابلة للذوبان
- Zinc drops, Zinkid, Orazinc متاحة في مصر

المريض: "يا دكتور بياخذ مضاد حيوي وصاحبه قاله يأخذ بروبيوتيك معاه، إيه الموضوع؟"

التوصية

- ما هو البروبيوتيك؟
- بكتيريا وخمائر حية نافعة — تعزز البكتيريا الطبيعية في الأمعاء
- المضادات الحيوية بتقتضي على الجيد والوحش في الأمعاء → إسهال، انتفاخ، فطريات
- متى يُستخدم البروبيوتيك؟
- مع المضادات الحيوية: يقلل إسهال المضاد بنسبة 50%
- بعد الإسهال الحاد: يُعيد الفلورا
- القولون العصبي: يقلل الانتفاخ والغازات
- فطريات المهبل المتكررة: مع (أو بعد) العلاج المضاد للفطريات
- أنواع البروبيوتيك الشائعة:

البكتيريا	الاستخدام الرئيسي
Lactobacillus rhamnosus GG	الأفضل للإسهال والمضادات
Saccharomyces boulardii	إسهال السفر، C. difficile
Lactobacillus acidophilus	عام — صحة الأمعاء
Bifidobacterium	القولون العصبي والانتفاخ

منتجات في مصر:

• Lacteol Fort (S. boulardii + L. acidophilus): الأشهر

• Ultraflora / Probiox: كبسولات

• Laktofil (Lactobacillus): للأطفال

قواعد الأخذ:

- يأخذ البروبيوتيك بعد المضاد الحيوي بساعتين — مش معاه في نفس الوقت
- يُحفظ في الثلاجة (بعض الأنواع)

الموضوع السادس — مكملات خاصة بالمرأة

المریضة: "یا دكتور أنا حامل 6 أسابيع، أنهي مكملات لازم أخذها؟"

التوصية

- الأساسيات:

السبب	الجرعة	المكمل
وقاية عيوب الأنبوب العصبي	mcg 400-800	حمض الفوليك
يبدأ الثلث الثاني	mg 30-60	حديد
نمو العظام، مناعة	IU 1000-2000	فيتامين D3
نمو الدماغ والغدة الدرقية	mcg 150-220	يود
عظام الأم والجنين	mg (1000 من الأكل + مكمل)	كالسيوم

الاختيارات المفيدة:

• أوميغا 3 (DHA): 200-300 mg — تطور دماغ الجنين

• المغنيسيوم: يقلل تقلصات الساق والصداع

مكملات الحمل الجاهزة (كل ما سبق في قرص واحد):

• **Elevit**: مشهور وشامل

• **Pregnacare**: يحتوي أوميغا 3 في نسخته المتقدمة

• **Femibion**: يحتوي (Methylfolate أفضل من حمض الفوليك العادي لبعض النساء)

ملاحظة:

• لو بتأخذ مكمل شامل: تأكدي إنه يحتوي يود وحمض فوليك — بعض المكملات ينقصها

• الغثيان من الحمل؟ اشربيه مع الأكل أو خدي نسخة ليلاً

المريضة: "يا دكتور عندي 50 سنة وبدأ ال Menopause، بييجيلي هبات حرارة وتعب، في حاجة؟"

التوصية

- مكملات مفيدة لمرحلة ما بعد سن اليأس:
- فيتامين + D3 كالسيوم: ضروريان لمنع هشاشة العظام
- Magnesium: يقلل اضطرابات النوم وهبات الحرارة
- (Black Cohosh) Actaea racemosa: عشبة لهبات الحرارة — أدلة متوسطة — آمن بجرعات معتدلة
- Phytoestrogens (إيزوفلافون الصويا): مركبات نباتية تشبه الإستروجين — تقلل هبات الحرارة في بعض النساء
- Omega-3: تحسين المزاج وصحة القلب
- B Complex: للطاقة واضطرابات المزاج
- لو الأعراض شديدة جداً:
- العلاج الهرموني التعويضي ((HRT هو الأقوى فعالية — من طبيب نساء فقط

ملخص سريع للفصل

الشكوى / الطلب	أول سؤال	التوصية
فيتامين D	فيه تحليل؟	بدون تحليل: IU 1000 يومياً
تعب وشحوب في امرأة	الدورة غزيرة؟	CBC + Ferritin تحليل
تنميل في مريض ميتفورمين	من امتى على الميتفورمين؟	Methylcobalamin 1000 mcg
تشنج عضلات ليلي	يشرب فيه كافي؟	+ Magnesium مياه + تمدد
إسهال مع مضاد حيوي	من امتى بدأ؟	Saccharomyces boulardii بعد المضاد بساعتين
حمل مبكر	بياخد حمض فوليك؟	400 + mcg مكمل شامل
هشاشة عظام	بياخد D3 مع الكالسيوم؟	D3 + Calcium Citrate / Carbonate

📌 المبدأ الذهبي في المكملات:

المكملات لا تعوّض نظام غذائي سيئ — بس تسد الفجوات الحقيقية.

فيتامين D وحمض الفوليك والحديد = الثلاثة الأكثر نقصاً في مصر.

الجرعة الزائدة من المكملات الدهنية (D, A, E, K) تتراكم وتضر.

البروبيوتيك بعد المضاد بساعتين — مش معه.

القسم الثاني — الفيتامينات والمكملات · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

صحة المرأة والأطفال

[صورة غلاف توضيحية لفصل: صحة المرأة والأطفال]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

تذكر: المرأة والطفل مش "بالغ صغير" — لهم فسيولوجيا مختلفة وأدوية مختلفة وحسابات مختلفة. الخطأ هنا أثره ضعيف.

الموضوع الأول — تنظيم الحمل

المريضة: "يا دكتور عايزة حبوب منع الحمل، مش عارفة أنهى أحسن"

اسأل أولاً

- عمرها كام؟
- بتدخن؟ (المدخنة فوق 35 سنة: خطر جلطة مع الحبوب المركبة)
- بترضع؟ (الحبوب المركبة ممنوعة في الـ 6 شهور الأولى من الرضاعة)
- عندها ضغط مرتفع، سكري، تخثر دم سابق؟
- بيحبلها صدام نصفى مع أورة (ومضات بصرية)؟ — موانع مطلقة
- عندها مشكلة في الكبد؟
- بياخد أى أدوية بتقلل فعالية الحبوب؟ (Rifampicin، بعض مضادات المصراع)

الحالة	الأنسب
صحيحة، غير مدخنة، غير مرضعة	حبوب مركبة ((COC
مرضعة	بروجستين فقط ((Mini-pill أو سيرال
مدخنة فوق 35 سنة	بروجستين فقط أو IUD
صدام نصفى مع أورة	لا حبوب مركبة — بروجستين أو IUD
ضغط مرتفع غير منضبط	لا حبوب مركبة — IUD أو بروجستين
تريد راحة بال طويلة المدى	سيرال ((IUD — من طبيب

الاسم	المحتوى	ملاحظة
Microgynon	EE 30 mcg + Levonorgestrel	الأرخص والأشهر
Yasmin	EE 30 mcg + Drospirenone	أقل احتباس ماء وانتفاخ
Yaz	EE 20 mcg + Drospirenone	جرعة استروجين أقل
Mercilon	EE 20 mcg + Desogestrel	جرعة استروجين منخفضة
Marvelon	EE 30 mcg + Desogestrel	وسط
Diane-35	EE 35 mcg + Cyproterone	للبنات اللاتي عندما حب شباب هرمونى أو شعر زيادة

كيف تبدأ الحبوب؟

- يوم 1 من الدورة: حماية فورية من اليوم الأول
- يوم 2-5 من الدورة: حماية بعد 7 أيام — تحتاج وسيلة إضافية أسبوع
- أي وقت ((Quick Start): تبدأ فوراً — تحتاج وسيلة إضافية 7 أيام

ما تقويله لكل سيدة بتبدأ الحبوب:

1. خذيها في نفس الوقت كل يوم — ضبطي منه
2. لو نسيت قرص: لو أقل من 12 ساعة متأخر — خديه فوراً / لو أكثر: اتبعي إرشادات العبوة
3. الشريك يحتاج وسيلة إضافية أول 7 أيام
4. بعض الأدوية بتقلل فعاليتها — قولي لو بدأت دواء جديد
5. لو جاتك أعراض غريبة: ألم في الساق، ضيق تنفس، صاع شديد مفاجئ — اتصلي بالطبيب فوراً (جلطة محتملة — نادرة لكن ممكنة)

المريضة: "يا دكتور نسيت أخذ الحبة امبارح، أعمل إيه؟"

التوصية

- حبوب مركبة ((COC):

التأخير	الإجراء
أقل من 24 ساعة	خذه فوراً — مغيش مشكلة
24-48 ساعة (قرص واحد ناسيه)	خذه فوراً + القرص الجاي في وقته — وسيلة إضافية 7 أيام
أكثر من 48 ساعة أو قرصين ناسياهم	ابدأى كورس جديد + وسيلة إضافية 7 أيام

بروجستين فقط ((Mini-pill):

- الهامش 3 ساعات فقط — لو تأخرت أكثر: وسيلة إضافية 48 ساعة

المريضة: "يا دكتور محتاجة حاجة طارئة بعد البارح"

التوصية

• الأنواع المتاحة في مصر:

الدواء	المادة الفعالة	الجرعة	الفعالية
Postinor-2	Levonorgestrel 0.75 mg	قرصان معاً أو واحد كل 12 ساعة	95% خلال 24 ساعة
Escapelle / NorLevo	Levonorgestrel 1.5 mg	قرص واحد	95% خلال 24 ساعة
EllaOne	Ulipristal Acetate 30 mg	قرص واحد	98% حتى 120 ساعة

القاعدة الأهم — كل ساعة بتفرق:

• أول 24 ساعة: فعالية 95%

• 24-48 ساعة: 85%

• 48-72 ساعة: 58%

• بعد 72 ساعة: تناقص كبير

ما تقولييه للمريضة:

• هي مانعة للحمل وليست مجهزة — تمنع الإخصاب أو انغراس البويضة

• الدورة ممكن تتأخر أو تجي بدرى — طبيعي

• لو الدورة تأخرت أكثر من أسبوع: اعمل اختبار حمل

• مش بديل لو وسيلة منع حمل منتظمة

المريضة: "يا دكتور ممكن أعمل اختبار حمل هنا؟ وإيه الصح مشان يطلع دقيق؟"

التوصية

- طريقة الاختبار الصحيحة:
- أول بول الصباح — تركيز hCG أعلى
- لو مش صبح: ما تشربيش ميه 2-3 ساعات قبل الاختبار
- بول منتصف التيار — ابدأي تبولي وبعدين حطّي الاختبار
- متى يكون الاختبار دقيق؟
- من أول يوم تأخر الدورة — معظم الاختبارات الحديثة
- بعض الاختبارات الحساسة: 4-5 أيام قبل الدورة
- لو سلمي ومفيش دورة: كرري بعد 3-5 أيام — HCG بيضاعف كل 48 ساعة
- قراءة النتيجة:
- خطان (حتى خفيفين جداً): حمل — الخط الخفيف يعتبر إيجابي
- خط واحد: سلمي
- لا خطوط: الاختبار فاسد — كرري بعبوة جديدة

الموضوع الثاني — الحمل والأدوية الآمنة

المريضة: "يا دكتور أنا حامل 10 أسابيع، الغثيان بيقتلني من الصبح لحد الظهر"

التوصية

- غير دوائي أولاً — الأكثر أماناً:
- **الزنجبيل:** شاي زنجبيل أو كبسولات 250 mg $\times$ 4 يومياً — مثبت علمياً وآمن
- وجبات صغيرة متكررة كل 2-3 ساعات — معدة فاضية بتزود الغثيان
- بسكويت مالح قبل الأكل
- تجنب الروائح المزعجة
- رقائق الزنجبيل
- مكمل آمن:
- **فيتامين (B6) (Pyridoxine) 10-25 mg $\times$ 3 يومياً:** مثبت علمياً للغثيان في الحمل
- **(Diclegis) B6 + Doxylamine:** المعتمد في الولايات المتحدة للغثيان الشديد
- أدوية من الطبيب (لو الغثيان شديد):
- **(Maxolon) Metoclopramide:** الأكثر استخداماً — فئة B
- **(Zofran) Ondansetron:** للحالات الشديدة — يتجنب في الثلث الأول
- **Promethazine:** يُستخدم لكن بحذر

تحذير — أحوله فوراً

- قيء 5+ مرات يومياً + فقدان وزن + جفاف
- طوارئ — تحتاج IV fluids في المستشفى

المريضة: "أنا حامل 6 شهور وبيجيلي حموضة وحرقان في صدري"

التوصية

- الحموضة شائعة جداً في الثلث الثاني والثالث — الرحم المتوسع يضغط على المعدة
- الآمن في الحمل:
- (Tums), Rennie Calcium Carbonate: آمن تماماً — يعادل الحمض فوراً
- Gaviscon: آمن — يكون طبقة واقية
- (Aluminium): آمن Maalox Magnesium Trisilicate بدون
- Omeprazole: آمن في الحمل — فئة C — لو الحالة محتاجة
- ممنوع في الحمل من مضادات الحموضة:
- Sodium Bicarbonate بكميات كبيرة — يسبب احتباس سوديوم
- نصائح:
- وجبات صغيرة متكررة
- لا تنامي فور الأكل — انتظري ساعتين
- ارفعي وسادتك أو رأس السرير
- تجنبي الأكل الحار والدهني

المريضة: "أنا حامل 5 شهور وبعد ما بدأت الحديد بقيت زعلانة من الإمساك"

التوصية

- أدوية آمنة للإمساك في الحمل:
- (Lactulose) **Duphalac**: الأول والأمن — غير ممتص ومش بيضر الجنين
- (Psyllium) **Fybogel**: ألياف — آمن تماماً
- (Macrogol) **Movicol**: لا يُمتص — آمن
- ممنوع في الحمل:
- **Senna** و **Bisacodyl** بكميات كبيرة: محرصة للأمعاء — تجنب في الثلث الأول والثالث
- **Castor oil** يحرض تقلصات رحمية — ممنوع
- غير دوائي:
- شرب ماء كثير — 8-10 أكواب
- خضروات وفاكهة وخبز أسمر
- مشي 20-30 دقيقة يومياً

الموضوع الثالث — الرضاعة والأدوية

المریضة: "یا دکتورة بعد الولادة بیأجعی ظهري وبرضع، آخذ إیه؟"

الدواء	الأمان	ملاحظة
Paracetamol	✓ آمن تماماً	الخيار الأول
Ibuprofen	✓ آمن (بكميات قليلة في الحليب)	مقبول
Diclofenac	✓ آمن	مقبول
Naproxen	⚠ تجنب	نصف عمره طويل — يتراكم
Aspirin 500 mg	✗ ممنوع	خطر s'Reye في الرضيع
Aspirin 100 mg	✓ آمن	الجرعة المنخفضة
Codeine	✗ ممنوع	وفيات رضع موثقة — محظور
Tramadol	⚠ تجنب	ينتقل للحليب

نصيحة:

- خذي الدواء مباشرة بعد الرضعة — الدواء يكون في أدنى مستوياته في الحليب عند الرضعة التالية

المریضة: "أنا مرضعة وعندی التهاب فی الحلق، الدكتور كتبلی أزیثرومیسین، ینفع؟"

المضاد الحيوي	الرضاعة
Amoxicillin	✓ آمن
Augmentin	✓ آمن
Azithromycin	✓ مقبول (كميات قليلة في الحليب)
Clarithromycin	⚠ تجنب إذا أمكن
Ciprofloxacin	⚠ تجنب — Amoxicillin بديل لمعظم الحالات
Doxycycline	✗ ممنوع — يتراكم في عظام الرضيع
Metronidazole	⚠ تجنب كمية كبيرة — لو ضروري: جرعة واحدة ثم أوقفی الرضاعة 24 ساعة

الموضوع الرابع — الأطفال

الأم: "يا دكتور ابني 4 سنين ووزنه 16 كيلو، كام مليلتر أدبه من كل دواء؟"

التوصية

- باراسيتامول ((Paracetamol — الجرعة: 15 mg/kg
- وزن 16 kg $\rightarrow 16 \times 15 = 240$ mg

الشكل	التركيز	الكمية
Kalpol شراب	120 mL 5 mg	10 mL
Kalpol Forte	250 mL 5 mg	4.8 mL (تقريباً 5 mL)
Panadol شراب	120 mL 5 mg	10 mL
لبوس 125 mg	—	2 لبوسة

إيبوبروفين ((Ibuprofen — الجرعة: 10 mg/kg

- وزن 16 kg $\rightarrow 16 \times 10 = 160$ mg

الشكل	التركيز	الكمية
Brufen شراب	100 mL 5 mg	8 mL
Nurofen for Children	100 mL 5 mg	8 mL

أموكسيسيلين ((Amoxicillin — الجرعة: 25-40 mg/kg/day $\div 3$:

- 40 mg/kg $\times 16 = 640$ mg/day $\div 3 = 213 \sim$ mg كل 8 ساعات

الشكل	التركيز	الكمية
Amoxil معلق	125 mL 5 mg	8.5 mL
Amoxil معلق	250 mL 5 mg	4.25 mL

قاعدة سريعة لتقدير الجرعة بالعمر (لو ما فيش ميزان):

العمر	الوزن التقريبي	جرعة باراسيتامول
3-6 شهور	kg 5-7	120mg/5mL)mL (2.5-3.5
6-12 شهر	kg 7-10	mL 3.5-5
1-2 سنة	kg 10-12	mL 5-6
2-4 سنين	kg 12-16	mL 7-8
4-6 سنين	kg 16-20	mL 10-12

الأم: "يا دكتور ابني 8 شهور وعنده إسهال من امبارح، بيرضع طبيعي"

اسأل أولاً

- كام مرة راح الحمام؟
- لون البراز؟ فيه دم أو مخاط؟
- فيه قيء معاه؟
- فيه حرارة؟
- بيرضع ويبلع كويس؟
- علامات الجفاف؟ (عيون غائرة، ما فيش دموع، فم جاف، ما بيبولش)

التوصية

- الإمالة — الأهم:
- استمر في الرضاعة الطبيعية — لا توقفها أبداً في الإسهال
- أضع (ORS محلول إمالة فموي) بين الرضعات
- لكل برازة سائلة: أعطه mL ORS 100-50
- لكل قيء: mL/kg 10
- مستحضرات ORS للأطفال:
- **Pedialyte**: **Hydrite** مخصصة للأطفال — الأفضل
- **ORS WHO**: المعيار الدولي (شائل، ماء، سكر، ملح، بوتاسيوم)
- لو ما فيش: 1 لتر ماء + ملعقة ملح + 6 ملاعق سكر
- أدوية:
- (**Diosmectite**) **Smecta**: 1 كيس مرتين يومياً — يمس السموم ويحمي الغشاء المخاطي — آمن للرضع
- **Zinc 10-20 mg** يومياً × 14 يوم: موصى به من WHO بعد الإسهال الحاد
- (**Lactobacillus GG**) **Probiotics**: يقصر مدة الإسهال

لا تعطي

- (Imodium)Loperamide — ممنوع أقل من 2 سنة — وفيات موثقة
- مضاد حيوي بدون تشخيص

تحذير — أحوله فوراً

- الرضيع لا يبول أكثر من 8 ساعات
- يبكي بدون دموع
- عيانه غائرتان
- فم وشفاه جافة جداً
- خامل ومش مستجيب
- دم في البراز

الأم: "يا دكتور ابني شهرين وبيعيط كثير من المساء لحد منتصف الليل من غير سبب واضح"

اسأل أولاً

- الطفل يبأكل كويس وبيزيد في الوزن؟ (الكوليك لا يؤثر على النمو)
- البكاء محدد من المساء إلى الليل؟ (علامة الكوليك الكلاسيكية)
- بيرفع رجليه على بطنه وهو بيعيط؟ (مغص)
- الأم بترضع طبيعي؟ بتأكل كابينة أو ألبان بكميات كبيرة؟

التشخيص

- بكاء أكثر من 3 ساعات يومياً، أكثر من 3 أيام في الأسبوع، في رضيع صحي
- يبدأ الأسبوع الثاني، أشد في الأسبوع السادس، يختفي في 3-4 شهور

التوصية

- أثبتت الدراسات فعاليتها نسبياً:
- (**InfacolSimethicone**), (**Colic Calm**): يكسر الفقاعات — آمن، نتائج متباينة
- **Lactase drops**: لو الكوليك من عدم تحمل اللاكتوز (أقل شيوعاً)
- **Lactobacillus reuteri** — **Probiotics**: أكثر الأبحاث إيجابية لتقليل الكوليك — آمن
- تقنيات غير دوائية:
- تحريك خفيف أو اهتزاز
- صوت أبيض ((white noise
- تدليك بطن خفيف بزيت دافئ باتجاه عقارب الساعة
- وضع الطفل على بطنه على ذراعك وضغط خفيف على بطنه
- للأم المرضعة:
- قتل الكافيين
- جربي إزالة منتجات الألبان من غذائك أسبوعين وشوفي الفرق
- قتل الكرنب والبصل والكابينة

تحذير — أحوله فوراً

- بكاء مستمر لا يتوقف مع أي شيء
- حرارة أو قيء مع البكاء
- الطفل لا يأكل أو يزيد وزنه
- دم في البراز

الأم: "ابني 7 شهور بيعيط وعنده حرارة خفيفة، قالولي من الثنيان، أعمل إيه؟"

التوصية

- التسنين — الحقائق:
- التسنين قد يسبب: لعاب زيادة، حكة في اللثة، انزعاج خفيف، حرارة خفيفة (37.5 أقصى)
- لا يسبب: إسهال، قيء، حرارة فوق 38 — لو فيه أعراض شديدة → سبب آخر العلاج:
- حلقة التسنين الباردة ((Teething ring): تُبرد في الثلاجة (مش الفريزر) وتُعطى للطفل بعضها
- (Bonjela Teething gel, Calgel): يحتوي Lidocaine موضعي + Antiseptic — يُفرك على اللثة برفق
- تحذير Benzocaine في بعض جيلات التسنين الأمريكية:
- FDA حذرت من benzocaine للأطفال — ممكن يسبب methemoglobinemia
- اختر المنتجات المحتوية على Lidocaine فقط
- للحرارة الخفيفة:
- Paracetamol بجرعة مناسبة للوزن

الأم: "يا دكتور ابني 3 سنين عنده كحة، أنهى شراب أدبه؟"

اسأل أولاً

- الكحة جافة ولا معها بلغم؟
- فيه حرارة؟
- مسبوقه بزكام؟

التوصية

- للأطفال أقل من 6 سنين:
- معظم أدوية الكحة OTC غير موصى بها لأقل من 6 سنين — FDA وEMA حذرتا
- الأفضل:
- غسل نص ملعقة (فوق سنة فقط) — مثبت علمياً
- شاي دافئ بعسل وليمون
- بخار دافئ
- Saline nasal drops للاحتقان
- شرب سوائل كثير
- لو الكحة مزعجة جداً (فوق 4 سنين فقط):
- (Guaifenesin مذيّب بلغم): يرقق البلغم — أنسب من مثبطات الكحة
- Stodal, Linhale Honey-based syrups — بدائل طبيعية آمنة
- ممنوع للأطفال:
- Codeine ممنوع تحت 12 سنة
- Dextromethorphan: تجنب أقل من 4 سنين
- مضادات الهيستامين كمهدئ للكحة ((Diphenhydramine تحت 6 سنين

ملخص سريع للفصل

الشكوى	أول سؤال	الإجراء
حبوب منع حمل لأول مرة	بترضع؟ بتدخن؟ عمرها؟	COC لو مغيث موانع
نسبت قرص	من امتى؟	أقل من 24 ساعة: خذيه فوراً
حبوب طوارئ	من امتى؟	فوراً — كل ساعة بتفرق
غثيان حمل	أسابيع كام؟	+ B6 زنجبيل أولاً
جرعة طفل	وزنه كام؟	احسب 15 mg/kg باراسيتامول
إسهال رضيع	بيبول؟ عيانه كيف؟	+ Smecta + ORS رضاعة مستمرة
كوليك	البكاء من المساء؟	+ Simethicone تقنيات تهدئة
كحة طفل أقل من 4 سنين	عمره كام؟	عسل + بخار + سوائل

2 المبدأ الذهبي في صحة المرأة والأطفال:

الحامل والمرضع: الباراسيتامول دائماً الأول.

الرضيع المصاب بإسهال: الخطر من الجفاف مش الإسهال نفسه.

جرعة الطفل دائماً بالوزن — مش بالعمر.

حبوب الطوارئ: كل ساعة بتقلل الفعالية — ابدأ فوراً.

القسم الثاني — صحة المرأة والأطفال · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

الإسعافات الأولية والطوارئ

[صورة غلاف توضيحية لفصل: الإسعافات الأولية والطوارئ]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

هذا الفصل الأهم عملياً: معظم الكتاب عن صرف الأدوية بشكل صحيح — لكن هنا نتعلم كيف تنقذ حياة. الصيدلية هي أول نقطة تماس للكثير من حالات الطوارئ في مصر.

المبدأ الأساسي — ترتيب الأولويات

الأمان أولاً ← استدعاء المساعدة ← تقييم الحالة ← تدخل بسيط ← انتظار
الإسعاف

أرقام الطوارئ في مصر:

الخدمة	الرقم
إسعاف	123
شرطة	122
مركز مكافحة السموم	08008880700 (مجاني)
حريق	180
دفاع مدني	125

الموضوع الأول — توقف القلب والإنعاش ((CPR

الموقف: شخص يسقط فجأة في الصيدلية أو على بابها

1. تأكد من الأمان

↓

2. تحقق من الاستجابة - ناديه واهز كتفه

↓

3. "اطلب المساعدة - اصرخ" في حد يساعدني

↓

4. اتصل بالإسعاف 123 فوراً

↓

5. افحص التنفس (10 ثواني فقط)

↓

6. لو مفيش تنفس طبيعي CPR ابدأ

كيف تعمل CPR:

الضغط على القص ((Chest Compressions:

- المريض على ظهره على سطح صلب
- ضع راحة إيدك على منتصف القص (بين الحلمتين)
- ضع الإيد الثانية فوقها — أصابع متشابكة
- ذراعيك مستقيمين — كتفك فوق إيديك
- اضغط بعمق 5-6 سم — بقوة حقيقية
- 100-120 ضغطة في الدقيقة (بمعدل أغنية "Alive 'Stayin")
- اسمح للصدر يرجع كاملاً بين كل ضغطة

نفس الإنقاذ (لو متدرب):

- 30 ضغطة ثم نفسين
- كل نفس: أغلق أنفه، انفخ ببطء حتى ترى الصدر يرتفع
- لو مش متدرب أو مش مرتاح: اعمل ضغطات فقط بدون أنفاس — أحسن من لا شيء

للأطفال:

- رضيع (أقل من سنة): أصبعان على الصدر — عمق 4 سم

• طفل (1-8 سنين): راحة يد واحدة — عمق 5 سم

لا توقف CPR حتى:

- يصل الإسعاف
- يبدأ المريض في التنفس والتحرك
- تنهك تماماً — في الحالة دي: طلب من شخص آخر يكمل

المريض: "يا دكتور بييجيني ضغط في صدري وعندي مص في ذراعي الشمال"

اسأل أولاً

- ضغط أو ألم مستمر في منتصف الصدر (أكثر من 20 دقيقة)
- الألم يمتد للكف الشمال أو الذراع أو الفك أو الظهر
- تعرق بارد
- غثيان أو قيء
- ضيق تنفس
- دوخة أو إغماء
- ⚠️ الأعراض غير الكلاسيكية (خاصة عند النساء والسكري والمسنين):
- إرهاق شديد غير مبرر
- ألم في البطن أو الفك فقط
- ضيق تنفس بدون ألم صدر

التوصية

- اتصل بإسعاف 123 فوراً — قبل أي شيء
- أجلسه في وضع مريح (نصف جلوس — ظهره مرتكز)
- أسبرين 300 mg يعضغه (مش يبلعه) — لو مش عنده حساسية ومش عنده نزيف نشط
- الأسبرين يمنع تجلط الصفائح ويحافظ على الشريان مفتوحاً
- لازم يُعضغ مش يُبلع — الامتناس أسرع بكثير
- لو عنده نيتروجليسرين: قرص تحت اللسان — ينتظر 5 دقائق
- أرخي ياقة قميصه وأي ضغط على صدره
- لا تتركه لوحده
- لو بدأ يفقد الوعي: استعد للـ CPR

الموضوع الثاني — الجلطة الدماغية

الحالة 3 — شخص عنده أعراض جلطة دماغية

الموقف: شخص في الصيدلية فجأة وجهه ميّال وكلامه مختلط

F – Face (الوجه) : علامة ✓ علامة : الوجه بيميل جهة ؟
A – Arms (الأيدي) : علامة ✓ علامة : إيد تنزل ؟
S – Speech (الكلام) : علامة ✓ علامة : كلامه متأثر ؟
T – Time (الوقت) : (الوقت) : اتصل بإسعاف فوراً

التوصية

- اتصل بإسعاف 123 فوراً
- لاحظ وسجل وقت بداية الأعراض — مهم جداً للعلاج (نافذة الـ 4.5 ساعة لتفتيت الجلطة)
- أجلسه أو أضجعه بأمان
- لا تديه أي دواء — ولا طعام ولا شرب
- لا تتركه يمشي لوحده
- لو فقد الوعي: ضعه على جنبه (وضع الإنفاقة) — Recovery position
- ⚠ مش صح إنك تديه أسبرين في الجلطة الدماغية — الجلطة الدماغية ممكن تكون نزيفية والأسبرين هيزودها سوءاً. اتركها للطبيب في المستشفى.

الموضوع الثالث — الحساسية الشديدة (أنفيلاكسيس)

الموقف: طفل أكل فول سوداني وبدأ وجهه ينتفخ ويبصعب عليه يتنفس

الأعراض	درجة الخطورة
حكة وطفح فقط	خفيف
حكة + شرى + انتفاخ	متوسط
انتفاخ الشفاه/اللسان + صعوبة بلع	شديد — تدخل فوري
صعوبة تنفس + صفير + انخفاض ضغط + إغماء	طوارئ — أنافيلاكسيس

- اتصل بإسعاف 123 فوراً
- (Epinephrine) **mg IM 0.5 Adrenaline** في الفخذ الخارجي — الدواء الوحيد الفعّال
- الجرعة: 0.01 mg/kg, بعد أقصى 0.5 mg للبالغين
- للأطفال: (0.15 mg) EpiPen Jr لو وزنه 15-30 kg
- يمكن تكرار بعد 5-10 دقائق لو الأعراض مستمرة
- أضع المريض على ظهره مع رفع رجليه (لو انخفض ضغطه)
- لو عنده EpiPen: استخدمه فوراً في الفخذ الخارجي — الإبرة تخترق الملابس
- لا تعطيه حاجة عن طريق الفم — مجرى هوائيه قد يكون ضيق
- بعد الإبينيفرين: مضاد هيستامين + IV كورتيزون — في الإسعاف
- التمييز:
- حساسية بسيطة (مش أنافيلاكسيس):
- شرى وحكة فقط بدون مشاكل تنفس أو ضغط
- Cetirizine أو Loratadine فورية
- راقبه 30 دقيقة
- أنافيلاكسيس:
- أي مشكلة في التنفس أو الضغط أو الوعي
- إبينيفرين فوراً + إسعاف

الموضوع الرابع — التسمم وجرعة زائدة

الأم: "يا دكتور ابني 2 سنة أكل من الحبوب اللي في درج بابا"

اسأل أولاً

- اتصل بمركز مكافحة السموم: 08008880700 فوراً
- أحضر العبوة — سيسألونك:
- اسم الدواء بالطبط
- تركيز الجرعة
- الكمية المتبقية في العبوة (لتقدير ما أكله)
- وزن الطفل وعمره
- الوقت المقدّر للابتلاع
- انتظر تعليماتهم — لا تعمل أي حاجة قبل ما يقولوا

لا تعطي

- بعض المواد أخطر لو رجعت (حوامض، قلويات، نفط)
- الاستفراغ قد يسبب استنشاق المادة للرئة
- مواد تستدعي الطوارئ الفورية:
- باراسيتامول (الجرعة الزائدة بتدمر الكبد)
- أوبيويدات (ترامادول، كودين)
- أدوية القلب (ديجوكسين، أدوية الإيقاع)
- أدوية الضغط
- منومات وبنزوديازيبينات
- حديد (جرعة كبيرة)
- منظفات وكيماويات منزلية
- الترياقات الأكثر أهمية:

السم	الترىاق
باراسيتامول	(NAC)N-Acetylcysteine — في المستشفى خلال 8 ساعات
أوبويديات (مورفين، ترامادول)	(Naloxone)Narcan — IV أو Intranasal
بنزوديازيبينات (ديازيبام)	Flumazenil — في المستشفى
أدوية الكولينستراز	Atropine + Pralidoxime
أحادي أكسيد الكربون	أكسجين 100%

الحالة 6 — جرعة زائدة من باراسيتامول عند البالغ

المريض أو أهله: "هو أخذ علبة بانادول كاملة من ساعة"

التوصية

- لماذا الباراسيتامول خطير بالجرعة الزائدة؟
- الجرعة الزائدة تُنتج مادة (NAPQI) سامة للكبد
- الأعراض الأولى خفيفة (غثيان وقيء) — يبدو بسيطاً
- الفشل الكبدي يظهر بعد 3-4 أيام — الوقت الضائع قاتل
- الإجراء:
- اتصل بإسعاف 123 فوراً — لا تنتظر أعراض
- (NAC)N-Acetylcysteine هو الترياق الوحيد — فعال لو أُعطى خلال 8 ساعات من التناول
- لو تأخرت: يمتد العلاج لـ 21 ساعة IV في المستشفى
- الجرعة الخطرة:
- فوق 150 mg/kg في جرعة واحدة — خطر الفشل الكبدي
- طفل 20 kg: فوق 3000 mg = 6 أقراص 500 mg
- بالغ 70 kg: فوق 10,500 mg = 21 قرص 500 mg

الموضوع الخامس — الإغماء والدوخة

الموقف: شاب فجأة شحب ووقع على الأرض وفقد الوعي لثوان

اسأل أولاً

- إيه اللي كان شايله؟ (وقف طويل، صيام، حرارة)
- فيه ضربات قلب غريبة قبلها؟
- فيه تاريخ قلب؟
- إغماء سابق بنفس الظروف؟

النوع	الظروف	مدة الإغماء	بعد الصحو
(Vasovagal (الأشهر)	وقوف طويل، ألم، خوف، دم	ثواني	استجابة كاملة فوراً
Orthostatic	وقوف سريع من الجلوس	ثواني	تحسن سريع
قلبي	أى وقت، مع تمرين	أطول	استجابة أبطأ
نقص سكر	سكرى أو صيام	ثواني-دقائق	ارتباك

التوصية

- إغماء بسيط ((Vasovagal):
- ضعه على ظهره — ارفع رجليه للأعلى
- تأكد من التنفس
- فكّ يافته
- لو صحي: أجلسه ببطء — لا تقومه فوراً
- أعطه ماء أو عصير لو مستيقظ ومش قاي
- لو مش صحي بعد دقيقة:
- ابدأ CPR وأتصل بإسعاف

تحذير — أحوله فوراً

- الإغماء كان مع خفقان أو ألم صدر
- تكرر أكثر من مرة
- مريض قلب معروف
- عنده إصابة في رأسه من الوقعة

الموضوع السادس — الحروق والجروح

المريض: "يا دكتور مسكت حاجة ساخنة وإيدي احترقت"

الخطوة الأولى والأهم:

ماء بارد جاري على الحرق $\times 20$ دقيقة كاملة
(مش ثلج - ماء بارد عادي)

لماذا 20 دقيقة؟

- الجلد يفضل يسخن من الداخل حتى بعد إزالة المصدر
- الماء البارد يوقف التلف المستمر ويقلل الألم

بعد التبريد:

الدرجة الأولى (احمرار فقط — مثل حرق الشمس):

• **Aloe Vera gel:** يبرّد ويرطب ويهدئ

• Paracetamol للألم

• رطب المنطقة

الدرجة الثانية (فقاعات — ألم شديد):

• **Silver Sulfadiazine cream 1% (م):** مضاد حيوي للحروق الأكثر استخداماً

• ضماد معقم غير لاصق ((Non-adherent dressing

• لا تفقع الفقاعات — بتحمي الجرح من العدوى

لا تعطي

• معجون أسنان

• زبدة أو زيت

• بيض

• ثلج مباشراً

• قطن أبيض عادي (بيلتصق بالجرح)

تحذير — أحوّله فوراً

- الحرق في الوجه أو اليدين أو الأعضاء التناسلية أو المفاصل
- الحرق أكبر من راحة يد المريض (> 1% مساحة الجسم)
- الجلد أبيض أو متفحم (الدرجة الثالثة)
- مريض سكري — أي حرق
- طفل أقل من 5 سنين أو مسن

المريض: "يا دكتور انجرحت وفيه دم شوية"

التوصية

- 1. وقف النزيف:
- ضغط مباشر بضمادة نظيفة $15-10 \times$ دقيقة بدون رفع
- ارفع الطرف المجرّح لو ممكن
- لا تشيل الضمادة لتشوف — بتفرط التجلط
- 2. تنظيف الجرح:
- ماء جاري وصابون $5-10 \times$ دقائق — الخطوة الأهم
- أزل أي جسم غريب صغير برفق
- (Povidone-Iodine بيتادين) 10%: للتعقيم — مخفف 1:10 أحسن من مركّز

- أو: 0.05% Chlorhexidine بديل ممتاز
- 3. تضميد الجرح:
- (Bacitracin Antibiotic ointment أو Neosporin: طبقة رقيقة على

الجرح

- ضمادة مناسبة
- غير الضمادة يومياً أو لو بللت
- 4. تطعيم الكزاز:
- الجرح متلوث أو صدئ:
- آخر تطعيم أقل من 5 سنين: كافي
- آخر تطعيم 5-10 سنين: جرعة تقوية
- أكثر من 10 سنين أو مجهول: جرعة تقوية فوراً

تحذير — أحوّله فوراً

- الجرح عميق أو واسع (محتاج خياطة — الحواف بتفتح ولا تقترب لوحدها)
- النزيف ما وقفش بعد 15 دقيقة ضغط
- الجرح من حيوان (كلب، قطّة، خفاش) — تقييم داء الكلب
- علامات التهاب بعد 24-48 ساعة: احمرار بيكبر، سخونة، سيلان صديد، خطوط حمراء

الموضوع السابع — طوارئ الصيف في مصر

المريض (أهل): "يا دكتور ولدنا كان في الشمس وبقي بيتكلم مش صح وجلده جاف وساخن"

Heat Stroke	Heat Exhaustion	إجهاد الحر	ضربة الشمس
الجلد	رطب عارق	جاف وساخن	
درجة الحرارة	أقل من 40	فوق 40 درجة	
الوعي	سليم	مختل — ارتباك، هذيان	
الخطورة	متوسطة	طوارئ — مميت	

التوصية

- إجهاد الحر:
- أبعده عن الشمس — مكان مظلم مكيف
- خلع الملابس الزائدة
- ORS أو ماء بارد — يشربه لو واعى
- كمادات باردة على الرقبة والإبط والفخذ
- تعافى عادةً في 30-60 دقيقة
- ضربة الشمس:
- اتصل بإسعاف 123 فوراً
- أبعده عن الشمس فوراً
- أنزل درجة حرارته بسرعة — هذا هو العلاج:
- بلله بالكامل بماء بارد
- رَوِّح عليه بمروحة بقوة
- ضع ثلجاً أو كمادات باردة على: الإبط، الرقبة، الفخذ (الأماكن التي بها أوعية كبيرة)
- لا تديه أي شيء بالبق — قد يكون مش واعى
- لا تعطيه باراسيتامول — الحرارة هنا مش من التهاب بل من فشل تنظيم حرارة الجسم — الباراسيتامول مش هيفيد

الموقف: طفل أُخرج من المسبح وهو لا يستجيب

التوصية

- اتصل بإسعاف 123 فوراً
- افحص التنفس
- لو مقيش تنفس: ابدأ CPR فوراً
- للغريق: ابدأ بـ 5 أنفاس إنقاذ ثم 30 ضغطة (عكس الترتيب العادي) — الأكسجين المهم أولاً
- لا تحاول تُخرج الماء بضغط الصدر — ذلك مش صح ومش هيفيد
- ضع المصاب على جنبه بعد صحّوه (وضع الإنفاقة)
- ⚠ حتى لو صحي: الطفل اللي شبه غرق لازم يروح المستشفى لمراقبة 24-48 ساعة — "Secondary Drowning" ممكن يحصل بعد ساعات.

المريض: "يا دكتور لسعتني نحلة، أعمل إيه؟"

اسأل أولاً

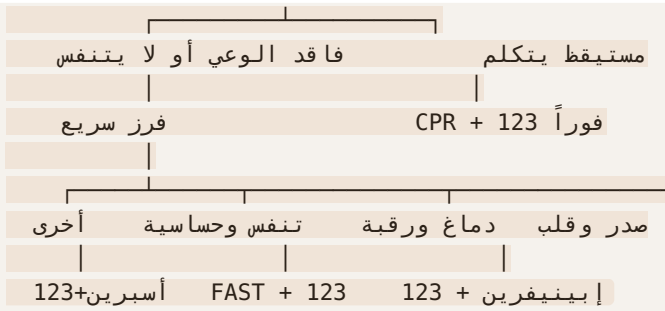
- فيه انتفاخ بعيد عن مكان اللسعة؟ في الوجه أو الحلق؟
- صعوبة تنفس أو بلع؟
- سبق عنده رد فعل قوي من لسعة قبل كده؟

التوصية

- لسعة بسيطة (ألم واحمرار موضعي فقط):
- أزل الشوكة لو موجودة — اكشط بظفرك أو بطاقة بلاستيكية (لا تضغط عليها — بئفرز مزيد من السم)
- اغسل المنطقة بماء وصابون
- كمادة باردة $10 \times$ دقائق — تقلل الألم والورم
- **Hydrocortisone cream 1%** موضعياً
- **Loratadine** أو **Cetirizine** فموي للحكة والانتفاخ الخفيف
- **Paracetamol** للألم
- رد فعل تحسسي (انتفاخ كبير موضعي):
- **Oral Antihistamine** كورتيزون فموي قصير (**Prednisolone 20-30 mg** × 3-5 أيام)
- أنافيلاكسيس (انتفاخ بعيد + ضيق تنفس + ضغط):
- **Epinephrine IM** + إسعاف 123 فوراً

ملخص قرارات الطوارئ — خريطة سريعة

شخص في الصيدلية يشكو من أعراض



الحالة	الدواء الفوري	ثم
جلطة قلبية	أسبرين 300 mg يُمَضَّغ	123
جلطة دماغية	لا شيء	123
أنافيلاكسيس	Epinephrine 0.5 mg IM	123
مهبوط سكر	15 g سكر سريع	تحسن ثم طبيب
جرعة زيادة باراسيتامول	لا شيء فوري	123 + مركز سموم
حرق	ماء بارد 20 دقيقة	Silveri م
ضربة شمس	تبريد فوري	123
إغماء بسيط	ارفع الرجلين	مراقبة

❓ المبدأ الذهبي في الطوارئ:

123 قبل أي دواء في الحالات الحرجة.

الأسبرين في الجلطة القلبية يُمضغ مش يُبلع.

الأنافيلاكسيس = Epinephrine IM فوراً — لا تتأخر.

الباراسيتامول الزائدة بتدمر الكبد بعد 3 أيام — روح المستشفى فوراً.

CPR بدون أنفاس (ضغوطات فقط) أحسن من لا شيء.

القسم الثالث

الأقسام الإضافية

التفاعلات الدوائية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: التفاعلات الدوائية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

هذا القسم قد ينقذ حياة. التفاعلات الدوائية مسؤولة عن 5-10% من دخول المستشفيات في مصر — ومعظمها كان يمكن تجنبه لو فيه في صيدلاني واعى وقف وسأل.

أولاً — أنواع التفاعلات

فارماكوكينيتي: الدواء A يغيّر كيف الجسم يتعامل مع الدواء (B امتصاص، استقلاب، إخراج).
فارماكوديناميكي: الدواء ان بيعملا نفس التأثير فيتضاعف، أو عكس بعض فيتلغى.

الموضوع الأول — تفاعلات يجب حفظها عن ظهر قلب

الحالة 1 — وارفارين مع أي دواء جديد

المريض: "يا دكتور بياخد وارفارين وعنده التهاب، الدكتور كتب له كلاريثروميسين"
التوضيح:

الوارفارين أخطر دواء من ناحية التفاعلات — يتفاعل مع أكثر من 200 دواء.

آلية الخطر: الوارفارين يُستقلب في الكبد عبر CYP2C9.

- دواء يثبط (CYP2C9 زي كلاريثروميسين) = تركيز وارفارين يرتفع = خطر نزيف شديد
- دواء يحفز (CYP2C9 زي ريفامبيسين) = تركيز وارفارين ينخفض = جلطة

أخطر التفاعلات مع الوارفارين:

الدواء	التأثير على الوارفارين	الخطر
Erythromycin , Clarithromycin	يرفع التركيز	نزيف
Metronidazole , Ciprofloxacin	يرفع التركيز	نزيف
NSAIDs , Aspirin	تأثير إضافي على الصفائح	نزيف مضاعف
Amiodarone	يرفع التركيز بشكل كبير	نزيف خطير
Rifampicin	يخفض التركيز بشكل كبير	جلطة
Simvastatin 80 mg	يرفع مخاطر عضلية	رابدوميوليسيس
بعض الفطريات ((Fluconazole	يرفع التركيز	نزيف

التوصية:

- أي مريض على وارفارين يبدأ دواء جديد = يحتاج مراقبة INR قريبة
- أبلغ الطبيب الكاتب بأن المريض على وارفارين
- المسكن الآمن الوحيد معه: باراسيتامول بجرعة أقل من 2g يومياً
- لا تصرف أي NSAID لمريض وارفارين بدون موافقة طبيبه

علامات نزيف الوارفارين — قل للمريض يراجع فوراً لو:

- بول أحمر أو بني داكن
- براز أسود قطراني
- كدمات كبيرة من ضربة بسيطة
- نزيف لثة أو أنف لا يوقف

الحالة 2 — ستاتين مع كلاريثروميسين

المريض: "يا دكتور بياخذ أتورفاستاتين وعنده التهاب، الدكتور كتب له كلاريثروميسين"

التوضيح:

الستاتينات تُستقلب عبر CYP3A4 في الكبد.

الكلاريثروميسين يثبط CYP3A4 بشدة = تركيز الستاتين يرتفع 5-10 أضعاف.

النتيجة: Myopathy = ألم عضلي شديد، وفي أقصى الحالات = Rhabdomyolysis انهيار العضلات = فشل كلوي.

الستاتينات الأكثر تأثراً (تُستقلب عبر CYP3A4):

• Simvastatin الأعلى خطراً مع CYP3A4 inhibitors

• Atorvastatin خطر متوسط

• Lovastatin خطر عالي

الستاتينات الآمن (لا تتأثر بـ CYP3A4):

• Rosuvastatin الأفضل في وجود تفاعلات

• Pravastatin آمن

• Fluvastatin آمن نسبياً

التوصية:

• لو المريض على Simvastatin أو Atorvastatin أبلغ الطبيب

• البديل: تغيير المضاد الحيوي لأزيثروميسين (أقل تثبيطاً) أو Rosuvastatin للستاتين

• مدة الكلاريثروميسين قصيرة (7-14 يوم) فالخطر محدود نسبياً — لكن المريض لازم يبلغ لو جاه ألم عضلي

الحالة 3 — ACE inhibitors مع بوتاسيوم أو Spironolactone

المريض: "يا دكتور بياخذ ليزينوبريل وسبيرونولاكتون معاً للضغط والقلب"

التوضيح:

(ACE inhibitors الـ -pril) بتحبس البوتاسيوم في الجسم.

Spironolactone كمان بتحبس البوتاسيوم.

الاثنين مع بعض = فرط بوتاسيوم (Hyperkalemia).

فرط البوتاسيوم يسبب:

• ضعف عضلي

• اضطرابات في نبض القلب

• في الحالات الشديدة: توقف القلب

التوصية:

- التركيبة دي مسموح بها لكن تحتاج مراقبة دورية لمستوى البوتاسيوم والكرياتينين
- المريض يتجنب مكملات البوتاسيوم وبدائل الملح (= Salt Substitutes كلوريد البوتاسيوم)
- تجنب NSAIDs لهذا المريض = تزيد خطر ارتفاع البوتاسيوم وتضر بالكلية
- لو المريض حس بضعف غير عادي أو خفقان غريب = تحليل بوتاسيوم فوراً

الحالة 4 — بنزوديازيبين مع أوبيويد

المريض: "يا دكتور بياخذ ألبرازولام للقلق وترامادول للألم"

التوضيح:

كلاهما مثبطات للجهاز العصبي المركزي.

تأثيرهما معاً = تثبيط تنفسي خطير.

FDA أصدرت تحذير: Black Box

"الجمع بين الأوبيويدات والبنزوديازيبينات يزيد خطر الوفاة من تثبيط التنفس"

التوصية:

- لو المريض على الاثنين: أبلغه يبلغ طبيبه
- الجرعات المنخفضة لفترات قصيرة مقبولة تحت إشراف
- أهل المريض يعرفوا علامات الخطر: تنفس بطيء جداً، لون أزرق، صعوبة في الإفاقة
- الكحول مع أي منهما = مضاعفة الخطر

الحالة 5 — SSRIs مع Tramadol

المريض: "بياخذ سيرترالين للاكتئاب وترامادول للألم"

التوضيح:

كلاهما يرفع السيروتونين في الجهاز العصبي.

معاً = خطر. Serotonin Syndrome

Serotonin Syndrome: أعراض

- ارتجاف ورعشة
 - ارتفاع حرارة
 - تعرق غزير
 - ارتباك وأرق شديد
 - في الحالات الشديدة: تشنجات وعدم انتظام ضربات القلب
- التوصية:

- الجمع ممكن لكن بحذر وبجرعات منخفضة
- أبلغ الطبيب إذا جُمعا
- المريض يعرف الأعراض ويراجع فوراً لو حسها
- البديل للألم: باراسيتامول أو NSAIDs بدل ترامادول

الحالة 6 — ميتفورمين مع أشعة بالصبغة

المريض: "يا دكتور بياخذ ميتفورمين والدكتور عايزه يعمل CT بصبغة بكرة"

التوضيح:

الصبغة ((Contrast media ممكن تأثر مؤقتاً على الكلى.
لو الكلى اشتغلت أبطأ = الميتفورمين يتراكم في الجسم.
تراكم الميتفورمين = Lactic Acidosis حالة طارئة خطيرة.
البروتوكول المعتمد:

- وقف الميتفورمين 48 ساعة قبل الأشعة
- لا ميتفورمين يوم الأشعة
- بعد الأشعة: تحليل كرياتينين، لو طبيعي = يرجع للميتفورمين بعد 48 ساعة

التوصية:

- أي مريض ميتفورمين جيلك بورقة موعد CT بصبغة: ذكره يبلغ الطبيب ويوقف الميتفورمين

الحالة 7 — ليفوثيروكسين (ثيروكسين) مع أدوية أخرى

المريض: "يا دكتور بياخذ ثيروكسين وحديد وكالسيوم في نفس الوقت"
التوضيح:

الثيروكسين يُمتص في الأمعاء عبر آلية خاصة.

كثير من الأدوية والمكملات تربط الثيروكسين في الأمعاء وتمنع امتصاصه.
المواد التي تتفاعل مع الثيروكسين:

المادة	الفاصل الزمني المطلوب
الحديد (أقراص)	4 ساعات على الأقل
الكالسيوم (أقراص)	4 ساعات على الأقل
مضادات الحموضة (Antacids)	4 ساعات على الأقل
PPIs و Omeprazole	يقللوا الامتصاص - يأخذ أول المصح
حليب الصويا والألبان	ساعة على الأقل
قهوة	ساعة على الأقل

القاعدة: الثيروكسين أول شيء صباحاً على معدة فاضية - ساعة كاملة قبل أي حاجة.

الموضوع الثاني — تفاعلات الأكل مع الأدوية

الحالة 8 — وارفارين والخضروات الخضراء

المريض: "يا دكتور سمعت إنني ممنوع أكل سبانخ وأنا على وارفارين؟"
التوضيح:

الخضروات الخضراء (سبانخ، خس، بروكلي، كرات، ملوخية) غنية بفيتامين K.
فيتامين K يعاكس تأثير الوارفارين (الوارفارين يثبط فيتامين K).
الحقيقة المهمة:

- مش ممنوع تأكلهم - لكن لازم تكون الكميات ثابتة.

- لو بياكل ملوخية كل يوم: الجرعة تُضبط على كده.
- لو بياكل ملوخية يوم وما باكلهاش أسابيع: INR بيتقلب.
- الاتساق أهم من الامتناع.

التوصية للمريض:

- اتساق في أكل الخضروات الخضراء - مش زيادة مفاجئة أو نقص مفاجئ.
- يعمل INR بانتظام (كل 2-4 أسابيع حسب طبيبه).
- لو غير نظامه الغذائي: يبلغ طبيبه.

الحالة 9 — عصير الجريب فروت مع أدوية كثيرة

المريض: "بياخد أملوديدين ويحب يشرب جريب فروت كل الصباح"

التوضيح:

الجريب فروت ((Grapefruit)) يحتوي على مواد تثبط إنزيم CYP3A4 في الأمعاء والكبد. CYP3A4 مسؤول عن استقلاب كثير جداً من الأدوية. النتيجة: تركيز الدواء في الدم يرتفع بشكل غير متوقع. أدوية تتأثر بالجريب فروت:

الدواء	الخطر
Atorvastatin, Simvastatin	تركيز يرتفع = خطر عضلى
Nifedipine, Amlodipine	تركيز يرتفع = ضغط ينزل جداً
Cyclosporine	تركيز يرتفع = سمية
بعض مضادات المصع	تغير في التركيز
بعض مضادات الاكتئاب	تغير في التركيز

التوصية:

- مريض على ستاتين أو CCB تجنب الجريب فروت أو اشربه على فترات بعيدة من الدواء.
- البرتقال العادي والليمون: لا مشكلة.

الحالة 10 — التتراسيكلين والألبان

المريض: "الدكتور كتبلي دوكسيسيسكلين وبياخده مع الشاي بلبن"

التوضيح:

الكالسيوم في الألبان والجبنه يربط الدوكسيسيسكلين في الأمعاء ويمنع امتصاصه = الدواء لا يعمل.

نفس المشكلة مع:

- الحليد (حبوب حديد)
- كالسيوم (حبوب كالسيوم)
- مضادات الحموضة ((Antacids التي تحتوي ماغنيسيوم أو ألومنيوم أو كالسيوم
- منتجات الصويا

التوصية:

- الدوكسيسيسكلين على معدة فاضية أو مع ماء فقط.
- لو عنده غثيان على معدة فاضية: مع أكل خفيف خالي من الألبان.
- انتظر ساعتين على الأقل بين دوكسيسيسكلين وأي من المواد أعلاه.

الموضوع الثالث — تفاعلات تطيل QT (قلبي)

الحالة 11 — تراكم أدوية تطيل QT

المريض: "يا دكتور بياخد أزيثروميسين وعنده اضطراب إيقاع وبياخد عليه أميودارون"

التوضيح:

إطالة QT في مخطط القلب = زيادة خطر اضطراب إيقاع خطير ((Torsades de Pointes يمكن أن يتحول لرجفان بطيني وموت مفاجئ.

أدوية تطيل QT:

الفئة الأولى (خطر عالي):

- (Amiodarone أميودارون)

• (Haloperidol هالوبيريدول)

• Methadone

• Sotalol

الفئة الثانية (خطر متوسط):

• (Azithromycin زيثروماكس) - خطر في مرضى القلب

• (Clarithromycin كلاسيد) - أكثر من أزيثروميسين

• Levofloxacin ,Ciprofloxacin

• Haloperidol ,Chlorpromazine

• (Domperidone موتيليوم) - بجرعات عالية أو مزمنة

• (Ondansetron زوفران) - خاصة IV

التوصية:

• مريض على أميودارون: تجنب الفلوروكينولونات والماكروليدات لو في بديل.

• لو لازم: أقصر مدة ممكنة وتحت إشراف طبي.

• أبلغ الطبيب الكاتب بكل الأدوية التي يأخذها المريض.

ملخص سريع — أخطر التفاعلات في الصيدلية المصرية

التفاعل	الخطر	الإجراء
وارفارين + أي NSAID	نزيف	لا تعطيه - باراسيتامول فقط
وارفارين + كلاريثروميسين	نزيف	أبلغ الطبيب
+ Simvastatin كلاريثروميسين	رابدوميوليسيس	أبلغ الطبيب
ACE inhibitor + Spironolactone + NSAID	فرط بوتاسيوم + فشل كلوي	ممنوع NSAIDs
Tramadol + SSRI	سيروتونين سيندروم	أبلغ الطبيب
بنزوديازيبين + أوبيويد	توقف التنفس	حذر + أبلغ
ميتفورمين + صبغة أشعة	لاكتيك أسيدوزيس	وقف 48 ساعة قبل
نيروكسين + حديد/كالمسيوم	فشل الامتصاص	4 ساعات فاصلة
دوكسيسيكلين + ألبان/حديد	فشل الامتصاص	معدة فاضية

المبدأ الذهبي في التفاعلات:

قبل ما تصرف لمريض مزمن أي دواء جديد: اسأله عن كل حاجة بياخذها.

الوارفارين والديجوكسين والليثيوم ومضادات الصرع = أدوية هامش ضيق.

أي تفاعل مش متأكد منه: استشر التطبيقات المتخصصة (Medscape Interactions, Drugs.com).

القسم الثالث — التفاعلات الدوائية · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

قراءة نتائج التحاليل

[صورة غلاف توضيحية لفصل: قراءة نتائج التحاليل]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

المريض ببجيبلك بورقة تحاليل ويسألك "دي تمام؟" — ده موقف يومي. لازم تعرف تقرأ الأرقام وتوضح للمريض، وتعرف امتي ترسله للطبيب فوراً.

الموضوع الأول — صورة الدم الكاملة ((CBC

المؤشر	القيمة الطبيعية	لو منخفض	لو مرتفع
Hgb)Hemoglobin (	رجل: 13-17 g/dL / ست: 12-16 g/dL	فقر دم - إرهاق وشحوب	نادر - جفاف أو حالات خاصة
WBC)كريات بيضاء (	mL/ 4,000-11,000	نقص مناعة - خطر	التهاب أو عدوى أو لوكيميا
Platelets)صفائح (	150,000-400,000	خطر نزيف	احتمال جلطة
MCV)حجم الكرية (	fL 80-100	نقص حديد أو B6	نقص B12 أو حمض الفوليك
MCH	pg 27-33	نقص حديد	نقص B12
HCT)Hematocrit (	رجل: 40-52% / ست: 36-48%	فقر دم	جفاف

الحالة 1 — مريض يجيب CBC

المريض: "يا دكتور دي نتيجة تحليل الدم بتاعتي، = 9.5 Hgb طبيعية؟"

التوضيح:

- = 9.5 Hgb فقر دم متوسط (أقل من 12 للسيدات، أقل من 13 للرجال)
- الخطوة التالية: شوف MCV
- MCV منخفض (أقل من 80): فقر دم بنقص الحديد (الأشيع في مصر)

- MCV طبيعي (80-100): فقر دم مزمن أو مرض كلبي
- MCV مرتفع (فوق 100): نقص B12 أو حمض الفوليك

التوصية:

- MCV منخفض + Hgb 9.5: تراجع طبيب، على الأرجح محتاج حديد
- لو سيدة: اسألها عن الدورة الشهرية
- لو رجل بفقر دم بالحديد: طبيب - لازم يعرف السبب (نزيف خفي؟)

الموضوع الثاني — سكر الدم

التحليل	القيمة	التفسير
سكر صيام ((Fasting Glucose	أقل من 100 mg/dL	طبيعي
	100-125	قبل السكري ((Pre-diabetes
	126 وأكثر (مرتين)	سكري
سكر بعد أكل ((2hr Post-prandial	أقل من 140	طبيعي
	140-199	قبل السكري
	200 وأكثر	سكري
HbA1c	أقل من 5.7%	طبيعي
	5.7-6.4%	قبل السكري
	6.5% وأكثر	سكري
	هدف العلاج لمرضى السكري: أقل من 7%	

الحالة 2 — مريض يجيب HbA1c

المريض: "يا دكتور HbA1c بتاعتي طلعت 7.8، كويسة؟"

التوضيح:

- 7.8% = السكر غير منضبط بالكامل (الهدف أقل من 7%)
- HbA1c يعكس متوسط السكر في آخر 3 شهور

• كل 1% زيادة = زيادة ملحوظة في خطر المضاعفات

التوصية:

- تراجع طبيبه لمراجعة العلاج
- ممكن يحتاج تعديل في الجرعة أو إضافة دواء جديد
- مشي يومي 30 دقيقة + تقليل الكربوهيدرات = بيفرق فرق حقيقي في HbA1c

الموضوع الثالث — وظائف الكلى

المؤشر	القيمة الطبيعية	التفسير
Creatinine	رجل: 0.7-1.2 mg/dL / ست: 0.5-1.0	الكلى بفرز الكرياتينين
(BUN يوريا)	7-20 mg/dL	منتج استقلاب البروتين
eGFR	فوق 90 mL/min/1.73m ²	كفاءة الكلى

تفسير (eGFR كفاءة الكلى):

eGFR	المرحلة	الإجراء
فوق 90	طبيعي	مراقبة لو فيه خطر
60-89	خفيف	مراقبة دورية
30-59	متوسط	تعديل جرعات، تجنب NSAIDs
15-29	شديد	تحت إشراف متخصص
أقل من 15	فشل كلوي	غسيل كلوي أو زراعة

الحالة 3 — مريض يطلب مسكن وعنده كلى

المريض: "يا دكتور بياخذ علاج للكلى وعنده ألم ظهر"

التوضيح:

- eGFR أقل من 30: NSAIDs ممنوعة تماماً (تقلل الدم للكلى)
- الميتفورمين: يوقف لو eGFR أقل من 30

• الليزينوبريل والأدوية الكلوية الحامية: تحت إشراف دقيق

التوصية:

- مريض كلى + ألم: باراسيتامول فقط بالجرعة المناسبة
- ممنوع إيبوبروفين، فولتارين، أي NSAID
- راجع الطبيب لضبط جرعات أدوية الكلى

الموضوع الرابع — وظائف الكبد

المؤشر	القيمة الطبيعية	التفسير
(SGPT)ALT	U/L 7-56	إنزيم خاص بالكبد - أدق
(SGOT)AST	U/L 10-40	أقل خصوصية - في القلب والعضلات أيضاً
ALP	U/L 44-147	صفراء وعظام
(Bilirubin إجمالي)	mg/dL 0.2-1.2	اصفرار لو ارتفع
Albumin	g/dL 3.5-5.5	وظيفة تصنيعية للكبد
PT/INR	0.8-1.2 (لغير الوارفارين)	وظيفة تخثر الكبد

تفسير ارتفاع الإنزيمات:

الارتفاع	التفسير
1-3 × الطبيعي	خفيف - مراقبة
3-10 × الطبيعي	متوسط - تحقيق
أكثر من 10 × الطبيعي	حاد - طبيب فوراً

الحالة 4 — مريض بارتفاع إنزيمات

المريض: "يا دكتور ALT طلع 85، طبيعي؟"

التوضيح:

- 85 = ضعف الطبيعي تقريباً - ارتفاع خفيف

- الأسئلة المهمة: بياخذ أي أدوية؟ (ستاتين، باراسيتامول بجرعات عالية)؟ يشرب كحول؟ فيه وزن زيادة؟

التوصية:

- يراجع الطبيب - محتاج سبب
- أشيع الأسباب في مصر: كبد دهني ((NAFLD، التهاب كبد، أدوية

الموضوع الخامس — الكوليسترول والدهون

المؤشر	المستهدف	التفسير
Total Cholesterol	أقل من 200 mg/dL	
(LDL الضار)	أقل من 100 عمومًا / أقل من 70 لمرضى القلب	
(HDL النافع)	فوق 40 رجل / فوق 50 ست	الأعلى أحسن
(Triglycerides TG)	أقل من 150 mg/dL	
Non-HDL	أقل من 130	

الحالة 5 — مريض يجيب كوليسترول

المريض: "يا دكتور نتيجتي: Total = 220, LDL = 145, HDL = 38, TG = 210"
التوضيح:

- Total 220 مرتفع بسيط
- LDL 145 مرتفع (فوق 100)
- HDL 38 منخفض (الأسوأ - النافع قليل)
- TG 210 مرتفع (فوق 150)

التوصية:

- هذه الصورة تحتاج طبيب لتقييم خطر قلبي الوعائي الكلي
- TG مرتفع: قلل السكر والكربوهيدرات والكحول
- HDL منخفض: زيد النشاط البدني وأوميغا 3

• LDL مرتفع: ستاتين على الأرجح من الطبيب

الموضوع السادس — الغدة الدرقية

المؤشر	القيمة الطبيعية	التفسير
TSH	mIU/L 0.4-4.0	أهم تحليل للغدة
Free T4	ng/dL 0.8-1.8	الهرمون الفعّال
Free T3	pg/mL 2.3-4.2	الأنشط

فهم TSH:

TSH	T4	التفسير
مرتفع (فوق 4)	منخفض	قصور الغدة ((Hypothyroidism - كسل، سمنة، برود
منخفض (أقل من 0.4)	مرتفع	فرط نشاط ((Hyperthyroidism - خفقان، رجفان، نزول وزن
مرتفع	طبيعي	قصور تحت الإكلينيكي - مراقبة

الحالة 6 — مريض يجيب TSH

المريض: "يا دكتور TSH بتاعتي = 8.5، طبيعي؟"

التوضيح:

- TSH 8.5 مرتفع = قصور الغدة الدرقية
- الأعراض المتوقعة: تعب، كسل، زيادة وزن، إمساك، برود
- مريض على ثيروكسين وTSH لسه مرتفع = الجرعة تحتاج تعديل

التوصية:

- يراجع طبيبه لضبط الجرعة أو البدء في العلاج
- ذكر مريض الثيروكسين: الدواء على معدة فاضية ساعة قبل أي حاجة

الموضوع السابع — تحاليل يجب معرفتها فوراً

قيم تستدعي إرسال المريض للطبيب فوراً:

التحليل	القيمة الخطرة
(Potassium بوتاسيوم)	أقل من 2.5 أو أكثر من 6.0 mEq/L
(Sodium صوديوم)	أقل من 120 أو أكثر من 155 mEq/L
(Glucose سكر)	أقل من 50 أو أكثر من 500 mg/dL
Creatinine	أكثر من 10 mg/dL
Hemoglobin	أقل من 7 g/dL
Platelets	أقل من 20,000
WBC	أكثر من 30,000 أو أقل من 1,000
INR	أكثر من 4 في مريض وارفارين

ملخص سريع — ماذا أقول للمريض؟

التحليل	الطبيعي	لو مش طبيعي
Hgb	فوق 12 (ست) أو 13 (رجل)	فقر دم - طبيب
HbA1c	أقل من 5.7%	فوق 6.5% = سكري
Creatinine	أقل من 1.2	كلية متأثرة - طبيب
ALT	أقل من 56	كبد متأثر - طبيب
TSH	0.4-4.0	فوق 4 = قصور غدة
LDL	أقل من 100	فوق 130 = تدخل
TG	أقل من 150	فوق 200 = تدخل

المبدأ الذهبي في التحاليل:

أنت تشرح - الطبيب يشخص.

أي قيمة خارج المدى المكتوب في الورقة: يراجع طبيبه.

أرقام الطوارئ في الجدول أعلاه = روح المستشفى فوراً.

القسم الثالث — قراءة نتائج التحاليل · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

التخزين وإدارة المخزون

[صورة غلاف توضيحية لفصل: التخزين وإدارة المخزون]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

دواء صح بتخزين غلط = دواء فاسد. المريض يأخذ حاجة مش فاعلة أو حتى ضارة وهو مش عارف.

الموضوع الأول — درجات الحرارة والتخزين

جدول التخزين الأساسي:

الحرارة	التصنيف	الأمثلة
2-8 درجة (تلاجة)	Refrigerated	أنسولين، لقاحات، بعض القطرات، بعض المضادات المخففة
8-15 درجة (بارد)	Cool	نادر في الاستخدام اليومي
15-25 درجة (معتدل)	Room Temperature	معظم الأقراص والكبسولات
15-30 درجة (درجة حرارة الغرفة)	Controlled RT	أدوية قياسية - معظم الصيدليات
أقل من 25 درجة	Below 25	بعض الشرابات والكريمات

الحالة 1 — الصيف المصري ومشكلة الحرارة

المشكلة: في الصيف حرارة القاهرة بتوصل لـ +40 درجة.

الأدوية الأكثر تأثراً:

- الأنسولين: يتلف فوق 30 درجة - يصبح غير فعال
- اللقاحات: حساسة جداً لأي ارتفاع
- بعض قطرات العين: تتغير تركيبتها
- الكريمات والمراهم: تنفصل مكوناتها

العلامات إن الدواء اتلف:

- الأنسولين: لون متغير، عكارة، حبيبات (الأنسولين الطبيعي شفاف ماعدا NPH)
- الكريمات: انفصال الطبقات أو رائحة غريبة
- الأقراص: لون متغير أو تفتت
- المضادات المخففة (معلق): رائحة غريبة

الموضوع الثاني — أدوية التلاجة

الحالة 2 — تعليمات أدوية التلاجة للمريض

أدوية التلاجة الشائعة:

الدواء	ملاحظات
أنسولين غير مفتوح	تلاجة حتى يُستخدم
أنسولين مفتوح	درجة حرارة الغرفة أقل من 30 درجة حتى 28 يوم
اللقاحات	تلاجة دائماً - لا يتجمد
Augmentin معلق بعد التحضير	تلاجة - يصلح 7 أيام
Amoxicillin معلق بعد التحضير	تلاجة أو درجة حرارة الغرفة - اقرأ النشرة
بعض قطرات العين	بعدها يُحفظ في التلاجة - اقرأ النشرة
Lactulose شراب	ممكن تلاجة لتحسين الطعم

تعليمات التلاجة للمريض:

- الدواء في الجزء الأوسط من التلاجة - مش في الباب (درجة حرارة متغيرة)
- بعيد عن الفريزر - الأنسولين المجمد لا يُستخدم
- بعيد عن الخضروات الرطبة
- في كيس بلاستيكي محكم - لا رطوبة

الموضوع الثالث — مدد الصلاحية بعد الفتح

الدواء	مدة الصلاحية بعد الفتح
معظم قطرات العين	28 يوم بعد أول فتح
معلق أموكسيسيلين	14-7 يوم (اقرأ العبوة)
معلق أوجمنتين	7 أيام في الثلاجة
شراب الباراسيتامول	حتى تاريخ انتهاء الصلاحية
أنسولين مفتوح	28 يوم (معظم الأنواع)
(Nitro SL نيترومينت)	6 أشهر بعد فتح العبوة
كريمات وأمرام	3-6 شهور بعد الفتح

الحالة 3 — مريض يحضر قطرة عين قديمة

المريض: "يا دكتور فتحت القطرة من 3 شهور، لسه صالحة؟"

التوضيح:

- معظم قطرات العين تصلح 28 يوم فقط بعد الفتح
- السبب: الحافظات ((Preservatives تنتهي صلاحيتها ويبدخل تلوث
- بعدها: خطر التهاب عين من القطرة نفسها

التوصية:

- القطرة اللي فتحت من أكثر من شهر: ارميها
- اكتب تاريخ الفتح على العبوة بالتيتا
- قطرات بدون حافظة ((Preservative-free: تُستخدم مرة واحدة فقط ثم ترمى

الموضوع الرابع — التعامل مع الأدوية المنتهية

الحالة 4 — مريض يجيب أدوية منتهية الصلاحية

المريض: "يا دكتور عندي حبوب ضغط انتهت من شهر، تنفع لسه؟"

التوضيح:

الحقيقة العلمية:

- معظم الأدوية الصلبة (أقراص وكبسولات) تحتفظ بـ 80-90% من فاعليتها لفترة بعد انتهاء الصلاحية
- الاستثناءات الخطيرة: أدوية لا تُستخدم أبداً بعد انتهاء الصلاحية
- الأنسولين
- مضادات حيوية سائلة (معلق)
- أدوية للعيون
- أدوية ضيقة الهامش (وارفارين، ديجوكسين، فينيتوين)
- نيترو تحت اللسان
- (EpiPen إبينيفرين للحساسية)

التوصية:

- أدوية الضغط العادية منتهية بشهر = من الناحية العلمية قد تصلح، لكن:
- الأمان أولاً - لا تستخدمها
- جدد وصفتك فوراً
- ابعد عن أدوية الهامش الضيق منتهية الصلاحية تماماً

التخلص من الأدوية المنتهية:

- لا ترميها في القمامة المنزلية (تلوث بيئي)
- لا تطفيها في الحمام (تلوث مياه)
- أفضل حل: أعدها للصيدلية لو فيه نظام تجميع، أو في كيس مختلط بتراب أو رماد

الموضوع الخامس — قراءة النشرة الداخلية والتعبئة

الحالة 5 — مريض لا يقرأ النشرة

المريض: "يا دكتور مش بقرأ الورقة الجوا، في حاجة مهمة؟"

أهم ما في النشرة:

1. موانع الاستخدام - يجب أن تقرأها
2. التفاعلات الدوائية - مهمة للغاية
3. التحذيرات الخاصة - حمل، رضاعة، أطفال
4. طريقة الحفظ - الحرارة والضوء والرطوبة
5. تاريخ الانتهاء - وكيف تحسب المدة بعد الفتح

ما لا تحتاج أن تقرأه:

- الكيمياء والتركيب الجزيئي
- كل الأعراض الجانبية النادرة (100,000 مريض واحد يصيبه)

الموضوع السادس — الضوء والرطوبة

أدوية حساسة للضوء:

الدواء	التخزين
(Nitroglycerin نيتروغليسرول)	عبوة بنية داكنة - بعيد عن الضوء
Sodium Nitroprusside	محلول محمي من الضوء
Haloperidol ,Chlorpromazine	بعيد عن الضوء
بعض قطرات العين	في العبوة الأصلية الداكنة
Furosemide للحقن	محمي من الضوء

أدوية حساسة للرطوبة:

الدواء	التحذير
أقراص Aspirin	يتحول لحمض خليك بالرطوبة - رائحة خل = تالف
بعض الفيتامينات	في عبوات محكمة مع desiccant
(Effervescent tablets فورات)	في أنبوب مقفول جيداً - تتفاعل بالرطوبة

القاعدة: الحمام مش مكان تخزين الأدوية رغم الشيوخ - رطوبة عالية وحرارة متغيرة.

الموضوع السابع — أدوية الرقابة الخاصة

الحالة 6 — التعامل مع الأدوية الخاضعة للرقابة

في مصر، الأدوية الخاضعة للرقابة:

- المسكنات القوية: ترامادول (في بعض التركيزات)، كودين
- منومات: Zolpidem، بعض البنزوديازيبينات
- مضادات النفسية القوية

واجباتك:

- طلب وصفة طبية أصلية ومختومة
- عدم التجديد بدون وصفة جديدة
- تسجيل في سجل خاص لو مطلوب
- عدم صرف كميات مشبوهة أو متكررة
- رفض الوصفات التي تبدو مزورة (توقيع غير واضح، تاريخ مختلف)

ملخص سريع

الموقف	القرار
دواء منتهي بشهر (ضغط)	لا تستخدمه - جدد
أنسولين منتهي	ارمه فوراً
قطرة مفتوحة من شهرين	ارمها
معلق أطفال من أسبوعين في الثلاجة	اقرأ النشرة - الغالب بيخلص في 7-14 يوم
أدوية في الحمام	انقلها لمكان جاف
أنسولين في الصيف للمسافر	حافظه حرارية - لا تلتج مباشر

المبدأ الذهبي في التخزين:

الحرارة والرطوبة والضوء أعداء الدواء.

الثلاجة مش معناها الفريزر.

28 يوم = الحد الأقصى لمعظم قطرات العين.

الأنسولين المتغير اللون أو العكر = لا تحقنه.

القسم الثالث — التخزين وإدارة المخزون · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

المريض المسن في الصيدلية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: المريض المسن في الصيدلية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

المسن مشي بالغ كبير السن فقط. جسمه يعمل بشكل مختلف، كليته وكبدته أبطأ، وهو في الغالب يياخذ 5 أدوية أو أكثر. كل قرار صرف هنا يتضاعف خطره.

أولاً — لماذا المسن مختلف فسيولوجياً؟

التغيير الفسيولوجي	الأثر على الدواء
تراجع وظيفة الكلى	تراكم الأدوية التي تُطرح بالكلى
تراجع وظيفة الكبد	تراكم الأدوية التي تُستقلب بالكبد
قلة الماء في الجسم	ارتفاع تركيز الأدوية الذائبة في الماء
زيادة الدهون نسبياً	تراكم الأدوية الذائبة في الدهون
قلة ألبومين الدم	نشاط أعلى للأدوية المرتبطة بالألبومين
حساسية أعلى للجهاز العصبي	استجابة مبالغ فيها للمنومات والمهدئات
تراجع الحواس	صعوبة قراءة التعليمات والاستخدام الصحيح

القاعدة: ابدأ بجرعة منخفضة وزد ببطء (Start Low, Go Slow).

الموضوع الأول — أدوية خطيرة على المسن

قائمة Beers — أدوية يجب تجنبها أو تقليلها للمسن:

الحالة 1 — مسنة تطلب منوم

المریضة: "یا دکتورة أنا عندی 70 سنة ومش قادرة أنام، عایزة حبة ديازيبام"
التوضیح:

البنزوديازيبينات (ديازيبام، ألبرازولام، كلونازيبام) خطيرة على المسنين:

- تراكم في الجسم لأن نصف عمرها يطول عند المسنين
- أكثر تسبباً للنعاس والارتباك
- خطر السقوط والكسر - خاصة كسر عنق الفخذ
- تدهور الإدراك والذاكرة

التوصية:

- لا تصرف ديازيبام أو ألبرازولام للمسنين بدون إشراف طبي مشدد
- الجرعة لو لازم: نصف جرعة البالغ
- البدائل الأمان للأرق عند المسن:
- Melatonin 0.5-3 mg قبل النوم (الأمان)
- Trazodone 25-50 mg مضاد اكتئاب بتأثير منوم - أمان من (BZD)
- تحسين نظافة النوم: نفس ميعاد النوم والصحيان، بدون شاشات قبل النوم
- Zolpidem: أمان من BZD لكن لازم يتجنب في المسنين فوق 75 سنة

الحالة 2 — مسن يطلب مسكن للألم

المريض: "یا دكتور عندی 75 سنة وعندي ألم في ركبتي من الروماتيزم"
التوضیح:

NSAIDs عند المسن = خطر متضاعف:

- الكلى الأضعف تتأثر أكثر
- معدة أكثر هشاشة = قرحة وأنزفة بدون أعراض واضحة
- ضغط الدم قد يرتفع
- تفاعل مع أدوية الضغط والقلب الكثيرة التي يأخذها

التوصية:

- الخط الأول: باراسيتامول 500-1000 mg الآمن للمسن
- كريمات موضعية: Diclofenac gel، - Capsaicin cream آمن من الفموي
- لو ما اشتغلش: طبيب لتقييم
- NSAIDs لو ضرورية: بأقل جرعة ممكنة وأقصر فترة + حماية معدة ((Omeprazole
- تجنب Indomethacin للمسن - الأخطر على الكلى والمعدة والدماغ

الحالة 3 — مسنة تطلب دواء حساسية

المريضة: "يا دكتورة عندي 68 سنة وعايضة بيناديريل للحساسية زي ما كنت بخد"

التوضيح:

(Diphenhydramine بيناديريل) = مضاد هستامين جيل أول.

عند المسن يسبب:

- ارتباك وهلوسة
- احتباس بول (خاصة الرجال مع تضخم البروستاتا)
- إمساك شديد
- ارتفاع ضغط داخل العين (خطر في الجلوكوما)
- نعاس مفرط = خطر سقوط

التوصية:

- مضادات الهستامين الجيل الثاني دائماً للمسن:
- - Loratadine 10 mg الآمن وأقل نعاساً
- (10 mg Cetirizine أو 5 mg للكبر سنأ)
- - Fexofenadine الأقل في النعاس والآمن

الحالة 4 — مسن على ميترونيدازول يشكو من دوخة

المريض: "يا دكتور ابني عنده 80 سنة وبياخد فلاجيل وبيقع كثير"

التوضيح:

الميترونيذازول عند المسن:

- الجهاز العصبي أكثر حساسية
- قد يسبب ارتباك ودوخة أشد
- ممكن يزيد التشنجات في من لديهم تاريخ صرع

الأدوية التي تزيد خطر السقوط عند المسن:

الفئة	الأمثلة	آلية السقوط
بنزوديازيبينات	ديازيبام، ألبرازلام	نعاس وارتباك
منومات	زولبيديم	ارتباك ليلي
مضادات الاكتئاب	أميتريبتيلين	انخفاض ضغط عند الوقوف
حاصرات ألفا	تامسولوسين، دوكسازوسين	انخفاض ضغط عند الوقوف
مدرات البول	فيوروسيميد	جفاف وضعف
مضادات الهيستامين جيل 1	ديفينهيدرامين	نعاس وارتباك
أدوية باركنسون	ليفودوبا	انخفاض ضغط

التوصية:

- أي مسن يبدأ دواء جديد من هذه القائمة: أبلغ ذويه بخطر السقوط
- تعديلات منزلية ضرورية: مسكات في الحمام، إضاءة ليلية، إزالة السجاد المتحرك

الموضوع الثاني — Polypharmacy عند المسن

الحالة 5 — مسن يأخذ 7 أدوية

المريض: "يا دكتور معايا ورقة أدوية كتير أوي، ممكن تشرحلي"

الحقيقة:

- المسن فوق 65 سنة يأخذ في المتوسط 5-7 أدوية
- كل دواء إضافي = خطر تفاعل إضافي
- بعض الأعراض "من الكبر" هي في الواقع أعراض جانبية من الأدوية

الأعراض الشائعة التي قد تكون من الأدوية لا من المرض:

- الإمساك: مضادات الكولين، أوبيويدات، كالسيوم
- الدوخة: حاصرات ضغط، مدرات، مضادات اكتئاب
- الارتباك: بنزوديازيبينات، ديفنهيدرامين، بعض مضادات الصرع
- الإرهاق: حاصرات بيتا، بعض أدوية الضغط
- الغثيان: حديد، أدوية قلب كثيرة، مضادات حيوية
- سيلان اللعاب: أدوية باركنسون

توصيتك للمسن وذويه:

- احتفظوا بقائمة كاملة بكل الأدوية (اسم + جرعة + توقيت)
- أحضروها مع كل زيارة للطبيب
- لا تضيفوا أدوية جديدة بدون إبلاغ الطبيب

الموضوع الثالث — تعديلات الجرعات عند الكلى الضعيفة

الحالة 6 — مسن بكلى ضعيفة يطلب ميتفورمين

الحقيقة:

المسن فوق 70 سنة: وظيفة الكلى تتراجع تدريجياً حتى لو الكرياتينين "طبيعي" في التحليل.

(لأن كتلة العضلات تقل = كرياتينين أقل = eGFR مخفي)

أدوية تحتاج تعديل أو إيقاف عند ضعف الكلى:

الدواء	عند eGFR
Metformin	وقف عند أقل من 30، تقليل عند 30-45
(NSAIDs إيبوبروفين)	تجنب عند أقل من 30
Gabapentin	تقليل الجرعة
Digoxin	تقليل ومراقبة
Codeine	تجنب
بعض المضادات الحيوية ((Ciprofloxacin	تعديل الجرعة

التوصية:

- أي مسن فوق 70 سنة: اسأل عن آخر تحليل كرياتينين أو eGFR
- لو مجهول: افترض ضعف كلى جزئي واعمل حسابك

الموضوع الرابع — إدارة الأدوية اليومية للمسن

الحالة 7 — مسن ينسى جرعاته

المريض: "يا دكتور بابا عنده 78 سنة وبينسى ياخذ حبوه"

الحلول العملية:

- صندوق الأدوية الأسبوعي ((Pill Organizer - موجود بأشكال كثيرة
- تطبيق تذكير على الموبايل (أو موبايل أحد أبنائه)
- ربط الدواء بنشاط يومي (بعد الإفطار، قبل النوم)
- تحضير الأدوية الأسبوعية في مكان ثابت ومرئي

للذوي:

- صورة يومية للجرعات على WhatsApp
- تقسيم المسؤولية لو أكثر من مقيم مع المسن

ملخص سريع — قواعد الذهب للمسن

الموقف	القرار
مسن يطلب بيناديريل	أعطه لوراتادين أو سيتيريزين بدلاً منه
مسن يطلب ديازيبام للنوم	ميلاتونين أولاً - ترازودون ثانياً - طبيب
مسن يطلب إيبوبروفين	باراسيتامول أولاً + جل موضعي
مسن يبدأ دواء جديد	أبلغ ذويهِ بعلامات الأعراض الجانبية
مسن على +7 أدوية يشكو من أعراض جديدة	الأعراض الجديدة قد تكون من الأدوية
مسن بكلية ضعيفة + ميتفورمين	تحقق من eGFR أولاً

المبدأ الذهبي مع المسن:

أي عرض جديد = أول سؤال: أضاف دواء جديد مؤخراً؟

الدواء الآمن للشباب ممكن يكون خطراً للمسن.

السقوط في المسن = كسر = سرير = مضاعفات = وفاة في بعض الحالات.

ابدأ بنص الجرعة دائماً.

القسم الثالث — المريض المسن في الصيدلية · BetterDiagnosis الإصدار 0.1

الصيام والأدوية

[صورة غلاف توضيحية لفصل: الصيام والأدوية]

نسبة الأبعاد المقترحة: 16:9 • تُضاف لاحقاً

رمضان في مصر = 30 مليون سؤال في الصيدليات. المريض المزمّن خائف يصوم وخائف يفطر. شغلتك إنك تعرف الإجابة.

أولاً — المبدأ الأساسي

الصيام في رمضان يعني: لا أكل ولا شرب من الفجر للمغرب.
بالنسبة للأدوية:

- أي دواء فموي = يُفطر (رأي الجمهور الفقهي)
- الاستثناءات: ما يدخل تحت الجلد أو في الوريد أو لا يُمتص ولا يغذي
- الشغلة مش الدين - الشغلة إزاي تساعد المريض يكمل علاجه بأمان

الموضوع الأول — أدوية الأمراض المزمنة في رمضان

الحالة 1 — مريض ضغط يسأل عن وقت الدواء

المريض: "يا دكتور بياخد نورفاسك وليفينوبريل صباحاً، أعمل إيه في رمضان؟"
التوضيح:

أدوية الضغط المرة الواحدة يومياً: ممكن تنقل وقتها بسهولة.

الدواء	الوقت المقترح في رمضان
(Amlodipine نور فاسك)	عند الإفطار - نصف عمره طويل (35-50 ساعة)
Enalapril ,Lisinopril	عند الإفطار أو السحور
Valsartan ,Losartan	عند الإفطار
Metoprolol ,Atenolol	عند السحور - يغطي النهار
Bisoprolol	عند السحور
(Furosemide مدر)	عند الإفطار - لا عند السحور (هيمحيه يروح الحمام ليلاً)

للأدوية التي تؤخذ مرتين يومياً:

- جرعة عند الإفطار + جرعة عند السحور
- الفترة بينهما 8-12 ساعة - مقبول

التحذير:

- لا يوقف الأدوية طوال الشهر - خطر أزمة ضغط
- لو الضغط بيتغير كثير بعد تحويل المواعيد: يراجع الطبيب

الحالة 2 — مريض سكري نوع 2 على ميتفورمين

المريض: "يا دكتور بياخد ميتفورمين 500 mg x 3 يومياً، أعمل إيه في رمضان؟"

التوضيح:

الميتفورمين وحده لا يسبب هبوط سكر - آمن نسبياً في رمضان.

خطة رمضان للميتفورمين:

- من 3 جرعات يومية: جرعتان فقط (عند الإفطار وعند السحور)
- أو تحويل لـ Metformin XR بطيء الإطلاق) مرة واحدة عند الإفطار
- السكر يُراقب بانتظام خاصة في الأسبوع الأول

قياس السكر في رمضان:

- قياس السكر بالجهاز لا يُفطر (رأي الفقهاء)
- أوقات مهمة للقياس:

- قبل الإفطار بساعة (أو لو حس بأعراض هبوط)
- بعد الإفطار بساعتين
- قبل السحور

الحالة 3 — مريض سكري على سلفونيل يوريا

المريض: "يا دكتور بياخذ جليمبيريد 4 mg صباحاً، أعمل إيه؟"
التوضيح:

السلفونيل يوريا (جليمبيريد، جليبنكلاميد، جليكلازيد) = **الأخطر في رمضان**.
تحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين حتى لو مغيث أكل = هبوط سكر شديد أثناء الصيام.
قواعد السلفونيل يوريا في رمضان:

- الجرعة الصباحية تُنقل لوقت الإفطار (مش السحور)
- تُخفض الجرعة بـ 50% في رمضان - الطبيب يقرر
- جليكلازيد MR آمن من جليبنكلاميد في رمضان (تأثير أبطأ وأكثر تدرجاً)
- جليبنكلاميد: الأعلى خطراً - يُفضل تغييره في رمضان

علامات هبوط السكر التي تستدعي الإفطار فوراً:

- دوخة وتعرق بارد
- ارتجاف
- سكر أقل من 70 mg/dL
- سكر أقل من 90 مع أعراض

الشرع يجيز الإفطار لو:

- السكر أقل من 70
- المريض خائف على نفسه
- الطبيب نصحه بعدم الصيام

الحالة 4 — مريض سكري على أنسولين

المريض: "يا دكتور بياخذ أنسولين، ينفع يصوم؟"

التوضيح:

مريض الأنسولين يصوم لكن بإشراف طبي إلزامي.

البروتوكول العام:

نوع الأنسولين	التعديل في رمضان
(Lantus/Levemir طويل مرة)	نفس الجرعة أو تخفيض 20-30% - عند الإفطار
(Toujeo طويل مرة)	نفس الجرعة تقريباً - مستقر أكثر
(NPH متوسط مرتين)	الجرعة الأكبر عند الإفطار، الأصغر عند السحور
(Rapid سريع مع وجبات)	مع الإفطار ومع السحور فقط (لا جرعة نهار)
(Mixed مخلوط)	إعادة حساب كاملة مع الطبيب

قاعدة مهمة:

- لو السكر وصل 300 mg/dL أثناء الصيام: يفطر ويعالج
- لو السكر وصل 70 أو أقل: يفطر فوراً بسكر سريع

الحالة 5 — مريض قلب يسأل عن أدويته

المريض: "يا دكتور بياخذ أسبرين 100 وبلافيكس وليبيتور، أعمل إيه؟"

التوضيح:

هذه الأدوية لا مشكلة فيها في رمضان:

- Aspirin 100 mg: ينقل لوقت الإفطار أو السحور (مع أكل)
- (Clopidogrel بلافيكس): عند الإفطار
- (Atorvastatin ليبيتور): عند السحور (الكبد ينشط ليلاً)

تحذير الستاتين في رمضان:

- وقت السحور للستاتين مثالي - الكبد ينتج الكوليسترول أكثر أثناء الصيام والليل

الحالة 6 — مريض درقية يسأل عن الثيروكسين

المريض: "يا دكتور الثيروكسين بياخذه على معدة فاضية صباحاً، أعمل إيه؟"

التوضيح:

التيروكسين يحتاج معدة فاضية وساعة قبل أي أكل أو شرب.

خطة رمضان:

- الأفضل: قبل السحور بساعة (يصحى مبكر، يأخذ الدواء، ينتظر ساعة ثم يسحر)
- البديل الأسهل: عند النوم (بعد الإفطار بـ 4-5 ساعات على الأقل) - بعض الدراسات تؤكد فعاليته في هذا الوقت

الموضوع الثاني — أدوية تؤخذ مع الأكل

الحالة 7 — أدوية تحتاج أكل

المريض: "يا دكتور الدكتور قالى الدواء ده مع الأكل بالظبط"

جدول التوقيت في رمضان:

الدواء	التوقيت في رمضان
(Metformin مع أكل)	عند الإفطار وعند السحور
(Diclofenac ,Ibuprofen مع أكل)	عند الإفطار فقط - ما يُأخذش على معدة فاضية
حديد (أفضل على معدة فاضية)	بعد الإفطار بساعتين
(Augmentin مع أكل)	عند الإفطار وعند السحور
(Prednisone مع أكل)	عند الإفطار
Finasteride	أى وقت
معظم الفيتامينات	مع أى وجبة

الموضوع الثالث — أدوية تؤثر على الصيام

الحالة 8 — المريض الذي يُنصح بعدم الصيام

المريض: "الدكتور قالى ما أصومش، أنا مش عايز أفطر، فى حاجة أعملها؟"

الحالات التي يُنصح فيها طبيياً بعدم الصيام:

- مريض سكري غير منضبط (HbA1c فوق 9%)
- مريض سكري نوع 1 على أنسولين كثيف
- فشل كلوي أو كبدي شديد
- قصور قلبي حاد
- حامل مريضة
- مريض يأخذ أدوية لا يمكن تعديل مواعيدها

توصيتك:

- احترام رأي الطبيب وشجع المريض على اتباعه
- قوله: "الإسلام رخص الإفطار للمريض - ده مش ضعف، ده حكمة"
- اقترح عليه يتحدث مع شيخه أو دكتوراه مرة ثانية

الحالة 9 — ماذا يُفطر وماذا لا يُفطر؟

المريض: "يا دكتور قطرة العين في رمضان بتفطر؟"

جدول ما يُفطر وما لا يُفطر (حسب الرأي الفقهي الأكثر شيوعاً):

الأداة	الحكم
قطرة العين	لا تُفطر - رأي الجمهور
قطرة الأذن	لا تُفطر (لو الطبلة سليمة)
قطرة الأنف	فيها خلاف - الاحتياط تأجيلها
بخاخ الأنف (ستيرويد)	الغالب لا يُفطر - كمية ضئيلة جداً
بخاخ الربو ((Ventolin	فيه خلاف - الأحوط يُفطر، لكن الضرورة تجيزه
لصقة الجلد ((Transdermal	لا تُفطر
حقنة تحت الجلد (أنسولين)	لا تُفطر
حقنة عضل أو وريد	لا تُفطر لو لا تغذي
تحاميل شرجية	فيه خلاف
مضمضة بغرغرة	لا تُفطر لو ما بلعته
تحاليل دم	لا تُفطر
غسيل كلي	فيه خلاف - استشر شيخ

التوصية العملية:

- مريض الربو اللي محتاج بخاخ: الضرورة الطبية تجيز الاستخدام والصيام صحيح
- قوله: "استخدم بخاك لو احتجتّه - ربنا ما يكلفش نفساً إلا وسعها"

الحالة 10 — الإنهاك والجفاف في رمضان

المريض: "يا دكتور بحس بتعب وصلاص كل يوم في رمضان"

أسباب شائعة:

- الجفاف: خاصة في الصيف المصري الحار
- انخفاض الكافيين: للي بيشرّب قهوة كثير
- تغيير مواعيد النوم
- نقص السكر خاصة عصرًا

التوصية:

- شرب 8-10 أكواب ماء بين الإفطار والسحور
- تخفيف الكافيين تدريجياً قبل رمضان
- وجبة السحور مهمة - بروتين وكربوهيدرات بطيئة الامتصاص
- للصداع من الجفاف: باراسيتامول عند الإفطار + ماء كثير
- النوم بانتظام - حتى لو في رمضان

الموضوع الرابع — الفطور والأدوية التي تؤثر على الشهية

الحالة 11 — مريض يشكو من غثيان شديد بعد الإفطار من الأدوية

المريض: "يا دكتور لما بياخذ الأوجمنتين في رمضان بيحيه غثيان شديد عند الإفطار"

التوضيح:

الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام + أدوية تهيج المعدة = غثيان شديد.

الحلول:

- لا تبدأ بالدواء أول ما تفطر - كل شيئاً خفيفاً أولاً (تمر + ماء)
- بعد 15-20 دقيقة خذ الدواء مع الطعام
- Augmentin: يُؤخذ في منتصف وجبة الإفطار - مش أولها
- Lacteol أو بروبوتيك لتقليل اضطراب الأمعاء من المضاد
- لو الغثيان شديد: Metoclopramide (ماكسولون) 10 mg قبل الإفطار بـ 30 دقيقة

ملخص جدول مواعيد الأدوية الشائعة في رمضان

الدواء	الوقت المقترح
أملوديبين، لوسارتان	عند الإفطار
أتينولول، بيسوبرولول	عند السحور
فيوروسيميد (مدر)	عند الإفطار (مش السحور)
ميثفورمين	عند الإفطار + السحور
جليمبيريد	عند الإفطار فقط بجرعة منخفضة
أتورفاستاتين، روسوفاستاتين	عند السحور
أسبرين 100	عند الإفطار
بلافيكس	عند الإفطار
ثيروكسين	قبل السحور بساعة أو عند النوم
أوميرازول	قبل الإفطار بـ 30 دقيقة
مكملات الحديد	بعد الإفطار بساعة
فيتامين D	مع أى وجبة
أنسولين لانتوس	عند الإفطار (مع تخفيض جرعة)
أنسولين سريع	مع وجبة الإفطار ومع السحور فقط

المبدأ الذهبي في رمضان:

الأدوية المرة الواحدة يومياً: انقلها للإفطار أو السحور حسب النوع.

الأدوية مرتبتين: إفطار + سحور.

السلفونيل يوريا والأنسولين: أخطر ما في رمضان -راقب السكر يومياً.

الصيام مع المرض المزمن يحتاج خطة من الطبيب قبل رمضان بأسبوعين.

لا تنسى: الشريعة الإسلامية رفعت الحرج عن المريض.

